

Buku Ajar

ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN MENYUSUI

PEMANTAUAN, KONSELING, DAN KOMPLIKASI

Karnilan Lestari Ningsi Sam • Wiwik Puspita Dewi • Dini Ria Oktavia
Erma Puspita Sari • Rini Kristiyanti

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



BUKU AJAR

ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN MENYUSUI: PEMANTAUAN, KONSELING, DAN KOMPLIKASI

Penulis:

Karnilan Lestari Ningsi Sam, S.ST., M.Keb.

Wiwik Puspita Dewi, S.SiT., M.Keb.

Bdn. Dini Ria Oktavia, S.ST., M.Keb.

Erma Puspita Sari, SST., M.Kes.

Bdn. Rini Kristiyanti, SSi.T., M.Keb.

Editor:

Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



**Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui:
Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi**

Penulis:

Karnilan Lestari Ningsi Sam, S.ST., M.Keb.
Wiwik Puspita Dewi, S.SiT., M.Keb.
Bdn. Dini Ria Oktavia, S.ST., M.Keb.
Erma Puspita Sari, SST., M.Kes.
Bdn. Rini Kristiyanti, SSi.T., M.Keb.

Editor:

Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-68-8

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi dapat disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami asuhan pada masa nifas dan menyusui secara komprehensif. Buku ini dirancang untuk membantu peserta didik menguasai konsep dasar asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui, memahami perubahan fisiologis dan psikologis ibu nifas, serta mengenali berbagai tanda bahaya yang memerlukan deteksi dini dan penanganan tepat.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui, adaptasi fisiologis dan psikologis ibu nifas, involusi uterus, lokia, perubahan emosi, hingga pemantauan masa nifas terjadwal melalui kunjungan nifas, parameter klinis, serta deteksi dini risiko. Selain itu, buku ini juga membahas fisiologi laktasi, produksi ASI, refleks menyusui, teknik menyusui yang benar, pelekatan efektif, serta konseling menyusui dalam menghadapi masalah umum seperti puting lecet, bendungan ASI, dan mastitis. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran berbasis capaian kompetensi, rubrik penilaian, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka untuk memperkuat proses belajar yang terarah dan aplikatif.

Penulis berharap buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan klinis, serta kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DAN MENYUSUI	1
A. Teori Dasar.....	2
B. Aktivitas 1 — Knows How	4
C. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	8
D. Portofolio	14
E. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	20
F. Rangkuman Materi	23
G. Daftar Pustaka	24
BAB 2 ADAPTASI FISILOGIS DAN PSIKOLOGIS IBU NIFAS, INVOLUSI, LOKIA DAN PERUBAHAN EMOSI	27
A. Adaptasi Fisiologis.....	28
B. Adaptasi Psikologis.....	35
C. Tanda Bahaya Masa Nifas	38
D. Aktivitas 1 — Knows How	39
E. Aktivitas 2 — Shows How	39
F. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	44
G. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	57
H. Rangkuman Materi	59
I. Daftar Pustaka	60
BAB 3 PEMANTAUAN MASA NIFAS TERJADWAL– KUNJUNGAN NIFAS, PARAMETER KLINIS, DAN DETEKSI DINI RISIKO	63
A. Konsep Pemantauan Masa Nifas.....	66
B. Jadwal Kunjungan Nifas Terstandar	67
C. Parameter Klinis Pemantauan Ibu Nifas.....	70
D. Pemantauan Bayi Baru Lahir pada Kunjungan Nifas	72
E. Tanda Bahaya Masa Nifas	75
F. Deteksi Dini Risiko dan Komplikasi Masa Nifas	77
G. Aktivitas 1 — Knows How	80
H. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	84

I. Portofolio	90
J. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	93
K. Rangkuman Materi	96
L. Daftar Pustaka	97

BAB 4 LAKTASI DAN PRODUKSI ASI: FISILOGI, TEKNIK MENYUSUI, DAN PELEKATAN EFEKTIF99

A. Fisiologi Laktasi.....	101
B. Reflek Menyusui	102
C. Teknik Menyusui yang Benar	103
D. Aktivitas 1 — Knows How	105
E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	109
F. Portofolio	118
G. Ringkasan.....	125
H. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	126
I. Daftar Pustaka	128

BAB 5 KONSELING MENYUSUI DAN PEMECAHAN MASALAH: PUTING LECET, BENDUNGAN ASI, DAN MASTITIS129

A. Puting Susu Lecet (Abraded or Cracked Nipple)	137
B. Bendungan ASI atau Payudara Bengkak (Breast Engorgement).....	138
C. Mastitis.....	142
D. Aktivitas 1 — Knows How	143
E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	148
F. Portofolio	153
G. Rangkuman Materi	158
H. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	160
I. Daftar Pustaka	162

PROFIL PENULIS163

BAB 1

KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DAN MENYUSUI

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi dalam asuhan nifas & menyusui	CPMK-5,6,7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning pada kondisi nifas dan laktasi	CPMK-2,4,5,6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan nifas dan menyusui secara komprehensif	CPMK-3,4,5,6
CPL-6	Mengelola asuhan berbasis evidence pada nifas & menyusui	CPMK-1,4,5,7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep nifas dan fisiologi laktasi
CPMK-2	Mengidentifikasi perubahan fisiologis ibu nifas dan produksi ASI
CPMK-3	Melakukan teknik menyusui dan pelekatan efektif
CPMK-4	Menganalisis masalah menyusui dan penatalaksanaannya
CPMK-5	Mengoptimalkan keberhasilan menyusui melalui konseling
CPMK-6	Melakukan komunikasi terapeutik pada ibu nifas
CPMK-7	Mendokumentasikan asuhan nifas dan menyusui

Mapping CPMK per Subbab	
Fisiologi laktasi	CPMK 1,2
Produksi ASI	CPMK 2
Teknik menyusui	CPMK 3
Pelekatan efektif	CPMK 3
Masalah menyusui	CPMK 4
Konseling menyusui	CPMK 5,6
Dokumentasi asuhan	CPMK 7

Uraian Materi

A. Teori Dasar

Masa nifas atau puerperium merupakan periode yang dimulai segera setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika organ-organ reproduksi ibu kembali mendekati keadaan sebelum kehamilan. Secara umum, masa ini berlangsung selama kurang lebih enam minggu (42 hari), meskipun pada beberapa aspek fisiologis dan psikologis, proses pemulihan dapat berlangsung lebih lama. Dalam perspektif kebidanan modern, masa nifas tidak hanya dipandang sebagai proses pemulihan biologis semata, tetapi juga sebagai fase transisi yang kompleks, melibatkan interaksi antara perubahan fisiologis, adaptasi psikologis, serta dinamika sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, pendekatan asuhan kebidanan pada masa nifas harus bersifat holistik, mencakup aspek bio-psiko-sosial-spiritual. Menurut pedoman World Health Organization (WHO), masa nifas merupakan periode yang sangat kritis karena sebagian besar komplikasi yang berkontribusi terhadap kematian ibu terjadi pada fase ini, khususnya dalam 24 jam pertama postpartum. Hal ini menegaskan bahwa kualitas asuhan kebidanan pada masa nifas memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu.

Asuhan kebidanan masa nifas adalah serangkaian tindakan profesional yang diberikan oleh bidan kepada ibu setelah persalinan, yang bertujuan untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara fisiologis, mendeteksi secara dini adanya komplikasi, serta mendukung keberhasilan laktasi dan adaptasi peran sebagai ibu. Asuhan ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Dalam praktiknya, bidan berperan sebagai: 1. Pemberi asuhan klinis; 2. Edukator kesehatan; 3. Konselor laktasi; 4. Advokat keselamatan ibu dan bayi. Pendekatan asuhan kebidanan masa nifas harus berlandaskan pada prinsip *evidence-based practice*, yaitu penggunaan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, dikombinasikan dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien.

Tujuan utama asuhan kebidanan masa nifas adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi. Secara lebih spesifik, tujuan tersebut mencakup memastikan bahwa proses involusi uterus berlangsung secara normal, mencegah terjadinya komplikasi seperti perdarahan postpartum dan infeksi, serta mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Selain itu, asuhan nifas juga bertujuan untuk membantu ibu beradaptasi secara psikologis terhadap peran barunya. Proses menjadi seorang ibu sering kali disertai dengan perubahan emosi yang signifikan, sehingga dukungan dari tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mencegah gangguan mental seperti *baby blues* atau depresi postpartum.

Tidak kalah penting, asuhan nifas juga mencakup edukasi kesehatan yang berkelanjutan, termasuk mengenai perawatan diri, tanda bahaya, serta perencanaan keluarga (KB pascapersalinan). Dengan demikian, asuhan nifas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup ibu dan keluarga secara keseluruhan. Asuhan nifas merupakan bagian dari continuum of care, yaitu kesinambungan pelayanan dari: Antenatal care, Intrapartum care, Postpartum care. Pendekatan ini menekankan bahwa kualitas asuhan nifas tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan sebelumnya.

Menyusui merupakan proses fisiologis yang melibatkan produksi dan pengeluaran air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi. Proses ini diatur oleh interaksi hormon prolaktin dan oksitosin, yang masing-masing berperan dalam produksi dan pengeluaran ASI. Namun, keberhasilan menyusui tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, serta kebijakan kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Menurut WHO dan UNICEF, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan merupakan intervensi yang paling efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup bayi. ASI tidak hanya menyediakan nutrisi yang optimal, tetapi juga mengandung antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Dalam konteks asuhan kebidanan, bidan memiliki tanggung jawab untuk: memfasilitasi inisiasi menyusui dini (IMD), memberikan edukasi teknik menyusui yang benar, mengatasi masalah laktasi, memberikan dukungan emosional kepada ibu.

Ruang lingkup asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui mencakup seluruh proses pelayanan yang diberikan kepada ibu sejak segera setelah persalinan hingga akhir masa nifas. Asuhan ini meliputi pengkajian komprehensif, penegakan diagnosis kebidanan, perencanaan asuhan, implementasi tindakan, serta evaluasi hasil asuhan. Pengkajian dilakukan secara menyeluruh, mencakup kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan ibu. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi apakah kondisi ibu berada dalam batas normal atau terdapat masalah yang memerlukan intervensi. Dalam tahap implementasi, bidan memberikan berbagai tindakan, seperti pemeriksaan fisik, edukasi kesehatan, konseling menyusui, serta intervensi terhadap masalah yang ditemukan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan asuhan telah tercapai.

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan prinsip utama dalam pemberian asuhan kebidanan. Dalam konteks masa nifas, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting karena kondisi ibu yang masih rentan terhadap komplikasi.

Prinsip keselamatan pasien mencakup beberapa aspek, antara lain: identifikasi pasien secara tepat, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, pencegahan infeksi melalui praktik kebersihan yang baik, deteksi dini tanda bahaya, respons cepat terhadap kondisi emergensi. Kegagalan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk keterlambatan penanganan komplikasi yang berpotensi mengancam jiwa ibu.

Bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan asuhan pada masa nifas dan menyusui. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga mencakup edukasi, konseling, dan advokasi. Sebagai tenaga kesehatan yang berada paling dekat dengan masyarakat, bidan diharapkan mampu memberikan asuhan yang berkesinambungan, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan ibu. Bidan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perawatan masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Dalam praktik profesional, bidan harus mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan asuhan yang aman dan efektif. Hal ini sejalan dengan standar kompetensi bidan yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan lembaga pendidikan.

Secara keseluruhan, masa nifas dan menyusui merupakan periode yang sangat penting dalam siklus kehidupan seorang perempuan. Asuhan kebidanan yang diberikan pada fase ini harus bersifat komprehensif, berkesinambungan, dan berbasis evidence-based. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar masa nifas dan menyusui akan menjadi landasan bagi bidan dalam memberikan asuhan yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi dapat ditekan, dan kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

B. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang perempuan usia 25 tahun, P1A0, 8 jam postpartum normal di PMB. Ibu tampak lelah, belum menyusui karena merasa ASI belum keluar. Pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, nadi 90x/menit, TFU setinggi pusat, lochea rubra.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa kondisi ibu berdasarkan konsep masa nifas?
2. Apakah kondisi tersebut fisiologis? Jelaskan!
3. Apa prioritas asuhan bidan?
4. Risiko apa yang harus diwaspadai?
5. Apa edukasi awal yang harus diberikan?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Teknik Menyusui yang Baik dan Benar pada Ibu Nifas dengan Puting Lecet
3	Kasus	Postpartum 8 jam dengan keluhan puting lecet dan nyeri saat menyusui
4	Tujuan	Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian ibu nifas, analisis masalah laktasi, serta pemberian edukasi teknik menyusui yang benar secara aman, efektif, dan profesional, sehingga peserta mampu menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas berbasis evidence-based dan berorientasi pada keselamatan pasien.
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 25 tahun, P1A0, 8 jam postpartum normal di PMB. Ibu mengeluh nyeri pada puting saat menyusui. Bayi tampak sering melepas puting saat menyusu. Pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, nadi 88x/menit, TFU setinggi pusat, lochea rubra, puting tampak lecet. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 3. Berikan KIE/konseling singkat kepada ibu
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: a. Actual mark (0/1/2/3) b. Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS ➤ Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai skenario. ➤ Jika peserta melakukan pemeriksaan payudara, penguji memberikan data: ▪ Puting tampak lecet kemerahan ▪ Tidak ada tanda infeksi ➤ Tindakan yang diharapkan: ▪ Menilai kondisi ibu dan payudara ▪ Menjelaskan penyebab puting lecet ▪ Mengajarkan posisi menyusui yang benar ▪ Mendemonstrasikan perlekatan (latch-on) ▪ Memberikan edukasi perawatan puting ▪ Memberikan dukungan emosional ➤ Penguji tidak melakukan interupsi. ➤ Data tambahan hanya diberikan jika diminta. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.

No.	Komponen	Isi
		2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu nifas 8 jam postpartum. 2. PS tampak lelah dan mengeluh nyeri saat menyusui. 3. PS tampak khawatir dan bingung menyusui bayinya. 4. Bila peserta memberikan edukasi, PS merespons kooperatif. 5. Bila diberikan dukungan, PS tampak lebih tenang
9	Dialog PS	Peserta: Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan membantu ibu, apakah bersedia? PS: Iya, Bu. Peserta: Apa keluhan ibu? PS: Puting saya sakit sekali saat menyusui, Bu. Peserta: Sejak kapan? PS: Sejak tadi pagi, sejak mulai menyusui. Peserta: Apakah bayi sulit menyusu? PS: Iya, sering lepas-lepas. Peserta: Apakah ada luka? PS: Iya, seperti lecet. Peserta: Baik Bu, saya akan bantu perbaiki cara menyusui. PS: Iya, Bu, saya ingin bisa menyusui dengan benar. Catatan: Jawaban lain normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain
10	Kebutuhan manikin	➤ Phantom payudara ➤ Boneka bayi (untuk simulasi menyusui)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: ➤ Menyiapkan dan merapikan alat ➤ Memastikan station siap ➤ Mengganti lembar instruksi bila diperlukan

No.	Komponen	Isi
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom payudara — 1 3. Boneka bayi — 1 4. Tensimeter — 1 5. Stetoskop — 1 6. Sarung tangan — 1 pasang 7. Handrub — 1 8. Kain penutup — 1 9. Tisu — 1 10. Leaflet edukasi menyusui — 1 11. Lembar jawaban — 1 12. Pena — 1
13	Penulis	
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Standar profesi bidan</i> . 2. World Health Organization. (2022). <i>Postnatal care recommendations</i> . 3. United Nations Children's Fund. (2020). <i>Infant feeding counselling</i> . 4. Academy of Breastfeeding Medicine. (2016). <i>Clinical protocol nipple pain</i> .

C. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (nyeri puting, kesulitan menyusui)	0–3	—
2. Riwayat menyusui (sejak kapan menyusui, frekuensi, durasi, kesulitan bayi)	0–3	—
3. Riwayat keluhan payudara (lecet, nyeri, bengkak, ASI keluar/tidak)	0–3	—
4. Respons bayi saat menyusu (menangis, sering lepas, tidak puas)	0–3	—
5. Riwayat obstetri (GPA, jenis persalinan, waktu postpartum)	0–3	—

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
6. Riwayat kesehatan ibu (penyakit, obat-obatan, alergi)	0–3	___
7. Riwayat edukasi menyusui sebelumnya	0–3	___
8. Aktivitas harian (istirahat, nutrisi, dukungan keluarga)	0–3	___

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah	0–3	___
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan	0–3	___
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan	0–3	___
d. Menjaga privasi ibu	0–3	___
e. Mencuci tangan/hand hygiene	0–3	___
f. Menyiapkan alat yang diperlukan (phantom/bayi/alat edukasi)	0–3	___
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum ibu nifas	0–3	___
b. Menilai tanda vital ibu	0–3	___
c. Menilai kondisi payudara (bentuk, bengkak/tidak)	0–3	___
d. Menilai kondisi puting (lecet, kemerahan, luka)	0–3	___
e. Mengkaji keluhan ibu saat menyusui	0–3	___
f. Mengobservasi teknik menyusui ibu	0–3	___
g. Mengobservasi perlekatan bayi (latch-on)	0–3	___
h. Menyimpulkan masalah puting lecet akibat teknik menyusui tidak tepat	0–3	___
i. Menjelaskan penyebab puting lecet kepada ibu	0–3	___
j. Mendemonstrasikan posisi menyusui yang benar	0–3	___

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
k. Mendemonstrasikan teknik perlekatan yang tepat	0–3	___
l. Mengajarkan cara melepas isapan bayi dengan benar	0–3	___
m. Memberikan edukasi perawatan puting lecet	0–3	___
n. Memberikan dukungan emosional kepada ibu	0–3	___
o. Melakukan evaluasi ulang respon ibu dan bayi	0–3	___
p. Mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi/rujukan bila ada tanda infeksi	0–3	___
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan dan rencana lanjutan	0–3	___
b. Mendokumentasikan hasil asuhan	0–3	___
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat	0–3	___

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta melakukan **15–19 langkah dengan tepat dan sistematis**
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah dengan tepat**
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah dengan tepat**
- **0** = Tidak melakukan / tidak tepat

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam	0–3	___
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan (puting lecet & penyebabnya) dengan bahasa sederhana	0–3	___
3. Menjelaskan teknik menyusui yang benar	0–3	___
4. Menjelaskan perawatan puting lecet	0–3	___
5. Menenangkan ibu dan memberikan dukungan emosional	0–3	___
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas	0–3	___

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan tindakan secara sistematis	0-3	___
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien	0-3	___
3. Responsif terhadap kondisi dan kenyamanan ibu	0-3	___
4. Komunikasi jelas, tenang, dan informatif	0-3	___
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu	0-3	___

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1-3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas dengan Putting Lecet dan Konseling Teknik Menyusui yang Baik dan Benar

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Putting Lecet dan Konseling Menyusui
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural klinik mahasiswa. Penilai (pembimbing klinik/dosen) mengamati secara langsung tindakan yang dilakukan mahasiswa pada pasien nyata, kemudian memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai. Domain penilaian meliputi kemampuan pengkajian, komunikasi terapeutik, keterampilan teknis, edukasi, profesionalisme, serta keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian pada ibu nifas dengan putting lecet, mengidentifikasi penyebab masalah laktasi, serta memberikan konseling teknik menyusui yang benar. Pembimbing juga menilai bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan ibu, menunjukkan empati, dan memastikan kenyamanan pasien selama proses konseling.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan pada masalah laktasi secara komprehensif, khususnya dalam mengidentifikasi penyebab putting lecet dan memberikan edukasi teknik menyusui yang tepat, aman, dan efektif. Pendekatan harus berbasis evidence-based, woman-centered care, serta mendukung keberhasilan ASI eksklusif.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pemahamannya tentang putting lecet, tetapi dari kemampuannya melakukan pengkajian menyeluruh, mengidentifikasi kesalahan teknik menyusui, memberikan edukasi yang tepat, serta membangun kepercayaan ibu agar tetap melanjutkan menyusui.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya dalam penanganan masalah laktasi. Kasus mencakup identifikasi penyebab putting lecet, evaluasi teknik menyusui, serta intervensi edukatif. WHO dan UNICEF menekankan bahwa teknik menyusui	Seorang ibu usia 28 tahun, P1A0, hari ke-5 postpartum, datang ke puskesmas dengan keluhan putting susu lecet dan nyeri saat menyusui. Bayi sering menangis setelah menyusui. Hasil observasi menunjukkan posisi menyusui kurang tepat dan perlekatan bayi tidak optimal. Tidak ada tanda infeksi sistemik.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
	yang benar merupakan kunci utama keberhasilan ASI eksklusif.	
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan tindakan nyata, bukan hanya diskusi. Pada topik ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian kondisi ibu, mengidentifikasi penyebab puting lecet, mengobservasi teknik menyusui, serta memberikan konseling dan demonstrasi teknik menyusui yang benar.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, menggali keluhan ibu, melakukan observasi teknik menyusui, mengidentifikasi kesalahan perlekatan, kemudian memberikan edukasi tentang posisi menyusui yang benar, perlekatan (latch-on), serta cara merawat puting lecet. Mahasiswa juga memberikan dukungan emosional agar ibu tetap percaya diri menyusui.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan pengkajian, ketepatan diagnosis, keterampilan edukasi, komunikasi terapeutik, profesionalisme, serta keselamatan pasien. Dalam konteks laktasi, penilaian juga mencakup kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi teknik menyusui yang salah dan memberikan solusi yang tepat.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan nyeri puting dengan kesalahan teknik menyusui, mampu memberikan edukasi yang mudah dipahami, serta mampu membangun hubungan yang suportif dengan ibu.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah performa nyata mahasiswa dalam memberikan asuhan. Pada kasus laktasi, WHO menekankan pentingnya edukasi teknik menyusui yang benar sebagai intervensi utama.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengenali masalah dengan cepat, memberikan edukasi secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memastikan ibu memahami dan mampu mempraktikkan teknik menyusui yang benar.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai. Umpan balik mencakup aspek yang sudah baik serta area yang perlu ditingkatkan,	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan empati, tetapi perlu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
	dengan tujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan.	meningkatkan keterampilan demonstrasi teknik menyusui atau memperjelas penjelasan mengenai perlekatan yang benar.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Penilaian didasarkan pada ketepatan tindakan, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan klinis.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan pengkajian, edukasi, dan konseling secara tepat dan aman. Dinyatakan perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Dinyatakan remedial jika tidak mampu mengidentifikasi masalah atau memberikan edukasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS merupakan metode penilaian yang menunjukkan capaian pembelajaran pada level does dalam piramida Miller, karena mahasiswa dinilai berdasarkan performa nyata di lapangan.	Pada kasus ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori menyusui, tetapi mampu menerapkan konseling teknik menyusui secara langsung pada pasien dengan pendekatan profesional, empatik, dan evidence-based.

D. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Kebidanan Masa Nifas Putting Lecet dan konseling teknik menyusui yang baik dan benar

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Putting Lecet dan Konseling Menyusui
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio berfungsi sebagai alat untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya berdasarkan satu kali evaluasi.	Pada topik putting lecet dan konseling menyusui, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian masalah laktasi, mengidentifikasi penyebab putting lecet, memberikan edukasi teknik menyusui yang benar, serta menunjukkan peningkatan kemampuan setelah mendapatkan umpan balik dari dosen atau pembimbing klinik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan untuk mendokumentasikan proses belajar mahasiswa, capaian kompetensi klinik, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan yang dilakukan selama praktik kebidanan.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu nifas dengan putting lecet, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya dalam memberikan konseling menyusui berkembang setelah menerima masukan terkait komunikasi, teknik edukasi, dan demonstrasi perlekatan bayi.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan bagian penting dari portofolio karena memberikan bukti keterampilan mahasiswa secara terstruktur di laboratorium (OSCE) dan performa nyata di lahan praktik (DOPS).	OSCE memuat hasil ujian keterampilan konseling teknik menyusui dan demonstrasi perlekatan yang benar. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian ibu nifas dengan putting lecet dan memberikan edukasi menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, meliputi data	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu nifas hari ke-5 postpartum dengan keluhan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
	subjektif dan objektif, masalah kebidanan, intervensi yang dilakukan, serta hasil asuhan.	puting lecet, hasil observasi teknik menyusui yang kurang tepat, intervensi berupa konseling teknik menyusui dan perawatan puting, serta hasil berupa berkurangnya nyeri dan peningkatan kenyamanan ibu saat menyusui.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, serta merencanakan langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan teknik menyusui dapat menyebabkan trauma pada puting dan risiko kegagalan pemberian ASI. Mahasiswa juga menyadari pentingnya edukasi yang tepat dan komunikasi yang efektif untuk mencegah komplikasi lebih lanjut serta memastikan keberhasilan menyusui.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen merupakan bagian penting dalam portofolio untuk menunjukkan pembinaan dan pengembangan kompetensi mahasiswa.	CI memberikan umpan balik bahwa mahasiswa sudah mampu membangun komunikasi yang baik dan empatik dengan ibu, tetapi masih perlu meningkatkan keterampilan demonstrasi teknik perlekatan bayi dan memperjelas edukasi agar lebih mudah dipahami oleh pasien.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat longitudinal, yaitu dikumpulkan secara berulang dan berkesinambungan. Penilaian tidak hanya berdasarkan satu pengalaman, tetapi konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi klinik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari satu kasus puting lecet, tetapi dari beberapa pengalaman praktik yang menunjukkan bahwa ia mampu secara konsisten mengidentifikasi masalah laktasi, memberikan edukasi menyusui, dan membangun hubungan terapeutik dengan pasien.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kualitas performa dalam berbagai kesempatan praktik dan waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan konseling menyusui, memperbaiki teknik perlekatan bayi, dan memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan ibu.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tercermin dalam performa mahasiswa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada kasus puting lecet, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori menyusui, tetapi mampu menerapkan konseling teknik menyusui secara nyata, empatik, dan evidence-based dalam praktik kebidanan.

Tabel. Case Report pada Asuhan kebidanan mas nifas: Putting lecet dan konseling Teknik menyusui yang baik dan benar

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis mengenai satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis berdasarkan evidence-based practice.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu nifas hari ke-5 postpartum yang mengalami puting lecet akibat teknik menyusui yang tidak tepat, disertai keluhan nyeri saat menyusui dan bayi tampak belum menyusu secara efektif.
Tujuan	Case report bertujuan untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah kebidanan, perencanaan asuhan,	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu nifas, tetapi juga menjelaskan penyebab puting lecet, kesalahan teknik menyusui, intervensi berupa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
	implementasi tindakan, serta evaluasi hasil secara sistematis.	konseling dan demonstrasi teknik menyusui, serta perkembangan kondisi ibu setelah diberikan edukasi.
Isi laporan	Isi case report meliputi identitas pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis kebidanan, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, serta pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan keluhan nyeri pada puting, hasil observasi teknik menyusui yang tidak tepat (perlekatan kurang), diagnosis puting lecet akibat teknik menyusui tidak efektif, intervensi berupa konseling teknik menyusui dan perawatan puting, serta hasil berupa penurunan nyeri dan peningkatan kenyamanan ibu saat menyusui.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, serta kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan nyeri dengan kesalahan teknik menyusui, serta mampu memberikan solusi yang tepat melalui edukasi dan demonstrasi teknik menyusui yang benar.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, serta kebiasaan berpikir reflektif dalam praktik kebidanan.	Dari kasus puting lecet, mahasiswa belajar bahwa teknik menyusui yang benar merupakan faktor utama dalam mencegah masalah laktasi dan keberhasilan ASI eksklusif.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep menyusui, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
		kebidanan secara komprehensif dan berbasis evidence.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan kebidanan mas nifas: Putting lecet dan konseling Teknik menyusui yang baik dan benar

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, serta merencanakan langkah pencegahan dalam praktik kebidanan.	Pada kasus puting lecet, mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan teknik menyusui dapat menyebabkan trauma puting, nyeri, dan berpotensi mengganggu keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari setiap tindakan kebidanan, termasuk dalam asuhan nifas dan laktasi.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan dalam edukasi atau kurangnya keterampilan dalam mengajarkan teknik menyusui dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk risiko infeksi dan kegagalan menyusui.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, serta pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah trauma puting yang berulang, nyeri yang menyebabkan ibu menghentikan menyusui, serta kurangnya asupan ASI pada bayi akibat perlekatan yang tidak efektif.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa diharapkan mampu mengenali berbagai risiko yang dapat membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain puting lecet berulang, infeksi pada puting, kegagalan pemberian ASI eksklusif, serta gangguan tumbuh kembang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Puting Lecet dan Konseling Menyusui
		bayi akibat asupan ASI yang tidak adekuat.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mencegah risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya edukasi teknik menyusui yang benar, demonstrasi perlekatan bayi, pemantauan kondisi puting, serta pemberian dukungan emosional agar ibu tetap termotivasi menyusui.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi praktik di masa depan.	Mahasiswa menyadari bahwa edukasi menyusui yang efektif dan komunikasi yang empatik merupakan kunci dalam mencegah masalah laktasi dan meningkatkan keberhasilan asuhan kebidanan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan klinik, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

E. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Kebidanan Masa Nifas: Putting lecet dan konseling teknik menyusui

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri puting yang sangat hebat hingga ibu tidak mampu menyusui	Trauma puting berat yang dapat mengganggu proses menyusui	Evaluasi teknik menyusui, berikan intervensi segera, pertimbangkan kolaborasi
Puting lecet disertai perdarahan atau luka terbuka	Risiko infeksi lokal pada payudara	Lakukan perawatan luka, edukasi kebersihan, dan kolaborasi bila diperlukan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tanda infeksi (kemerahan, bengkak, nyeri, demam)	Mengarah pada mastitis atau infeksi payudara	Rujuk atau kolaborasi untuk penanganan lebih lanjut
Bayi tidak mau menyusui atau sering menangis setelah menyusui	Kemungkinan asupan ASI tidak adekuat akibat perlekatan tidak efektif	Evaluasi teknik menyusui, perbaiki perlekatan, pantau tumbuh kembang bayi
Produksi ASI menurun	Stimulasi menyusui tidak optimal	Tingkatkan frekuensi menyusui, edukasi teknik yang benar
Ibu menunjukkan tanda stres atau kelelahan emosional	Risiko gangguan psikologis dan kegagalan menyusui	Berikan dukungan emosional, konseling, dan libatkan keluarga
Puting tidak membaik setelah intervensi awal	Kemungkinan masalah yang lebih kompleks	Lakukan evaluasi lanjutan dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain
Ibu menghentikan menyusui	Risiko kegagalan ASI eksklusif	Konseling intensif dan dukungan berkelanjutan
Kurangnya pemahaman ibu tentang teknik menyusui	Faktor utama terjadinya masalah laktasi	Edukasi ulang secara bertahap dan demonstratif

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Konsep dasar Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Menjelaskan konsep masa nifas dan proses laktasi	☐	☐	
2	Menjelaskan penyebab puting lecet pada ibu menyusui	☐	☐	
3	Melakukan pengkajian kondisi ibu nifas secara komprehensif	☐	☐	
4	Mengkaji kondisi payudara dan puting secara tepat	☐	☐	
5	Mengidentifikasi masalah puting lecet berdasarkan data klinis	☐	☐	
6	Menganalisis penyebab puting lecet (teknik menyusui, perlekatan, posisi)	☐	☐	
7	Menjelaskan teknik menyusui yang benar secara teoritis	☐	☐	
8	Mendemonstrasikan posisi menyusui yang benar	☐	☐	
9	Mendemonstrasikan teknik perlekatan (latch-on) yang tepat	☐	☐	
10	Memberikan konseling menyusui dengan komunikasi terapeutik	☐	☐	
11	Memberikan edukasi perawatan puting lecet	☐	☐	
12	Memberikan dukungan emosional kepada ibu menyusui	☐	☐	
13	Mengidentifikasi tanda bahaya (infeksi, mastitis, dll)	☐	☐	
14	Menerapkan prinsip patient safety dalam asuhan nifas	☐	☐	
15	Melakukan evaluasi hasil edukasi dan respon ibu	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Mendokumentasikan asuhan kebidanan secara lengkap dan sistematis	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

F. Rangkuman Materi

Asuhan Kebidanan Masa Nifas: Puting Lecet dan Konseling Teknik Menyusui

Masa nifas merupakan periode adaptasi fisiologis dan psikologis setelah persalinan yang berlangsung sekitar 6 minggu. Pada periode ini, salah satu fokus utama asuhan kebidanan adalah keberhasilan menyusui, karena pemberian ASI memiliki peran penting dalam kesehatan ibu dan bayi. Namun, dalam praktik klinik, sering dijumpai masalah laktasi, salah satunya adalah puting lecet (nipple trauma), yang dapat mengganggu proses menyusui dan berpotensi menyebabkan kegagalan ASI eksklusif.

Puting lecet umumnya disebabkan oleh teknik menyusui yang tidak tepat, terutama kesalahan dalam posisi dan perlekatan bayi (latch-on). Perlekatan yang tidak optimal menyebabkan tekanan berlebih pada puting, sehingga menimbulkan nyeri, luka, bahkan perdarahan. Kondisi ini sering membuat ibu enggan menyusui, sehingga berdampak pada penurunan frekuensi menyusui, berkurangnya produksi ASI, serta risiko bayi tidak mendapatkan asupan nutrisi yang adekuat.

Dalam praktik kebidanan, bidan harus mampu melakukan pengkajian menyeluruh pada ibu nifas, tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga pada proses menyusui. Pengkajian meliputi keluhan ibu, kondisi payudara dan puting, teknik menyusui, serta respons bayi saat menyusu. WHO dan UNICEF menekankan bahwa edukasi teknik menyusui yang benar merupakan intervensi utama dalam mengatasi masalah laktasi, termasuk puting lecet.

Tindakan utama bidan pada kasus puting lecet berfokus pada perbaikan teknik menyusui melalui konseling dan demonstrasi langsung. Langkah penting meliputi mengajarkan posisi menyusui yang nyaman, memastikan perlekatan yang benar (mulut bayi terbuka lebar, sebagian besar areola masuk ke mulut bayi), serta mengajarkan cara melepas isapan bayi dengan benar agar tidak menambah trauma pada puting. Selain itu, bidan juga perlu memberikan edukasi mengenai

perawatan puting, menjaga kebersihan, serta memberikan dukungan emosional agar ibu tetap percaya diri dalam menyusui.

Pendekatan asuhan harus berpusat pada ibu (woman-centered care), menggunakan komunikasi terapeutik, serta berbasis evidence-based practice. Bidan juga harus mampu mengidentifikasi tanda bahaya seperti infeksi atau mastitis yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dukungan keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan menyusui.

Alur Asuhan Singkat

Ibu nifas dengan keluhan nyeri puting → lakukan pengkajian kondisi payudara dan teknik menyusui yang baik dan benar → identifikasi puting lecet akibat perlekatan tidak tepat → lakukan konseling dan demonstrasi teknik menyusui yang benar → berikan edukasi perawatan puting dan dukungan emosional → evaluasi respon ibu dan bayi → dokumentasi asuhan.

G. Daftar Pustaka

-
- Academy of Breastfeeding Medicine. (2016). ABM clinical protocol #26: Persistent pain with breastfeeding. *Breastfeeding Medicine*, 11(2), 46–53. <https://doi.org/10.1089/bfm.2016.29002>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). Breastfeeding challenges. *Obstetrics & Gynecology*, 137(2), e42–e53. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004223>
- BMC Pregnancy and Childbirth. (2020). Determinants of breastfeeding success in postpartum mothers. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03067-2>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Breastfeeding report card. Atlanta: CDC.
- Cunningham F Gary., et al. (2018). *Williams obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill.
- Dennis Cindy-Lee. (2017). Breastfeeding difficulties and maternal mental health. *Journal of Affective Disorders*, 215, 47–55. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.03.010>
- Fraser Diane M., & Cooper Margaret A. (2014). *Myles textbook for midwives* (16th ed.). Elsevier.
- Geddes Donna T., et al. (2013). Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants. *Early Human Development*, 89(9), 635–640. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2013.04.008>
- International Breastfeeding Journal. (2021). Factors influencing breastfeeding technique and nipple trauma. <https://doi.org/10.1186/s13006-021-00388-5>
- International Confederation of Midwives. (2019). *Essential competencies for midwifery practice*.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pemberian ASI eksklusif*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan kesehatan masa nifas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kent Jacqueline C., et al. (2015). Nipple pain in breastfeeding mothers: Incidence, causes, and treatments. *Journal of Human Lactation*, 31(3), 394–402. <https://doi.org/10.1177/0890334415582064>
- Maternal & Child Nutrition. (2019). Breastfeeding practices and maternal outcomes. <https://doi.org/10.1111/mcn.12729>
- McClellan Heather L., et al. (2012). Nipple pain during breastfeeding with or without visible trauma. *Journal of Human Lactation*, 28(4), 511–521. <https://doi.org/10.1177/0890334412444464>
- Riordan Jan., & Wambach Karen. (2010). *Breastfeeding and human lactation* (4th ed.). Jones & Bartlett.
- Rollins Nigel C., et al. (2016). Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *The Lancet*, 387(10017), 491–504. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01044-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2)
- United Nations Children's Fund. (2020). *Infant and young child feeding counselling: An integrated course*. New York: UNICEF.
- Victora Cesar G., Bahl, R., Barros, A. J. D., et al. (2016). Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)
- World Health Organization. (2018). *Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>

BAB 2

ADAPTASI FISIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS IBU NIFAS, INVOLUSI, LOKIA DAN PERUBAHAN EMOSI

CPL:

- CPL 04: Melakukan clinical reasoning untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyimpulkan status kesehatan ibu nifas dan menyusui.
- CPL 06: Menghasilkan dokumentasi asuhan, edukasi/konseling, dan penggunaan bukti ilmiah dasar untuk peningkatan mutu.

CPMK:

- CPMK 02: Menganalisis adaptasi fisiologis–psikologis nifas dan fisiologi laktasi untuk menafsirkan parameter klinis.
- CPMK 04: Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning.
- CPMK 06: Mengidentifikasi dan melakukan tatalaksana awal komplikasi/kegawatdaruratan nifas (perdarahan, infeksi, kesehatan mental) serta menetapkan kriteria rujukan dan kolaborasi.

SUB CPMK:

1. Menafsirkan perubahan involusi uterus dan lokia serta parameter fisiologis normal/abnormal berdasarkan data klinis.
2. Menganalisis perubahan emosi masa nifas dan faktor risiko gangguan psikologis untuk rencana dukungan awal.

Uraian Materi

Masa nifas merupakan periode penting dalam proses pemulihan segera setelah melahirkan hingga kurang lebih enam minggu pasca persalinan (Grace et al., 2023). Masa ini ditandai dengan proses perubahan fisiologis dan psikologis yang kompleks, karena tubuh ibu mengalami berbagai perubahan besar untuk kembali ke kondisi sebelum kehamilan. Secara medis, pemulihan pasca persalinan mencakup penyembuhan organ reproduksi, terutama uterus yang mengalami involusi dan pengeluaran lochia, tetapi tidak hanya perubahan secara fisik, juga melibatkan perubahan psikologis dalam beradaptasi di masa nifas yang sama pentingnya untuk kesehatan ibu secara menyeluruh (Antonio et al., 2021).

Pemulihan pada masa nifas tidak semata dimaknai sebagai periode penyembuhan fisik, tetapi juga sebagai fase transisi menuju kehidupan baru yang sehat dan seimbang sebagai seorang ibu (Sopiah et al., 2025). Dengan memperhatikan berbagai aspek mulai dari adaptasi fisiologis dan psikologis dapat disimpulkan bahwa pemulihan pasca persalinan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup pemulihan fisik dan psikologis. Fase ini membutuhkan dukungan komprehensif, baik dari tenaga medis maupun dukungan keluarga, agar ibu dapat melewati transisi pasca persalinan dengan sehat, sejahtera, dan siap menjalani peran barunya secara optimal (Lestari & Azizah, 2022).

Pendekatan integratif dalam pemulihan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup ibu dan anak, serta mendukung tercapainya tujuan kesehatan masyarakat secara lebih luas. Adapun perubahan fisiologis dan psikologis yang terjadi selama masa nifas adalah sebagai berikut.

A. Adaptasi Fisiologis

Masa setelah persalinan, yang dikenal sebagai periode postpartum, merupakan fase adaptasi fisiologis yang signifikan bagi tubuh perempuan. Perubahan tersebut berkaitan erat dengan proses pemulihan fisik akibat kehamilan dan persalinan (Nurseha, Lintang, et al., 2024).

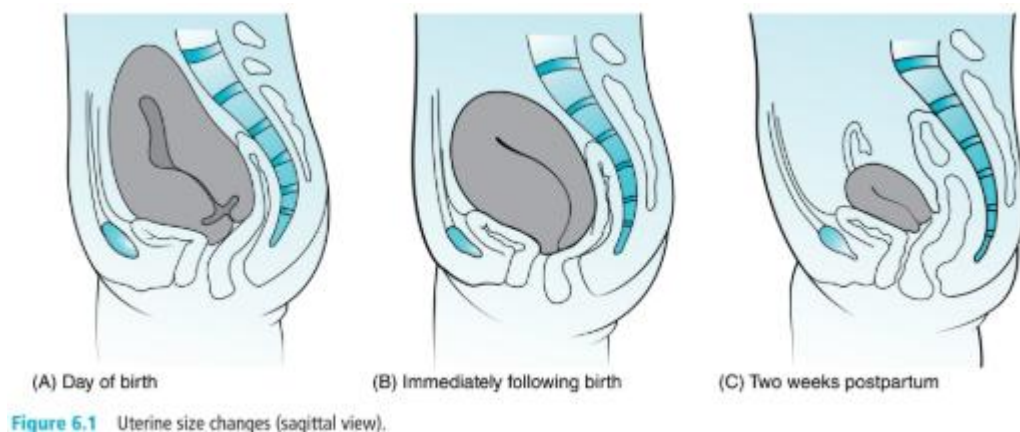
1. Sistem Reproduksi

a. Involusi Uterus

Segera setelah plasenta keluar, dimulailah proses kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Proses ini dikenal dengan istilah involusi. Uterus yang telah menyelesaikan tugasnya, akan menjadi keras karena kontraksinya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa nyeri/mulas yang disebut "*nyeri ikutan*" (*after pain*).

dapat dirasakan lebih intensif terutama pada ibu yang telah melahirkan lebih dari satu anak. Bila uterus gagal untuk kembali pada keadaan tidak hamil disebut subinvolusi (Paliulyte et al., 2017).

Setelah plasenta lahir, fundus uterus terletak kira-kira setinggi atau sedikit di bawah pusar dan tetap di sana selama satu hingga dua hari pertama setelah kelahiran. Uterus harus tetap berkontraksi dengan kuat dan berukuran sebesar bola kecil, kira-kira setinggi 17 cm, lebar 12 cm, dan tebal 10 cm. Pada periode pasca persalinan, uterus cenderung retroversi. Uterus akan mencapai posisi tengah pada akhir minggu pertama dan akan kembali ke posisi anteversi pada akhir minggu ke-2 (Grace et al., 2023).



Gambar 2.1: Perubahan Ukuran Uterus

Proses involusi uterus adalah sebagai berikut:

1) Autolisis

Merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterus. Enzim proteolitik akan memendekkan jaringan otot yang telah sempat mengendur.

2) Atrofi Jaringan

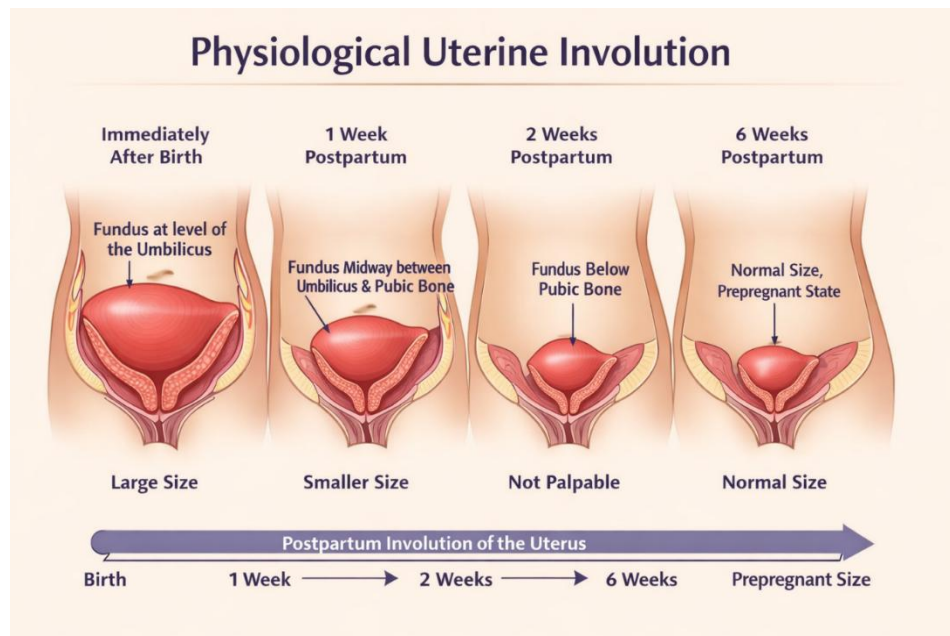
Jaringan yang berproliferasi dengan adanya estrogen dalam jumlah besar, kemudian mengalami atrofi sebagai reaksi terhadap penghentian produksi estrogen yang menyertai pelepasan plasenta.

3) Efek Oksitosin

Penyebab kontraksi dan retraksi otot uterus sehingga akan mengompres pembuluh darah yang akan menyebabkan pengurangan suplai darah ke uterus.

Uterus memulai proses involusi segera setelah persalinan. Selama kehamilan, terjadi peningkatan aliran darah ke uterus dengan hipertrofi dan adaptasi pembuluh darah panggul (Matteo et al., 2021). Sedangkan, pada masa nifas, aliran darah uterus menurun, dan pembuluh darah

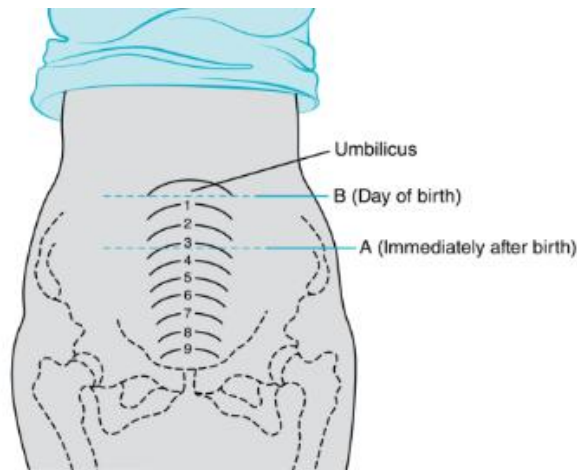
kembali ke keadaan sebelum kehamilan. Involusi terjadi dengan pengurangan ukuran sel miometrium secara drastis dengan berkurangnya jumlah sitoplasma dan resorpsi jaringan ikat. Proses ini terjadi dengan cepat, dengan berat uterus hanya 500 g pada satu minggu setelah kelahiran, 300 g pada dua minggu, dan sekitar 100 g pada empat minggu (Grace et al., 2023).



Gambar 2.2: Fisiologis Penurunan Uterus

Secara abdominal, penurunan ukuran uterus terlihat jelas dengan palpasi fundus uterus dan terjadi dengan kecepatan sekitar 1 cm per hari. Pada hari ke-14, uterus telah turun di bawah tepi simfisis pubis dan tidak lagi teraba secara abdominal (Sulistiyowati, 2024).

Setelah plasenta terpisah dari endometrium, serabut otot uterus berkontraksi, secara efektif mengikat pembuluh darah di tempat menempelnya plasenta (Lestari & Azizah, 2022). Kompresi pembuluh darah sangat penting untuk mencegah perdarahan pascapersalinan. Endometrium juga dipulihkan setelah kelahiran, kelebihan protein intraseluler serta sitoplasma intraseluler dihilangkan melalui autolisis dengan enzim proteolitik dan degradasi makrofag. Lokasi perlekatan plasenta membutuhkan waktu sekitar enam minggu untuk sepenuhnya terkelupas dan meregenerasi lapisan endometrium baru (Grace et al., 2023).



Gambar 2.3: Penurunan Fundus Uterus

b. Pengeluaran Lokia

Dalam masa nifas dikenal istilah lokia yaitu cairan secret yang berasal dari kavum uteri dan vagina pada masa nifas (Kusumaningrum et al., 2023). Lokia adalah cairan vagina yang dihasilkan dari pengelupasan jaringan desidua dan meliputi sisa-sisa produk konsepsi serta beberapa bakteri, sel epitel, dan sel darah merah (Mardhika et al., 2025). Karakteristik lokia berubah seiring dengan pengosongan rahim dari jaringan nekrotik dan regenerasi endometrium baru pada lapisan basal yang berdekatan dengan miometrium. Durasi pengeluaran lokia adalah antara 24-36 hari (Grace et al., 2023). Pengeluaran lokia ini adalah proses normal sebagai bagian dari penyembuhan dan involusi uterus (Rianti et al., 2025).

Lokia muncul dalam berbagai pola seiring waktu. Lokia rubra dimulai setelah pengeluaran plasenta dan terutama terdiri dari darah, bersama dengan sisa-sisa plasenta, membran, vernix, lanugo, dan jaringan desidua (Nugraeny et al., 2025). Lokia rubra berwarna merah, memiliki bau seperti daging yang khas, dan berlangsung selama beberapa hari hingga seminggu. Lokia serosa adalah cairan berwarna coklat kemerahan yang berlangsung selama kurang lebih dua hingga tiga minggu (Sopiah et al., 2025). Cairan ini terdiri dari darah, eksudat luka, eritrosit, leukosit, lendir serviks, mikroorganisme, dan jaringan desisual, dan terjadi ketika rahim mulai meregenerasi endometrium dan ketika lokasi plasenta terkelupas dan dibentuk ulang. Cairan ini secara bertahap berubah menjadi warna merah muda, kuning, atau putih yang disebut lokia alba. Jumlahnya sedikit hingga jarang dan dapat berlangsung hingga empat minggu (Grace et al., 2023). Berikut perbedaan macam-macam lokia pada masa nifas (Fletcher et al., 2012):

1) Lochea Rubra (Kruenta)

Lochea ini berwarna merah, berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, dan mekonium. Lochia rubra keluar selama 2 hari pasca persalinan.

2) Lochea Sanguinolenta

Berwarna merah-kuning, berisi darah dan lendir. Keluar pada hari ke 3-7 pasca persalinan.

3) Lochea Serosa

Berwarna agak kuning, cair tidak berdarah lagi yang keluar pada hari ke 7-14 pasca persalinan.

4) Lochea Alba

Berupa cairan putih yang keluar setelah 2 minggu pasca persalinan.

5) Lochea Purulenta

Terjadi infeksi dan keluar cairan seperti pus (nanah) yang berbau busuk.

6) Lochiostasis

Lochea keluar secara tak lancar.

c. Segmen Bawah Uterus

Otot pada segmen bawah uterus tidak terlalu banyak sehingga tetap merupakan sub organ pasif. Kontraksi dan retraksi otot uterus mengembalikan segmen bawah uterus menjadi isthmus (Puriastuti et al., 2025).

d. Serviks Uteri

Muara serviks, yang berdilatasi 10 cm sewaktu melahirkan menutup secara bertahap. Beberapa hari setelah persalinan, ostium uteri eksternum dapat dilalui oleh 2 jari. Pada akhir minggu pertama hanya dapat dilalui oleh 1 jari saja (Lalita et al., 2025).

e. Vagina dan Perineum

Estrogen pasca partum yang menurun berperan dalam penipisan mukosa dan hilangnya rugae. Vagina yang semula sangat teregang akan kembali secara bertahap ke ukuran sebelum hamil, 6-8 minggu setelah bayi lahir. Kekurangan estrogen menyebabkan penurunan jumlah pelumas vagina dan penipisan mukosa vagina. Kekeringan lokal dan rasa tidak nyaman saat koitus (dispareunia) menetap sampai fungsi ovarium kembali normal dan menstruasi dimulai lagi. Setelah persalinan perineum menjadi kendur karena teregang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Pulihnya otot perineum terjadi sekitar 5-6 minggu postpartum (Wahyuningsih, 2018).

2. Sistem Endokrin

Kadar estrogen dan progesteron menurun ke tingkat sebelum hamil. Kadar estrogen dan progesteron menurun secara mencolok setelah plasenta keluar. Kadar terendahnya mencapai kira-kira 1 minggu pasca persalinan (Azizah & Rosyadah, 2019).

Pada beberapa hari pertama setelah persalinan, terjadi peningkatan kombinasi ACTH, ADH, dan stress yang semuanya meningkatkan retensi natrium dan air. Sehingga banyak wanita mengalami peningkatan berat badan, yang biasanya menurun pada hari ke 4 setelah persalinan karena peningkatan diuresis.

Selama kehamilan, pembentukan gonadotropin tertekan. Kadar FSH pulih ke konsentrasi pra hamil dalam 3 minggu setelah persalinan, tetapi pemulihan sekresi LH memerlukan waktu lebih lama, bergantung pada lama laktasi. Konsentrasi hormon yang menstimulasi perkembangan payudara selama wanita hamil (estrogen, progesterone, human chorionic gonadotropin) menurun dengan cepat setelah bayi lahir. Setelah plasenta lahir maka terdapat dua hormon yang berperan dalam proses laktasi, yaitu prolaktin dan oksitosin (Wahyuningsih, 2018).

Perubahan hormon yang signifikan terjadi selama masa nifas, terutama penurunan kadar estrogen dan progesteron, yang mendukung kembalinya tubuh ke kondisi tidak hamil. Penurunan kadar hormon ini berperan dalam pengurangan ukuran uterus dan kembalinya siklus menstruasi. Selain itu, kadar hormon prolaktin meningkat untuk merangsang produksi ASI (air susu ibu). Peningkatan prolaktin juga menghambat ovulasi pada sebagian ibu yang menyusui, yang berfungsi sebagai bentuk alami kontrasepsi selama periode menyusui (Sulistiyowati, 2024).

Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi. Pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron menurun drastis, sehingga prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI. Dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting susu, terbentuklah prolaktin oleh hipofisis, sehingga sekresi ASI lebih lancar (Mardhika et al., 2025).

3. Sistem Kardiovaskuler

Penurunan volume darah sangat berkaitan dengan kehilangan darah yang dialami selama melahirkan. Penurunan volume dan peningkatan sel darah pada kehamilan diasosiasikan dengan peningkatan hematokrit dan hemoglobin pada hari ke-3 sampai hari ke-7 postpartum dan akan kembali

normal dalam 4-5 minggu postpartum (Azizah & Rosyadah, 2019).

Selama kehamilan, volume darah ibu meningkat untuk mendukung kebutuhan janin. Namun, setelah melahirkan, volume darah ini kembali ke kondisi normal. Proses ini biasanya terjadi dalam beberapa minggu setelah persalinan. Adaptasi sistem kardiovaskular juga melibatkan penurunan tekanan darah dan peningkatan kembali elastisitas pembuluh darah. Proses pemulihan ini bisa mempengaruhi ibu dalam bentuk perasaan lelah atau sesekali pusing, yang merupakan bagian dari penyesuaian tubuh kembali ke keadaan non-kehamilan.

4. Sistem Hematologi

Leukositosis mungkin terjadi selama persalinan, sel darah merah berkisar 15.000 selama persalinan. Peningkatan sel darah putih berkisar antara 25.000 – 30.000 yang merupakan manifestasi adanya infeksi pada persalinan lama. Hal ini dapat meningkat pada awal nifas yang terjadi bersamaan dengan peningkatan tekanan darah serta volume plasma dan volume sel darah merah. Pada 2 – 3 hari postpartum, konsentrasi hematokrit menurun sekitar 2% atau lebih. Total kehilangan darah pada saat persalinan dan nifas $\pm$ 700 – 1500 ml, yaitu 200 ml hilang pada saat persalinan, 500 – 800 ml hilang pada minggu pertama postpartum, dan 500 ml hilang pada saat masa nifas.

5. Sistem Urinaria

Perpindahan cairan ekstrasvaskular ke ruang intravaskular dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan mengakibatkan menetapnya peningkatan aliran darah ginjal selama periode tersebut. Peningkatan aliran darah ke ginjal ini dikaitkan dengan diuresis dan natriuresis yang mengeluarkan cairan dan natrium yang tertahan selama trimester ketiga.

Vesika urinaria dapat mengalami gangguan fungsi akibat persalinan yang lama atau akibat kateterisasi sebelumnya. Dapat terjadi disuria/distensi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada kasus yang sedang dengan distensi vesika urinaria perlu dipasang kateter. Sebagian besar persalinan normal tidak menimbulkan gangguan pada vesika urinaria. Distensi kandung kemih yang muncul segera setelah wanita melahirkan dapat menyebabkan perdarahan berlebihan karena keadaan ini bisa menghambat uterus berkontraksi dengan baik. Dengan mengosongkan kandung kemih secara adekuat, tonus kandung kemih biasanya akan pulih kembali dalam 5-7 hari setelah bayi lahir. Gangguan terjadi akibat episiotomi, persalinan yang lama, bayi yang besar.

6. Sistem Gastrointestinal

Sistem gastrointestinal selama kehamilan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya tingginya kadar progesteron yang dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah, dan memperlambat kontraksi otot-otot polos. Pasca melahirkan, kadar progesteron juga mulai menurun. Namun demikian, faal usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali normal. Beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem pencernaan, antara lain: nafsu makan, motilitas dan pengosongan usus.

Pasca melahirkan, ibu sering mengalami konstipasi. Hal ini disebabkan tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal masa pascapartum, diare sebelum persalinan, enema sebelum melahirkan, kurang makan, dehidrasi, hemoroid ataupun laserasi jalan lahir. Penurunan aktifitas usus terutama setelah pembatasan asupan diet selama 24 jam sampai 36 jam sebelumnya dapat menghambat defekasi selama 1 atau 2 hari pertama postpartum (Wahyuningsih, 2018).

7. Penyembuhan Luka Persalinan

Pada ibu yang melahirkan melalui persalinan normal atau caesar, luka persalinan, seperti episiotomi atau sayatan operasi caesar, membutuhkan waktu untuk sembuh. Proses penyembuhan ini dapat berlangsung beberapa minggu. Ibu yang melahirkan melalui caesar mungkin juga mengalami penyembuhan luka di sekitar area jahitan perut. Selama masa penyembuhan, penting untuk menjaga kebersihan area tersebut mengonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari infeksi yang dapat memperlambat proses pemulihan (Wahyuningsih, 2018).

B. Adaptasi Psikologis

Adaptasi psikologis ibu nifas ditandai oleh perubahan emosi yang dinamis akibat kombinasi faktor hormonal, kelelahan, perubahan peran, dan tanggung jawab baru sebagai ibu (Mardhika et al., 2025). Literatur menunjukkan bahwa perubahan emosi ini berlangsung dalam beberapa fase (taking-in, taking-hold, letting-go) dan dapat berkisar dari reaksi normal hingga gangguan seperti *postpartum blues* atau depresi (Nurseha, Kusumastuti, et al., 2024).

Periode postpartum menyebabkan stress emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat (Junika & Sulistyoningtyas, 2025). Faktor- faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orangtua pada masa postpartum adalah:

1. Respons dan dukungan dari keluarga dan teman
2. Hubungan antara pengalaman melahirkan dan harapan serta aspirasi

3. Pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lain
4. Pengaruh budaya

Perubahan Emosi pada Masa Nifas (Ningrum, 2017; Nurseha, Kusumastuti, et al., 2024; Sam et al., 2025):

1. Emosi labil (mood swing)
 - a. Ibu mudah berubah perasaan: dari senang, sedih dan cemas dalam waktu singkat
 - b. Dipengaruhi perubahan hormon estrogen dan progesteron setelah melahirkan
 - c. Merupakan kondisi paling umum pada hari-hari awal postpartum
2. Mudah menangis (baby blues)
 - a. Terjadi biasanya hari ke-2 sampai ke-10 setelah persalinan
 - b. Gejala: sedih tanpa sebab jelas, sensitif, mudah tersinggung
 - c. Bersifat ringan dan sementara, tetapi perlu dukungan keluarga
3. Kecemasan (anxiety)
 - a. Ibu merasa khawatir berlebihan terhadap kondisi bayi atau kemampuan merawat bayi
 - b. Sering muncul pada ibu primipara (anak pertama)
 - c. Dapat disertai sulit tidur dan gelisah
4. Perasaan tidak percaya diri
 - a. Ibu merasa belum mampu menjadi ibu yang baik
 - b. Takut salah dalam merawat bayi
 - c. Berkaitan dengan fase belajar peran baru
5. Ketergantungan emosional
 - a. Terlihat pada fase *taking-in*
 - b. Ibu cenderung pasif, bergantung pada orang lain, dan fokus pada dirinya sendiri
 - c. Membutuhkan perhatian dan dukungan penuh
6. Ikatan emosional dengan bayi (bonding attachment)
 - a. Timbul rasa kasih sayang, kedekatan, dan tanggung jawab
 - b. Jika terganggu, dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis
7. Risiko gangguan emosional berat

Jika tidak beradaptasi dengan baik maka dapat berkembang menjadi: Postpartum depression dan Postpartum psychosis (jarang tapi serius)

Periode postpartum ini di uraikan oleh Rubin terjadi dalam 3 tahap yaitu (Wahyuningsih, 2018):

1. *Taking in*

- a. Periode ini terjadi 1 – 2 hari sesudah melahirkan. Ibu pada umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan tubuhnya.
- b. Ibu akan mengulang-ulang pengalamannya waktu melahirkan.
- c. Tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mencegah gangguan tidur.
- d. Peningkatan nutrisi mungkin dibutuhkan karena selera makan ibu biasanya bertambah. Nafsu makan yang kurang menandakan proses pengembalian kondisi ibu tidak berlangsung normal.

2. *Taking Hold*

- a. Berlangsung 2-4 hari postpartum. Ibu menjadi lebih perhatian dalam kemampuannya menjadi orangtua dan meningkatkan tanggung jawab terhadap bayi.
- b. Perhatian terhadap fungsi-fungsi tubuh (misalnya, eliminasi)
- c. Ibu berusaha keras untuk menguasai ketrampilan untuk merawat bayi, misalnya menggendong dan menyusui. Ibu agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal tersebut, sehingga cenderung menerima nasihat dari bidan karena ia terbuka untuk menerima pengetahuan dan kritikan yang bersifat pribadi.

3. *Letting Go*

- a. Terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga.
- b. Ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi. Ia harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat tergantung, yang menyebabkan berkurangnya hak ibu dalam kebebasan dan berhubungan sosial. Pada periode ini umumnya terjadi postpartum blues/baby blues.

Tabel 2.1: Fase Adaptasi dan Ciri Perubahan Emosi Pada Masa Nifas

Fase	Waktu	Perubahan Emosi
Taking-In	1-2 hari	Pasif, tergantung, focus pada diri, emosional
Taking-Hold	3-10 hari	Mandiri, cemas, butuh dukungan
Letting-Go	> 10 hari	Menerima peran ibu, emosi lebih stabil

C. Tanda Bahaya Masa Nifas

Tanda bahaya masa nifas adalah gejala abnormal yang muncul setelah persalinan (hingga ± 6 minggu) yang menunjukkan adanya komplikasi serius seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan sistemik (Nugraeny et al., 2025). Deteksi dini sangat penting karena sebagian besar kematian ibu terjadi pada periode ini, terutama dalam 24 jam pertama hingga minggu pertama postpartum. Tanda bahaya masa nifas antara lain (Ningrum, 2017; Nugraeny et al., 2025; Puriastuti et al., 2025; Rejeki & Fajri, 2024; Triastin & Nabila, 2024):

1. Perdarahan pervaginam berlebihan
 - a. Ditandai dengan darah keluar banyak (lebih dari 1 pembalut penuh dalam ≤ 1 jam) atau disertai bekuan besar
 - b. Bisa menunjukkan *perdarahan postpartum* (penyebab utama kematian ibu)
 - c. Sering disebabkan oleh atonia uteri atau sisa plasenta
2. Demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$)
 - a. Menunjukkan kemungkinan infeksi nifas (*puerperal sepsis*)
 - b. Biasanya disertai menggigil, lemas, dan nyeri tubuh
3. Keputihan berbau busuk (lochia berbau)
 - a. Normalnya lochia tidak berbau menyengat
 - b. Bau busuk menandakan infeksi rahim (endometritis)
4. Nyeri perut hebat atau nyeri uterus
 - a. Nyeri berlebihan, menetap, atau semakin parah
 - b. Dapat mengindikasikan infeksi atau subinvolusi uterus
5. Payudara bengkak, merah, dan nyeri
 - a. Gejala mastitis (infeksi payudara)
 - b. Bisa disertai demam dan kesulitan menyusui
6. Sakit kepala hebat, penglihatan kabur
 - a. Bisa merupakan tanda *preeklamsia postpartum*
 - b. Berbahaya karena dapat berkembang menjadi kejang (eklamsia)
7. Bengkak pada wajah, tangan, atau kaki
 - a. Jika disertai tekanan darah tinggi maka menjadi tanda gangguan hipertensi postpartum
8. Sesak napas atau nyeri dada
 - a. Dapat menunjukkan emboli paru atau gangguan jantung dan merupakankndisi darurat yang membutuhkan penanganan segera
9. Luka jahitan bernanah atau tidak sembuh
 - a. Luka episiotomi/operasi caesar yang merah, bengkak, keluar nanah
 - b. Menandakan infeksi luka
10. Perubahan kondisi mental (bingung, gelisah, depresi berat)

- Bisa berupa *postpartum depression* atau psikosis
- Ditandai dengan perubahan perilaku ekstrem, bahkan keinginan menyakiti diri dan bayi

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Identifikasi adaptasi fisiologis masa nifas, involusi uterus, lokia, adaptasi psikologis, perubahan emosi dan red flags

Seorang ibu, umur 25 tahun, P1A0, hari ke-2 postpartum normal, BB bayi 3.500 g jenis kelamin laki-laki dan mengeluh tidak bisa BAB. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, P 22x/menit, N 84x/menit, S 36°C, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, lokia berwarna merah segar, tidak berbau. Ibu mengeluh mudah menangis tanpa sebab dan merasa cemas merawat bayinya.

- Apa masalah yang terjadi pada kasus di atas?
- Normalkan adaptasi fisiologis masa nifas kasus di atas?
- Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
- Berdasarkan konsep adaptasi fisiologis dan psikologis masa nifas, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab masalah kasus tersebut?
- Adakah tanda bahaya apa yang muncul pada kasus di atas? Kalau tidak ada, kemungkinan tanda bahaya yang terjadi pada masa nifas sesuai kasus di atas adalah?
- Bagaimanakah perubahan emosi ibu pada kasus di atas? Jelaskan alasan Anda.
- Asuhan yang diberikan bidan pada kasus ini antara lain?
- Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
- Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga setelah dilakukan tindakan?

E. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab pemeriksaan Involusi Uterus, Lokia dan tanda bahaya masa nifas
Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Soal OSCE Asuhan Kebidanan Nifas

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Asuhan Masa Nifas: Pemeriksaan Involusi uterus, Lokia dan tanda bahaya

No.	Komponen	Isi
3	Kasus	Postpartum hari ke-2
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 23 tahun P1A0 datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan payudara terasa penuh, dan tegang. Hasil anamnesis: baru melahirkan 2 hari yang lalu, normal di puskesmas. Hasil pemeriksaan: TD 120/70 mmHg, P 20x/menit, N 88x/menit S 36,9°C, payudara terasa tegang. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana asuhan
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta

No.	Komponen	Isi
		b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: • Actual mark (0/1/2/3) • Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi payudara, penguji memberikan data: payudara tegang, keras, hangat sebelah kanan, ASI + 3. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data: TFU 2 jari di bawah pusat 4. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan lokia, penguji memberikan data: lokia rubra 5. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: - Menilai ulang kondisi ibu secara cepat - Menjelaskan kondisi ibu secara jelas - Memberikan konseling/KIE sesuai dengan kebutuhan ibu 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 7. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN

No.	Komponen	Isi
		1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 6. PS berperan sebagai ibu nifas. 7. PS tampak cemas, lelah dan khawatir dengan kondisinya. 8. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 9. Bila peserta menyampaikan asuhan atau tindakan perawatan, PS tampak mengerti dan bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya kesulitan untuk menyusui, payudara sakit dan keras Bu. Peserta: Sejak kapan kesulitan untuk menyusui dan payudaranya kesar Bu? PS: Mulai kemarin malam, Bu. Peserta: Apakah sudah keluar ASI nya? PS: Iya, sudah Bu kalau dipencet. Peserta: Berapa kali bayi menyusui dalam sehari? PS: Kalau menangis saja Bu, sekitar 5-6 kali sehari. Peserta: Apakah kalau bayi tidur sudah lebih dari 2 jam dibangunkan untuk menyusui? PS: Tidak, Bu. Peserta: Apakah bayi menetek di dua payudara? PS: Lebih sering bagian kiri saja, Bu. Peserta: Durasi setiap menyusui hingga berapa menit?

No.	Komponen	Isi
		PS: 30 menit. Peserta: Apakah menyusui bayi hingga payudara kosong? PS: tidak tahu, Bu, saya hanya menyusui saja. Peserta: Apakah rutin dilakukan untuk perawatan payudara selama menyusui ini? PS: Tidak pernah, Bu. Peserta: Apakah pernah mendapatkan edukasi terkait perawatan payudara, cara menyusui yang benar, dan seputar ASI? PS: Pernah, tapi masih belum paham. Peserta: Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pemeriksaan pemulihan masa nifas secara keseluruhan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	Phantom pemeriksaan fisik wanita dewasa
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom pemfis Wanita dewasa — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Jam tangan/stopwatch — 1 6. Termometer — 1 7. Sarung tangan bersih — 1 pasang 8. Handrub — 1 botol 9. Kain penutup/selimut — 1 10. Tisu — 1 pack 11. Lembar pemeriksaan nifas — 1 set

No.	Komponen	Isi
		12. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 13. Pena — 1
13	Penulis	Bdn. Dini Ria Oktavia, S.ST., M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. Ikatan Bidan Indonesia. (2021). Modul Pelatihan: Midwifery Update.

F. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Asuhan Masa Nifas: Pemeriksaan Involusi uterus, Lokia dan Tanda Bahaya

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian Pemeriksaan Involusi Uterus, lokia, tanda bahaya
- Eskalasi bila red flags muncul

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan saat ini		
2. Riwayat persalinan dan nifas sekarang (tanggal persalinan, penyulit persalinan dan masa nifas)		
3. Pengeluaran pervaginam (pengeluaran lokia, berbau)		
4. Pengeluaran ASI		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
5. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
6. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		
d. Menyimpulkan ada/tidaknya tanda bahaya masa nifas dan kecurigaan komplikasi masa nifas		
e. Memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan kondisi ibu		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan rencana lanjutan/kunjungan ulang		
b. Dokumentasi tindakan dan perawatan yang diberikan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **9–14 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–5 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Mendampingi ibu dan melibatkan keluarga/pendamping dalam pengambilan keputusan		
5. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama pemeriksaan dan Tindakan awal		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),.....

.....

Penguji :.....

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Kebidanan Nifas: Pemeriksaan Involusi Uterus, Pengeluaran Lokia, dan Tanda Bahaya Masa Nifas

Komponen	Deskripsi	Kasus Nifas Normal 4 jam PP
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu nifas 4 jam PP, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan pemeriksaan nifas dan merencanakan asuhan kebidanan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan pemeriksaan yang aman, cepat, dan sistematis pada ibu nifas hari ke-2 dengan keluhan bendungan payudara dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang pemeriksaan nifas, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi normal dan abnormal pada masa nifas, merencanakan asuhan dan memberikan perawatan yang sesuai dan tepat.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, fisiologis masa nifas, identifikasi, perencanaan asuhan kebidanan dan tindakan kebidanan.	Seorang perempuan usia 23 tahun P1A0 baru melahirkan 4 jam yang lalu. Hasil anamnesa: merasa kelelahan setelah melahirkan, cemas, khawatir, dan tidak mampu untuk merawat bayinya. Hasil pemeriksaan S 36,7°C, N 80 x/menit, P 24x/menit, TD 120/80 mmHg, TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi ada, luka jahitan perineum basah, lokia rubra, payudara teraba penuh, dan pengeluaran payudara tidak ada
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan pemeriksaan sesuai fokus keluhan, mendiagnosa, menentukan masalah masa nifas sesuai kasus,

Komponen	Deskripsi	Kasus Nifas Normal 4 jam PP
	relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, pemeriksaan fisik sesuai focus utama keluhan ibu, pemeriksaan obstetric fokus pada involusi uterus, peneluaran lokia, proses penyembuhan luka pascapersalinan, merencanakan asuhan kebidanan tindakan kebidanan yang diperlukan sesuai dengan kasus dan dokumentasi kebidanan.	merencanakan asuhan kebidanan, tindakan kebidanan, dan dokumentasi asuhan kebidanan masa nifas.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi pemeriksaan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda normal/abnormal dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi fisiologis adaptasi dan psikologis masa nifas, tanda normal dan abnormal pada masa nifas, dan asuhan kebidanan secara mandiri atau rujukan.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan pemeriksaan masa nifas dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengidentifikasi kondisi normal dan abnormal pada masa nifas, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta pemberian asuhan yang tepat.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan mengidentifikasi kondisi normal dan abnormal pada masa nifas, ketepatan dalam merencanakan asuhan kebidanan sesuai data kasus atau kelengkapan

Komponen	Deskripsi	Kasus Nifas Normal 4 jam PP
		penjelasan kepada ibu dan keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan pemeriksaan fisik masa nifas secara runtut, aman, dan tepat sesuai masalah. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengidentifikasi tanda normal dan abnormal masa nifas, salah menentukan prioritas, atau rencana asuhan dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus nifas fisiologis dengan keluhan bendungan payudara, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan rencana asuhan dan tindakan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Tabel Portofolio pada Asuhan Kebidanan Nifas dan Komplikasi: Adaptasi Fisiologis dan Psikologis Ibu Nifas, Involusi, Lokia dan Perubahan Emosi

Komponen	Deskripsi	Nifas Normal 4 jam PP
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik nifas normal 4 jam PP, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian masa nifas, mengenali tanda normal dan abnormal masa nifas, merencanakan asuhan, melakukan tindakan, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu nifas normal 4 jam PP, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan mengidentifikasi fisiologis masa nifas, tanda normal dan abnormal masa nifas, rencana asuhan dan tindakan kebidanan yang tepat. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pemeriksaan, rencana asuhan dan tindakan pada ibu nifas.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Seorang perempuan usia 23 tahun P1A0 baru melahirkan 4 jam yang lalu. Hasil anamnesa: merasa kelelahan setelah melahirkan, cemas, khawatir, dan tidak mampu untuk merawat bayinya. Hasil pemeriksaan S 36,7°C, N 80 x/menit, P 24x/menit, TD 120/80 mmHg,

Komponen	Deskripsi	Nifas Normal 4 jam PP
		TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi ada, luka jahitan perineum basah, lokia rubra, payudara teraba penuh, dan pengeluaran payudara tidak ada, dokumentasi rencana asuhan dan tindakan kebidanan yang dilakukan
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda kemungkinan adanya tanda bahaya masa nifas, ketelitian dalam pemeriksaan, perencanaan asuhan kebidanan, tindakan kebidanan dan edukasi/komunikasi yang sesuai dengan kasus nifas normal 4 jam PP.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pemeriksaan nifas, mengidentifikasi tanda normal dan abnormal masa nifas, merencanakan asuhan dan tindakan kebidanan yang sesuai.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus nifas normal 4 jam PP, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan pemeriksaan fisik, mengidentifikasi tanda normal dan abnormal masa nifas, perencanaan asuhan dan tindakan asuhan yang sesuai berdasarkan pasien safety.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara

Komponen	Deskripsi	Nifas Normal 4 jam PP
	kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	konsisten mampu mengidentifikasi tanda normal dan abnormal masa nifas, rencana asuhan dan tindakan yang sesuai pada kasus yang terjadi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik nifas normal, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Kebidanan Nifas dan Komplikasi: Adaptasi Fisiologis dan Psikologis Ibu Nifas, Involusi, Lokia dan Perubahan Emosi

Komponen	Deskripsi	Kasus Nifas Normal 4 jam PP
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang bahwa pengkajian masa nifas, mengenali tanda normal dan abnormal masa nifas, merencanakan asuhan dan dokumentasi asuhan
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga pengkajian masa nifas, mengenali tanda normal dan abnormal masa nifas, merencanakan asuhan dan dokumentasi asuhan
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan pengkajian masa

Komponen	Deskripsi	Kasus Nifas Normal 4 jam PP
	utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	nifas, tanda normal dan abnormal masa nifas sesuai kasus, dan rencana asuhan kebidanan
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu nifas sesuai dengan kasus, merencanakan asuhan kebidanan dengan tepat dan mengevaluasi tindakan kebidanan yang sudah dilakukan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus nifas normal 4 jam PP, mahasiswa belajar bahwa pengkajian masa nifas, identifikasi diagnosa masa nifas, menilai kenormalan dan abnormal masa nifas, merencanakan asuhan dan tindakan sesuai dengan standar dan kesesuaian kasus masa nifas.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep adaptasi fisiologis dan psikologis masa nifas, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Kebidanan Nifas dan Komplikasi: Adaptasi Fisiologis dan Psikologis Ibu Nifas, Involusi, Lokia dan Perubahan Emosi

Komponen	Deskripsi	Kasus Nifas Normal 4 jam PP
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus nifas normal 4 jam PP, mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan dalam mengidentifikasi adaptasi fisiologis dan psikologis pada masa nifas menyebabkan keterlambatan dalam pencegahan dan penanganan kasus nifas.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca 55rofession, tidak memantau DJJ dengan cermat, atau menunda rujukan, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah perdarahan postpartum sekunder, kelelahan ibu, infeksi nifas, dan keterlambatan penanganan bila masa nifas tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain perdarahan postpartum sekunder, kelelahan ibu, infeksi nifas dan kesalahan identifikasi tanda normal dan abnormal masa nifas.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengkajian untuk mengidentifikasi tanda normal dan abnormal masa nifas untuk mencegah keterlambatan penanganan tanda bahaya masa nifas.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan	Mahasiswa menyadari bahwa pada nifas normal 4 jam PP, pengkajian adaptasi fisiologis dan psikologis,

Komponen	Deskripsi	Kasus Nifas Normal 4 jam PP
	memengaruhi praktik berikutnya.	perumusan diagnose, rencana asuhan dan tindakan yang sesuai prosedur adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Kebidanan Nifas dan Komplikasi: Adaptasi Fisiologis dan Psikologis Ibu Nifas, Involusi, Lokia dan Perubahan Emosi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan banyak (>500 ml, pembalut penuh <1 jam), Uterus lembek (tidak berkontraksi)	Perdarahan postpartum penyebab atonia uteri	Segera rujuk, lakukan manajemen awal (masase uterus, oksitosin), pantau tanda vital
Fundus uterus tidak turun sesuai hari nifas	Subinvolusi uterus (infeksi atau sisa plasenta)	Konsultasi atau rujuk ke fasilitas lebih tinggi, evaluasi USG bila perlu
Lokia rubra menetap >3–4 hari	Perdarahan abnormal atau involusi terganggu	Observasi ketat, rujuk jika disertai perdarahan banyak
Lokia berbau busuk	Infeksi puerperium	Rujuk, kolaborasi pemberian antibiotik
Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Infeksi (endometritis, mastitis, dll)	Evaluasi segera, lakukan kolaborasi/rujukan
Payudara merah, nyeri, panas	Mastitis atau abses payudara	Edukasi menyusui, kompres hangat/dingin, rujuk untuk terapi antibiotik
Edema, nyeri pada tungkai	Tromboflebitis	Rujuk segera (risiko emboli)
Ibu tampak sangat sedih, menangis terus >2 minggu	Depresi postpartum	Konseling, rujuk ke tenaga kesehatan jiwa
Tidak mau merawat bayi	Gangguan bonding atau depresi	Konseling, libatkan keluarga, rujuk bila perlu
Kelelahan ekstrem, tidak mampu aktivitas sehari-hari	Gangguan adaptasi psikologis atau fisik	Evaluasi menyeluruh, dukungan keluarga, rujuk bila perlu

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Asuhan Kebidanan Nifas dan Komplikasi: Adaptasi Fisiologis dan Psikologis Ibu Nifas, Involusi, Lokia dan Perubahan Emosi**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian periode nifas	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan adaptasi fisiologis masa nifas	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan adaptasi psikologis masa nifas	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi fisiologis involusi uterus	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menentukan perbedaan berat uterus dan posisi uterus pada involusi masa nifas	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi pengeluaran lokia	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengenali perbedaan perubahan emosi pada ibu masa nifas	☐	☐	
8	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada masa nifas	☐	☐	
9	Saya sudah bisa merencanakan asuhan kebidanan ibu nifas yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan pengkajian pada ibu nifas	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik terfokus pada ibu nifas	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi pemeriksaan nifas kepada ibu dan keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Rangkuman Materi

Capaian pembelajaran pada Bab ini adalah menganalisis adaptasi fisiologis–psikologis nifas dan fisiologi laktasi untuk menafsirkan parameter klinis. Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning. Mengidentifikasi dan melakukan tatalaksana awal komplikasi/kegawatdaruratan nifas (perdarahan, infeksi, kesehatan mental) serta menetapkan kriteria rujukan dan kolaborasi.

Masa nifas merupakan periode penting dalam proses pemulihan segera setelah melahirkan hingga kurang lebih enam minggu pasca persalinan. Masa ini ditandai dengan proses perubahan fisiologis dan psikologis yang kompleks, karena tubuh ibu mengalami berbagai perubahan besar untuk kembali ke kondisi sebelum kehamilan. Secara medis, pemulihan pasca persalinan mencakup penyembuhan organ reproduksi, terutama uterus yang mengalami involusi dan pengeluaran lokia, tetapi tidak hanya perubahan secara fisik, juga melibatkan perubahan psikologis dalam beradaptasi di masa nifas yang sama pentingnya untuk kesehatan ibu secara menyeluruh.

Segera setelah plasenta keluar, dimulailah proses kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Proses ini dikenal dengan istilah involusi. Setelah plasenta lahir, fundus uterus terletak kira-kira setinggi atau sedikit di bawah pusar dan tetap di sana selama satu hingga dua hari pertama setelah kelahiran.

Lokia adalah cairan vagina yang dihasilkan dari pengelupasan jaringan desidua dan meliputi sisa-sisa produk konsepsi serta beberapa bakteri, sel epitel, dan sel darah merah. Karakteristik lokia berubah seiring dengan pengosongan rahim dari jaringan nekrotik dan regenerasi endometrium baru pada lapisan basal yang berdekatan dengan miometrium. Durasi pengeluaran lokia adalah antara 24-

36 hari. Pengeluaran lochia ini adalah proses normal sebagai bagian dari penyembuhan dan involusi uterus.

Adaptasi psikologis ibu nifas ditandai oleh perubahan emosi yang dinamis akibat kombinasi faktor hormonal, kelelahan, perubahan peran, dan tanggung jawab baru sebagai ibu. Literatur menunjukkan bahwa perubahan emosi ini berlangsung dalam beberapa fase (taking-in, taking-hold, letting-go) dan dapat berkisar dari reaksi normal hingga gangguan seperti *postpartum blues* atau depresi. Periode postpartum menyebabkan stress emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat.

Alur Asuhan Masa Nifas

Pengkajian data subyektif → pemeriksaan fisik fokus masa adaptasi fisiologis dan psikologis masa nifas → identifikasi tanda normal dan abnormal masa nifas → perumusan diagnose kebidanan masa nifas → rencana asuhan kebidanan masa nifas → asuhan kebidanan masa nifas → dokumentasi kebidanan masa nifas

I. Daftar Pustaka

-
- Antonio, M., Di, D., Bellussi, F., & Berghella, V. (2021). Ultrasound evaluation of the uterus in the uncomplicated postpartum period: a systematic review. *American Journal of Obstetric and Gynecology MFM*, 3(3), 2–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2021.100318>
- Azizah, N., & Rosyadah, R. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui* (1st ed.). UMSIDA Press.
- Fletcher, S., Grotegut, C. A., & James, A. H. (2012). Lochia Patterns Among Normal Women : A systematic Review. *Journal of Women's Health*, 21(12), 1290–1294. <https://doi.org/10.1089/jwh.2012.3668>
- Grace, K. T., Cindy, L., Jeffers, N. K., & Wiley, J. (2023). *Prenatal and Postnatal Care : A Person Centered Approach* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Junika, I. R., & Sulistyoningtyas, S. (2025). Hubungan Dukungan Suami Dengan Proses Adaptasi Psikologis Pada Ibu Nifas. *Midwifery Care Journal*, 6(4), 133–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.31983/micajo.v6i4.12826>
- Kusumaningrum, A. T., Rokayah, Y., Fatmawati, Wardani, P. K., Iswanti, T., Nurakilah, H., Sulistyawati, H., Ismiati, Battya, A. A., Ningsih, D. A., Baska, D. Y., Linta, I. N., Rahmawatu, D., & Pratama, R. M. . (2023). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui* (1st ed.). Nuansa Fajar Cemerlang.
- Lalita, E. M. F., Indarsita, D., Melly, Sarliana, Notesya, Murtiyarini, I., Isnina, Suhriah, Yauri, I., Adista, N. F., Danaz, A. F., Lubis, R., Manik, R., Nurdahlana, Hidayati, Nopiska, D., Fasiha, & Manueke, I. (2025). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas* (L. O. Alifariki (ed.); 1st ed.). PT Media Pustaka Indo.

- Lestari, G. I., & Azizah, L. N. (2022). Uterus Involution and Psychological Adaptation in Postpartum Mothers. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 8(2), 469–477. <https://doi.org/10.33024>
- Mardhika, A., Oktavia, D. R., Purnami, R. W., Rofika, L. D., Fransysca, H., Hanifa, A. A., Wati, R., Nurhayati, F., Purnamasari, D., & Oktavia, N. (2025). *Nifas dan Peran Keluarga* (1st ed.). Bukuloka Literasi Bangsa.
- Matteo, U., Di, A., Daniele, M., Federica, B., & Vincenzo, B. (2021). Ultrasound evaluation of the uterus in the uncomplicated postpartum period: a systematic review. *American Journal of Obstetric and Gynecology MFM*, 3(3), 25–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2021.100318>
- Ningrum, S. P. (2017). Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Postpartum Blues. *PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 205–218. <https://doi.org/10.15575/psy.v4i2.1589>
- Nugraeny, L., Rostianingsih, D., Oktavia, D. R., Kolifah, Siantar, R. L., Liza, Andayani, A., Sari, K., Setyarini, D. I., Arfiana, Gultom, R., Andriani, F., Tompunuh, M. m, Winata, I. G. S., & Zurizah, Y. (2025). *Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir* (1st ed.). Bukuloka Literasi Bangsa.
- Nurseha, Kusumastuti, Farida, S. N., Mardianingsih, S., & Marlinawati, I. T. (2024). *Buku Ajar: Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas* (1st ed.). Nuansa Fajar Cemerlang.
- Nurseha, Lintang, S. S., Subagio, S. U., Pertasari, R. <, Tyas, T. P., Perbawati, D., & Lailaturohmah. (2024). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui* (1st ed.). Dewa Publishing.
- Paliulyte, V., Drasutiene, G. S., Ramasauskaite, D., Bartkeviciene, D., Zakareviciene, J., & Kurmanavicius, J. (2017). Physiological Uterine Involution in Primiparous and Multiparous Women: Ultrasound Study. *Obstetric and Gynecology International*, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/6739345>
- Puriastuti, E. A., Anggraeni, F. D., Nor'aini, Y., Kamila, N. A., Abdiani, B. T., Ardiyanti, A., Oktavia, D. R., Sandhi, S. I., & Ummah, K. (2025). *Kehamilan Sehat: Panduan Ilmiah dari Prakonsepsi hingga Persalinan* (1st ed.). Bukuloka Literasi Bangsa.
- Rejeki, I. S., & Fajri, F. (2024). Edukasi Pendidikan Tanda Bahaya dan Komplikasi masa Nifas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gunung Sari*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.58294/jpmgs.v2i1.150>
- Rianti, E., Fratidhina, Y., Triwinarto, A., Tarwoto, Mumpuni, & Nurulhuda, U. (2025). Preventing Postpartum Complications with Otaria Gymnastics : Improving the Welfare of Postpartum Mothers in Indonesia. *The Open Public Health Journal*, 18, 1–7. <https://doi.org/10.2174/0118749445371776250220115516>
- Sam, K. L. N., Rahmawati, S. A., Muninggar, Agustina, K. S., Nurmitasari, Qiftiyah, M., & Sari, N. N. (2025). *Buku Ajar Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas* (1st ed.).

Nuansa Fajar Cemerlang.

- Sopiah, O., Runggandini, S. A., Apriningrum, N., & Resita, C. A. (2025). The Effect of Postpartum Exercise Practices on Uterine Fundal Height , Lochia , Diastasis Recti , Baby Blues in Accelerating Recovery in Postpartum. *Universal Jouenal of Public Health*, 13(1), 197–209. <https://doi.org/10.13189/ujph.2025.130120>
- Sulistiyowati, A. N. (2024). *Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas dan Menyusui* (1st ed.). CV. Lliterasi Nusantara Abadi.
- Triastin, S. A., & Nabila, F. (2024). Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Nifas Terhadap Tanda Bahaya Pada Masa Nifas. *Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 2(2), 257–262. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm/v2n2>
- Wahyuningsih, H. P. (2018). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Kemenkes RI.

BAB 3

PEMANTAUAN MASA NIFAS TERJADWAL– KUNJUNGAN NIFAS, PARAMETER KLINIS, DAN DETEKSI DINI RISIKO

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab hukum dalam pemberian asuhan nifas dan menyusui.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi interprofesional dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam seluruh rangkaian pelayanan nifas–menyusui.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Melakukan clinical reasoning untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyimpulkan status kesehatan ibu nifas dan menyusui.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan nifas dan menyusui secara aman dan bermutu, termasuk stabilisasi awal dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menghasilkan dokumentasi asuhan, edukasi/konseling, dan penggunaan bukti ilmiah dasar untuk peningkatan mutu.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, ruang lingkup, standar, dan alur pelayanan asuhan nifas dan menyusui berbasis keselamatan pasien.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis–psikologis nifas dan fisiologi laktasi untuk menafsirkan parameter klinis.

CPMK-3	Merancang dan melaksanakan asuhan esensial segera setelah persalinan (kala IV) termasuk pencegahan perdarahan dan keselamatan ibu.
CPMK-4	Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning.
CPMK-5	Mengoptimalkan menyusui melalui teknik menyusui, perlekatan efektif, konseling, dan pemecahan masalah laktasi umum.
CPMK-6	Mengidentifikasi dan melakukan tatalaksana awal komplikasi/kegawatdaruratan nifas (perdarahan, infeksi, kesehatan mental) serta menetapkan kriteria rujukan dan kolaborasi.
CPMK-7	Menyusun edukasi, rencana tindak lanjut, dan dokumentasi asuhan nifas–menyusui berbasis bukti dengan komunikasi terapeutik.

Pendahuluan

Masa nifas merupakan periode penting dalam siklus reproduksi wanita yang dimulai segera setelah kelahiran plasenta dan berlangsung hingga sekitar enam minggu setelah persalinan. Periode ini ditandai dengan proses pemulihan fisiologis organ reproduksi serta adaptasi fisik dan psikologis ibu setelah kehamilan dan persalinan. Perubahan yang terjadi selama masa nifas meliputi involusi uterus, pemulihan sistem hormonal, serta penyesuaian terhadap proses laktasi dan peran baru sebagai ibu (Cunningham et al., 2022).

Periode masa nifas memiliki risiko kesehatan yang signifikan bagi ibu dan bayi apabila tidak dilakukan pemantauan yang adekuat. Berbagai komplikasi serius dapat muncul pada masa ini, seperti perdarahan postpartum, infeksi puerperium, gangguan laktasi, hingga gangguan kesehatan mental ibu. Data global menunjukkan bahwa sebagian besar kematian ibu terjadi pada periode setelah persalinan, terutama dalam minggu pertama masa nifas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan ibu setelah persalinan merupakan komponen penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (World Health Organization, 2022).

Pelayanan kesehatan pada masa nifas bertujuan untuk memastikan pemulihan kondisi ibu berlangsung secara optimal serta mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya komplikasi. Pelayanan ini dilakukan melalui kunjungan nifas terjadwal yang mencakup pengkajian kondisi ibu dan bayi, pemantauan parameter klinis, serta pemberian edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan diri dan bayi baru lahir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Kunjungan nifas terjadwal merupakan strategi penting dalam pelayanan kesehatan maternal untuk memantau kondisi ibu secara berkala setelah persalinan. Standar pelayanan kesehatan merekomendasikan beberapa kali kunjungan nifas dalam periode enam minggu pertama setelah persalinan. Kunjungan tersebut memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kondisi fisik ibu, mengevaluasi proses

involusi uterus, memantau tanda vital, menilai kondisi luka persalinan, serta memastikan keberhasilan proses menyusui (Tully & Ball, 2021).

Pemantauan masa nifas tidak hanya berfokus pada kondisi fisik ibu, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi. Adaptasi psikologis setelah persalinan dapat memunculkan berbagai perubahan emosional, mulai dari perasaan bahagia hingga kecemasan atau kelelahan. Identifikasi dini terhadap gangguan psikologis seperti postpartum blues atau depresi postpartum menjadi bagian penting dalam pelayanan masa nifas yang komprehensif (Stewart & Vigod, 2019).

Pengkajian parameter klinis selama kunjungan nifas menjadi dasar dalam menentukan kondisi kesehatan ibu. Parameter yang dinilai meliputi tanda vital, involusi uterus, jumlah dan karakteristik lochia, kondisi payudara, penyembuhan luka perineum atau luka operasi, serta kondisi umum ibu. Penilaian tersebut membantu tenaga kesehatan membedakan kondisi fisiologis normal dengan tanda awal komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut (Fraser & Cooper, 2020).

Deteksi dini risiko merupakan komponen penting dalam pemantauan masa nifas. Tenaga kesehatan perlu memiliki kemampuan melakukan pengkajian klinis secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi pada ibu maupun bayi. Tindakan deteksi dini memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat sehingga dapat mencegah terjadinya kondisi yang lebih serius serta meningkatkan keselamatan ibu dan bayi (World Health Organization, 2022).

Peran bidan dalam pelayanan masa nifas sangat penting karena bidan merupakan tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kebidanan kepada ibu setelah persalinan. Asuhan kebidanan masa nifas mencakup pemantauan kondisi ibu dan bayi, pemberian konseling menyusui, edukasi mengenai perawatan diri dan bayi, serta identifikasi dan penanganan dini terhadap komplikasi yang mungkin terjadi (Marshall & Raynor, 2021).

Pemahaman yang komprehensif mengenai pemantauan masa nifas terjadwal, parameter klinis yang perlu dinilai, serta deteksi dini risiko sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman dan berkualitas. Pengetahuan tersebut membantu tenaga kesehatan melakukan pengkajian secara sistematis, menentukan kondisi normal atau abnormal, serta mengambil keputusan klinis yang tepat dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Bab ini membahas secara sistematis mengenai konsep pemantauan masa nifas terjadwal, jadwal kunjungan nifas, parameter klinis yang perlu dipantau, serta strategi deteksi dini risiko dan komplikasi pada masa nifas. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan memahami prinsip pemantauan masa nifas serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pada periode postpartum.

A. Konsep Pemantauan Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode transisi penting setelah persalinan yang dimulai sejak lahirnya plasenta hingga sekitar enam minggu setelah persalinan. Periode ini ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis pada tubuh ibu yang bertujuan mengembalikan kondisi organ reproduksi dan sistem tubuh lainnya seperti sebelum kehamilan. Proses pemulihan tersebut meliputi involusi uterus, perubahan hormonal, pemulihan sistem kardiovaskular dan metabolik, serta adaptasi terhadap proses laktasi dan peran sebagai ibu (Cunningham et al., 2022).

Pemantauan masa nifas merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan ibu yang bertujuan memastikan bahwa proses pemulihan fisiologis berlangsung secara normal serta mendeteksi secara dini kemungkinan komplikasi. Pemantauan tersebut dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan dan evaluasi kondisi ibu secara berkala setelah persalinan. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan mengidentifikasi perubahan kondisi kesehatan ibu secara cepat sehingga tindakan yang diperlukan dapat segera dilakukan (World Health Organization, 2022).

Periode masa nifas memiliki kerentanan terhadap berbagai komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu maupun bayi. Perdarahan postpartum, infeksi puerperium, tromboemboli, serta gangguan kesehatan mental merupakan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada masa ini. Banyak kasus kematian ibu terjadi pada periode postpartum, terutama dalam minggu pertama setelah persalinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan ibu selama masa nifas memiliki peran penting dalam upaya pencegahan morbiditas dan mortalitas maternal (Say et al., 2019).

Pelayanan pemantauan masa nifas dilakukan melalui kunjungan nifas terjadwal yang bertujuan menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh. Kunjungan nifas memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan fisik, memantau proses involusi uterus, mengevaluasi produksi dan pengeluaran laktasi, menilai kondisi payudara dan keberhasilan menyusui, serta memeriksa penyembuhan luka persalinan atau luka operasi apabila terdapat tindakan bedah. Penilaian tersebut membantu memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung secara normal (Marshall & Raynor, 2021).

Pemantauan masa nifas juga mencakup penilaian kondisi psikologis ibu. Perubahan hormonal, kelelahan setelah persalinan, serta adaptasi terhadap

tanggung jawab baru dapat memengaruhi kondisi emosional ibu. Sebagian ibu dapat mengalami gangguan emosional ringan seperti postpartum blues, sedangkan sebagian lainnya berisiko mengalami depresi postpartum yang memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan. Identifikasi dini terhadap kondisi psikologis ibu menjadi bagian penting dari pelayanan masa nifas yang komprehensif (Stewart & Vigod, 2019).

Selain memantau kondisi ibu, pelayanan masa nifas juga mencakup pemantauan kesehatan bayi baru lahir. Tenaga kesehatan perlu menilai pertumbuhan, pola menyusui, serta tanda bahaya pada bayi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa ibu dan bayi memperoleh pelayanan kesehatan yang berkesinambungan setelah persalinan sebagai bagian dari konsep continuum of care dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (Tully & Ball, 2021).

Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat penting dalam pelaksanaan pemantauan masa nifas. Bidan bertanggung jawab melakukan pengkajian kondisi ibu dan bayi, memberikan edukasi mengenai perawatan diri dan bayi, mendukung keberhasilan menyusui, serta mendeteksi secara dini tanda bahaya yang dapat mengindikasikan komplikasi. Kemampuan bidan dalam melakukan penilaian klinis secara sistematis dan memberikan intervensi yang tepat sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan pada masa nifas (Fraser & Cooper, 2020).

Pemahaman yang baik mengenai konsep pemantauan masa nifas menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman dan berkualitas. Pemantauan yang terstruktur dan berkesinambungan dapat membantu memastikan proses pemulihan ibu berjalan optimal, meningkatkan keberhasilan menyusui, serta mencegah terjadinya komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemantauan masa nifas merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal.

B. Jadwal Kunjungan Nifas Terstandar

Kunjungan nifas merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu setelah persalinan yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi serta mendeteksi secara dini kemungkinan komplikasi. Pemantauan yang dilakukan secara terjadwal memungkinkan tenaga kesehatan mengevaluasi proses pemulihan fisiologis ibu serta memastikan bahwa kebutuhan kesehatan ibu dan bayi terpenuhi dengan baik. Pelayanan kesehatan pada masa nifas tidak hanya berfokus pada kondisi fisik ibu, tetapi juga mencakup pemantauan kesehatan bayi,

keberhasilan menyusui, serta kesiapan ibu dalam menjalani peran baru sebagai orang tua (World Health Organization, 2022).

Standar pelayanan kesehatan maternal merekomendasikan bahwa ibu harus memperoleh pelayanan kesehatan secara berkala selama masa nifas. Kunjungan nifas dilakukan dalam beberapa tahap yang disesuaikan dengan periode pemulihan ibu setelah persalinan. Setiap kunjungan memiliki tujuan dan fokus pemeriksaan yang berbeda sesuai dengan perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh ibu pada periode tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pelaksanaan kunjungan nifas secara terjadwal juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta pencegahan komplikasi postpartum. Pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan tenaga kesehatan mengidentifikasi secara dini adanya gangguan kesehatan sehingga tindakan yang tepat dapat segera dilakukan. Pendekatan ini menjadi salah satu strategi penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu setelah persalinan (Say et al., 2019).

1. Jadwal Kunjungan Nifas

Pelayanan kesehatan pada masa nifas dilakukan melalui beberapa kali kunjungan yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia dan standar pelayanan kesehatan nasional. Kunjungan tersebut dilakukan dalam periode enam minggu pertama setelah persalinan dengan tujuan memantau proses pemulihan ibu serta kondisi bayi baru lahir.

Secara umum, jadwal kunjungan nifas terdiri dari empat kali kunjungan, yaitu:

Kunjungan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan Utama
KF1	6–48 jam setelah persalinan	Memastikan kondisi ibu stabil setelah persalinan, memantau perdarahan, tanda vital, serta kondisi bayi
KF2	Hari ke-3 sampai hari ke-7 setelah persalinan	Menilai involusi uterus, lokia, kondisi luka persalinan, serta keberhasilan menyusui
KF3	Hari ke-8 sampai hari ke-28 setelah persalinan	Memantau proses pemulihan ibu, kesehatan bayi, serta memberikan konseling perawatan ibu dan bayi
KF4	Hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah persalinan	Mengevaluasi pemulihan kesehatan ibu, keberhasilan menyusui, serta memberikan konseling keluarga berencana

Jadwal kunjungan tersebut bertujuan memastikan bahwa ibu memperoleh pelayanan kesehatan secara berkesinambungan sejak awal masa nifas hingga akhir periode postpartum. Kunjungan nifas memberikan kesempatan bagi

tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan fisik ibu, menilai kondisi bayi, serta memberikan edukasi mengenai perawatan diri dan bayi baru lahir (Marshall & Raynor, 2021).

2. Tujuan Kunjungan Nifas

Kunjungan nifas memiliki beberapa tujuan penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, antara lain:

- a. Memantau kondisi kesehatan ibu setelah persalinan.
- b. Mendeteksi secara dini tanda bahaya atau komplikasi pada masa nifas.
- c. Memastikan proses involusi uterus berlangsung secara normal.
- d. Memantau kondisi bayi baru lahir serta keberhasilan menyusui.
- e. Memberikan edukasi mengenai perawatan ibu dan bayi.
- f. Memberikan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Pelaksanaan kunjungan nifas yang terjadwal memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan kepada ibu dan bayi. Pendekatan ini mendukung konsep continuum of care dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas (Tully & Ball, 2021).

3. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kunjungan Nifas

Tenaga kesehatan, terutama bidan, memiliki peran utama dalam pelaksanaan kunjungan nifas. Bidan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kondisi ibu dan bayi, memberikan konseling menyusui, memantau penyembuhan luka persalinan, serta mengidentifikasi tanda bahaya yang dapat mengindikasikan komplikasi. Kemampuan bidan dalam melakukan pengkajian klinis secara tepat dan memberikan intervensi yang sesuai sangat penting dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi pada periode postpartum (Fraser & Cooper, 2020).

Kunjungan nifas juga menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan emosional kepada ibu serta membantu ibu dalam beradaptasi dengan peran barunya. Edukasi yang diberikan selama kunjungan nifas dapat membantu meningkatkan pengetahuan ibu mengenai perawatan diri, perawatan bayi, serta tanda bahaya yang memerlukan pertolongan medis.

Pelaksanaan kunjungan nifas secara terstandar dan berkesinambungan merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas. Pemantauan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan deteksi dini

komplikasi sehingga penanganan yang tepat dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi.

C. Parameter Klinis Pemantauan Ibu Nifas

Pemantauan parameter klinis pada masa nifas merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu setelah persalinan. Penilaian klinis dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemulihan fisiologis ibu berlangsung secara normal serta untuk mendeteksi secara dini kemungkinan komplikasi. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik pada setiap kunjungan nifas. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan menilai kondisi kesehatan ibu secara menyeluruh serta menentukan tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tanda abnormal (Cunningham et al., 2022).

Parameter klinis yang dinilai pada masa nifas mencakup kondisi umum ibu, tanda vital, involusi uterus, karakteristik lokia, kondisi payudara dan proses menyusui, serta penyembuhan luka persalinan. Penilaian terhadap parameter tersebut membantu tenaga kesehatan membedakan kondisi fisiologis normal dari kondisi patologis yang memerlukan intervensi lebih lanjut (Marshall & Raynor, 2021).

1. Kondisi Umum Ibu

Penilaian kondisi umum ibu merupakan langkah awal dalam pemantauan masa nifas. Tenaga kesehatan perlu menilai kesadaran, tingkat kenyamanan, kemampuan mobilisasi, serta kondisi emosional ibu. Kondisi umum yang baik ditandai dengan ibu tampak sadar penuh, mampu melakukan aktivitas ringan, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau gangguan kesehatan yang berat.

Perubahan kondisi umum seperti kelemahan yang berlebihan, pucat, atau kesadaran menurun dapat menjadi indikasi adanya komplikasi seperti perdarahan atau infeksi sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut (Fraser & Cooper, 2020).

2. Tanda Vital

Pemantauan tanda vital merupakan bagian penting dalam pemeriksaan ibu masa nifas. Tanda vital yang dinilai meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan. Nilai tanda vital memberikan gambaran mengenai kondisi fisiologis ibu serta membantu mendeteksi dini adanya gangguan kesehatan.

Peningkatan suhu tubuh dapat mengindikasikan infeksi, sedangkan peningkatan denyut nadi atau penurunan tekanan darah dapat menjadi tanda

perdarahan postpartum. Oleh karena itu, pemantauan tanda vital secara berkala sangat penting dalam pelayanan kesehatan masa nifas (World Health Organization, 2022).

3. Involusi Uterus

Involusi uterus merupakan proses kembalinya ukuran uterus ke kondisi sebelum kehamilan setelah persalinan. Pemantauan involusi uterus dilakukan dengan menilai tinggi fundus uteri serta konsistensi uterus melalui palpasi abdomen.

Pada kondisi normal, tinggi fundus uteri akan menurun secara bertahap setiap hari setelah persalinan. Uterus yang teraba keras menunjukkan kontraksi uterus yang baik. Kondisi uterus yang lembek atau tidak mengalami penurunan ukuran secara normal dapat mengindikasikan adanya subinvolusi atau risiko perdarahan postpartum (Cunningham et al., 2022).

4. Lokia

Lokia merupakan cairan yang keluar dari uterus setelah persalinan yang terdiri dari darah, jaringan desidua, dan lendir. Pemantauan lokia penting untuk menilai proses penyembuhan uterus serta mendeteksi kemungkinan komplikasi.

Perubahan lokia berlangsung secara bertahap selama masa nifas. Pada awal masa nifas lokia berwarna merah (lochia rubra), kemudian berubah menjadi cokelat atau merah muda (lochia serosa), dan akhirnya menjadi putih kekuningan (lochia alba). Perubahan warna dan jumlah lokia yang tidak sesuai dengan tahap pemulihan dapat menjadi indikasi adanya infeksi atau perdarahan (Marshall & Raynor, 2021).

5. Kondisi Payudara dan Proses Menyusui

Penilaian kondisi payudara merupakan bagian penting dalam pemantauan masa nifas karena berkaitan dengan keberhasilan proses menyusui. Pemeriksaan dilakukan dengan menilai bentuk dan kondisi payudara, kondisi puting susu, serta adanya tanda pembengkakan atau nyeri.

Produksi ASI yang baik serta kemampuan bayi menyusui secara efektif merupakan indikator keberhasilan proses laktasi. Kondisi seperti payudara bengkak, mastitis, atau kesulitan menyusui perlu diidentifikasi secara dini agar dapat ditangani dengan tepat (Tully & Ball, 2021).

6. Penyembuhan Luka Persalinan

Penyembuhan luka persalinan perlu dipantau terutama pada ibu yang mengalami episiotomi, robekan perineum, atau operasi sesar. Penilaian dilakukan dengan mengamati kondisi luka, adanya tanda infeksi, serta tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu.

Luka yang sembuh dengan baik biasanya tampak kering, tidak bengkak, dan tidak menunjukkan tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri berlebihan, atau keluarnya cairan bernanah. Identifikasi dini terhadap tanda infeksi luka sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius (Fraser & Cooper, 2020).

7. Kondisi Psikologis Ibu

Perubahan emosional sering terjadi pada masa nifas sebagai akibat dari perubahan hormonal serta adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu. Penilaian kondisi psikologis ibu dilakukan untuk mengidentifikasi adanya gangguan emosional seperti postpartum blues atau depresi postpartum.

Dukungan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting dalam membantu ibu beradaptasi selama masa nifas. Identifikasi dini terhadap gangguan psikologis memungkinkan pemberian dukungan dan intervensi yang tepat untuk menjaga kesejahteraan ibu dan bayi (Stewart & Vigod, 2019).

Pemantauan parameter klinis secara sistematis pada masa nifas merupakan bagian penting dari asuhan kebidanan yang berkualitas. Penilaian yang tepat terhadap kondisi ibu memungkinkan tenaga kesehatan mendeteksi secara dini adanya komplikasi serta memberikan intervensi yang sesuai untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi selama periode postpartum.

D. Pemantauan Bayi Baru Lahir pada Kunjungan Nifas

Pemantauan bayi baru lahir merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada masa nifas. Periode neonatal merupakan fase adaptasi penting bagi bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin menuju kehidupan ektrauterin. Pemantauan kondisi bayi selama kunjungan nifas bertujuan memastikan bahwa proses adaptasi tersebut berlangsung secara normal serta mendeteksi secara dini adanya gangguan kesehatan yang dapat membahayakan bayi (World Health Organization, 2022).

Kunjungan nifas memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi bayi, termasuk pertumbuhan, status kesehatan umum, serta keberhasilan proses menyusui. Pemantauan ini penting karena sebagian besar kematian neonatal terjadi pada minggu pertama

kehidupan. Deteksi dini terhadap masalah kesehatan bayi memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan keselamatan bayi baru lahir (UNICEF, 2021).

Pelayanan kesehatan bayi pada masa nifas juga merupakan bagian dari pendekatan continuum of care dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan periode neonatal. Kunjungan nifas menjadi salah satu kesempatan penting bagi tenaga kesehatan untuk memantau kondisi bayi sekaligus memberikan edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi baru lahir (Marshall & Raynor, 2021).

1. Penilaian Kondisi Umum Bayi

Penilaian kondisi umum bayi dilakukan untuk memastikan bahwa bayi berada dalam kondisi sehat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan luar. Pemeriksaan meliputi tingkat kesadaran, aktivitas bayi, warna kulit, serta respons terhadap rangsangan.

Bayi yang sehat umumnya tampak aktif, memiliki warna kulit kemerahan atau merah muda, serta menunjukkan respons yang baik terhadap rangsangan. Kondisi seperti bayi tampak lemah, tidak aktif, atau menunjukkan perubahan warna kulit seperti kebiruan atau pucat dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan yang memerlukan perhatian medis (Cunningham et al., 2022).

2. Pemantauan Tanda Vital Bayi

Tanda vital bayi merupakan indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan bayi baru lahir. Parameter yang perlu diperiksa meliputi suhu tubuh, frekuensi pernapasan, serta denyut jantung.

Suhu tubuh bayi perlu dipertahankan dalam kondisi normal untuk mencegah hipotermia. Frekuensi pernapasan normal pada bayi baru lahir berkisar antara 30–60 kali per menit. Pernapasan yang terlalu cepat atau disertai tarikan dinding dada dapat menjadi tanda adanya gangguan pernapasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

3. Pemantauan Pertumbuhan dan Berat Badan

Pemantauan berat badan bayi merupakan indikator penting dalam menilai kecukupan asupan nutrisi serta keberhasilan proses menyusui. Penurunan berat badan pada bayi baru lahir dapat terjadi dalam beberapa hari pertama

kehidupan, namun berat badan biasanya kembali meningkat setelah beberapa hari.

Pemantauan berat badan bayi secara berkala membantu tenaga kesehatan memastikan bahwa bayi memperoleh nutrisi yang cukup melalui pemberian air susu ibu. Kenaikan berat badan yang tidak adekuat dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam proses menyusui atau kondisi kesehatan tertentu pada bayi (Tully & Ball, 2021).

4. Pemantauan Proses Menyusui

Proses menyusui merupakan komponen penting dalam pemantauan bayi baru lahir selama masa nifas. Air susu ibu merupakan sumber nutrisi utama yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi pada awal kehidupan.

Tenaga kesehatan perlu menilai posisi dan perlekatan bayi saat menyusui, frekuensi menyusui, serta kemampuan bayi mengisap secara efektif. Masalah dalam proses menyusui seperti kesulitan perlekatan atau frekuensi menyusui yang rendah dapat memengaruhi kecukupan nutrisi bayi sehingga perlu segera ditangani (Victora et al., 2016).

5. Pemeriksaan Tali Pusat

Pemantauan kondisi tali pusat merupakan bagian penting dalam pemeriksaan bayi baru lahir. Tali pusat yang sehat biasanya tampak kering dan tidak menunjukkan tanda infeksi.

Tanda infeksi pada tali pusat dapat berupa kemerahan di sekitar pangkal tali pusat, pembengkakan, keluarnya cairan berbau tidak sedap, atau nyeri pada area tersebut. Identifikasi dini terhadap tanda infeksi sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius seperti sepsis neonatal (World Health Organization, 2022).

6. Deteksi Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir

Deteksi ini terhadap tanda bahaya pada bayi baru lahir merupakan bagian penting dari pemantauan kesehatan bayi selama kunjungan nifas. Beberapa tanda bahaya yang perlu diwaspadai antara lain:

- a. bayi tidak mau menyusui atau menyusui dengan lemah
- b. demam atau suhu tubuh terlalu rendah
- c. napas cepat atau kesulitan bernapas
- d. kejang
- e. kuning pada kulit yang muncul sangat awal atau semakin berat

f. muntah berulang atau diare

Apabila ditemukan salah satu tanda bahaya tersebut, bayi perlu segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut (World Health Organization, 2022). Pemantauan bayi baru lahir selama kunjungan nifas merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang komprehensif. Pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan tenaga kesehatan memastikan bahwa bayi berada dalam kondisi sehat, memperoleh nutrisi yang cukup, serta dapat beradaptasi dengan baik pada awal kehidupan.

E. Tanda Bahaya Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode yang rentan terhadap berbagai komplikasi yang dapat mengancam kesehatan bahkan keselamatan ibu apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Perubahan fisiologis yang terjadi setelah persalinan dapat memicu berbagai gangguan kesehatan apabila proses pemulihan tidak berlangsung secara normal. Oleh karena itu, identifikasi tanda bahaya pada masa nifas menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu untuk memungkinkan deteksi dini dan penanganan segera terhadap kondisi yang berpotensi serius (World Health Organization, 2022).

Tanda bahaya masa nifas merupakan gejala atau kondisi yang menunjukkan adanya gangguan kesehatan yang memerlukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Pengetahuan mengenai tanda bahaya ini perlu dimiliki oleh tenaga kesehatan, ibu, serta keluarga agar dapat segera mencari pertolongan medis apabila terjadi kondisi yang tidak normal selama masa nifas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

1. Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu pada masa nifas. Kondisi ini ditandai dengan keluarnya darah dalam jumlah yang berlebihan setelah persalinan. Perdarahan yang tidak normal dapat terjadi akibat atonia uteri, sisa plasenta, trauma jalan lahir, atau gangguan pembekuan darah.

Perdarahan yang perlu diwaspadai antara lain apabila ibu mengalami pengeluaran darah dalam jumlah banyak, pembalut cepat penuh oleh darah, atau munculnya gumpalan darah yang besar. Kondisi tersebut memerlukan penanganan segera karena dapat menyebabkan syok dan membahayakan keselamatan ibu (Cunningham et al., 2022).

2. Demam atau Infeksi Puerperium

Infeksi puerperium merupakan infeksi yang terjadi pada saluran reproduksi setelah persalinan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masuknya mikroorganisme ke dalam saluran reproduksi selama atau setelah persalinan.

Gejala infeksi pada masa nifas dapat berupa demam, nyeri pada perut bagian bawah, keluarnya lochia yang berbau tidak sedap, serta rasa lemah atau tidak nyaman pada tubuh. Infeksi yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti sepsis sehingga memerlukan penanganan medis yang cepat (Fraser & Cooper, 2020).

3. Nyeri Kepala Berat dan Gangguan Penglihatan

Nyeri kepala berat yang disertai gangguan penglihatan dapat menjadi tanda adanya gangguan tekanan darah seperti preeklampsia postpartum. Kondisi ini dapat terjadi setelah persalinan meskipun sebelumnya ibu tidak memiliki riwayat hipertensi selama kehamilan.

Gejala yang perlu diwaspadai meliputi sakit kepala hebat, pandangan kabur, pusing, serta pembengkakan pada wajah atau ekstremitas. Kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencegah komplikasi yang lebih serius seperti kejang (Marshall & Raynor, 2021).

4. Nyeri Perut Hebat

Nyeri perut hebat yang terjadi pada masa nifas dapat mengindikasikan adanya komplikasi seperti infeksi uterus, retensi sisa plasenta, atau gangguan lain pada organ reproduksi. Nyeri yang berlangsung terus-menerus atau semakin memburuk perlu mendapatkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan penyebab nyeri serta memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi ibu (Cunningham et al., 2022).

5. Tanda Infeksi pada Luka Persalinan

Ibu yang mengalami episiotomi, robekan perineum, atau operasi sesar berisiko mengalami infeksi pada luka persalinan. Tanda infeksi pada luka dapat berupa kemerahan, pembengkakan, nyeri yang semakin meningkat, serta keluarnya cairan bernanah dari luka.

Pemantauan kondisi luka secara berkala sangat penting untuk memastikan proses penyembuhan berjalan dengan baik. Apabila ditemukan

tanda infeksi, ibu perlu segera mendapatkan penanganan medis untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut (Fraser & Cooper, 2020).

6. Gangguan Psikologis pada Masa Nifas

Perubahan emosional merupakan hal yang umum terjadi pada masa nifas sebagai akibat dari perubahan hormonal dan adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu. Sebagian ibu dapat mengalami kondisi emosional ringan seperti postpartum blues yang biasanya bersifat sementara.

Gejala yang lebih berat seperti perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi dapat mengindikasikan depresi postpartum. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat dari tenaga kesehatan (Stewart & Vigod, 2019).

7. Sesak Napas atau Nyeri Dada

Sesak napas atau nyeri dada pada masa nifas dapat menjadi tanda adanya komplikasi serius seperti emboli paru atau gangguan kardiovaskular lainnya. Kondisi ini merupakan keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera di fasilitas kesehatan.

Identifikasi dini terhadap gejala tersebut sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu (World Health Organization, 2022).

Pengenalan tanda bahaya masa nifas merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan ibu setelah persalinan. Tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai gejala-gejala yang perlu diwaspadai selama masa nifas. Edukasi tersebut membantu meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga untuk segera mencari pertolongan medis apabila muncul tanda bahaya sehingga komplikasi dapat dicegah atau ditangani secara lebih cepat dan efektif.

F. Deteksi Dini Risiko dan Komplikasi Masa Nifas

Deteksi dini risiko dan komplikasi pada masa nifas merupakan langkah penting dalam pelayanan kesehatan ibu setelah persalinan. Masa nifas merupakan periode yang rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan karena tubuh ibu sedang mengalami proses pemulihan dari perubahan fisiologis selama kehamilan dan persalinan. Identifikasi dini terhadap faktor risiko dan tanda awal komplikasi memungkinkan tenaga kesehatan melakukan intervensi secara cepat dan tepat

sehingga dapat mencegah terjadinya kondisi yang lebih serius (World Health Organization, 2022).

Deteksi dini dilakukan melalui pengkajian klinis yang sistematis selama kunjungan nifas. Pengkajian tersebut meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, serta evaluasi parameter klinis ibu dan bayi. Tenaga kesehatan perlu memperhatikan berbagai perubahan kondisi yang terjadi pada ibu, termasuk perubahan tanda vital, kondisi uterus, jumlah dan karakteristik lochia, penyembuhan luka persalinan, serta kondisi umum ibu. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah proses pemulihan berlangsung secara normal atau terdapat indikasi komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut (Marshall & Raynor, 2021).

Faktor risiko tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada masa nifas. Beberapa faktor tersebut antara lain riwayat perdarahan postpartum, anemia selama kehamilan, persalinan dengan tindakan operatif, persalinan lama, serta adanya penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes. Ibu dengan faktor risiko tersebut memerlukan pemantauan yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya komplikasi selama masa nifas (Cunningham et al., 2022).

Deteksi dini juga dilakukan dengan mengidentifikasi tanda awal komplikasi yang dapat muncul pada masa nifas. Komplikasi yang sering terjadi pada periode ini meliputi perdarahan postpartum, infeksi puerperium, subinvolusi uterus, mastitis, tromboemboli, serta gangguan kesehatan mental seperti depresi postpartum. Pengkajian yang dilakukan secara sistematis memungkinkan tenaga kesehatan mengenali tanda awal komplikasi tersebut sebelum kondisi menjadi lebih berat (Fraser & Cooper, 2020).

Pendekatan deteksi dini dalam pelayanan masa nifas juga melibatkan pemberian edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya yang perlu diwaspadai setelah persalinan. Pengetahuan ibu dan keluarga mengenai gejala yang tidak normal sangat penting untuk memastikan bahwa pertolongan medis dapat segera diperoleh apabila terjadi kondisi yang mengkhawatirkan. Edukasi tersebut mencakup informasi mengenai perdarahan yang berlebihan, demam tinggi, nyeri perut hebat, kesulitan bernapas, serta gangguan emosional yang berkepanjangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat penting dalam pelaksanaan deteksi dini risiko dan komplikasi masa nifas. Bidan bertanggung jawab melakukan pengkajian kondisi ibu secara menyeluruh, memberikan konseling mengenai perawatan diri dan bayi, serta menentukan kebutuhan rujukan apabila ditemukan tanda bahaya atau komplikasi. Keputusan klinis yang tepat dan

cepat sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayi pada periode postpartum (Marshall & Raynor, 2021).

Deteksi dini risiko dan komplikasi pada masa nifas juga berkaitan erat dengan sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan maternal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, tenaga kesehatan perlu segera merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan yang lebih lengkap. Sistem rujukan yang efektif memungkinkan ibu memperoleh penanganan yang tepat waktu sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius (World Health Organization, 2022).

Pemantauan masa nifas yang dilakukan secara terstruktur melalui kunjungan nifas terjadwal, pemeriksaan parameter klinis, serta deteksi dini risiko merupakan bagian penting dari asuhan kebidanan yang berkualitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan ibu setelah persalinan, tetapi juga mendukung kesejahteraan bayi dan keluarga secara keseluruhan. Upaya deteksi dini yang dilakukan secara konsisten oleh tenaga kesehatan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu pada periode postpartum.

G. Aktivitas 1 — Knows How

Topik: Pemantauan Masa Nifas Terjadwal, Parameter Klinis, dan Deteksi Dini Risiko

Mini-case

Seorang perempuan, usia 28 tahun, P1A0, hari ke-5 masa nifas, datang ke Puskesmas untuk kunjungan nifas (KF2).

Hasil anamnesis:

Ibu mengeluh badan terasa lemas, sedikit demam sejak kemarin, dan nyeri pada perut bagian bawah. Ibu juga mengatakan lokia berbau tidak sedap. Menyusui masih dilakukan, tetapi ibu merasa produksi ASI berkurang.

Hasil pemeriksaan:

TD 110/70 mmHg, N 102 x/menit, S 38,2°C, P 22 x/menit.

TFU masih setinggi pusat, uterus teraba agak lembek.

Lokia berwarna kecoklatan, jumlah sedang, berbau.

Luka perineum tampak kemerahan.

Tugas Mahasiswa (Knows How)

1. Analisis hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik
 - a. Identifikasi parameter klinis yang tidak normal pada masa nifas
2. Tentukan kemungkinan diagnosis/masalah kebidanan
 - a. Jelaskan dasar klinis dari masalah yang ditemukan
3. Jelaskan apakah kondisi ini termasuk fisiologis atau patologis
 - a. Sertakan alasan berbasis parameter nifas
4. Identifikasi faktor risiko atau tanda bahaya masa nifas pada kasus
5. Susun rencana tindak lanjut awal
 - a. Monitoring
 - b. Edukasi
 - c. Indikasi kolaborasi/rujukan.

SOAL CBT – MINI CASE (MASA NIFAS)

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	2
2	Judul	Pemantauan Masa Nifas Terjadwal dan Deteksi Dini Risiko
3	Kasus	Pengkajian ibu nifas hari ke-5 dengan keluhan demam dan lokia abnormal
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu menganalisis kondisi ibu masa nifas, mengidentifikasi tanda bahaya, dan menentukan tindakan yang tepat
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik 3. Analisis masalah/diagnosis 4. Penatalaksanaan awal 5. KIE/konseling 6. Rujukan 7. Profesionalisme
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 26 tahun, P1A0, hari ke-5 postpartum datang ke PMB dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Ibu mengeluh lemas dan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis: a. Persalinan normal 5 hari yang lalu b. ASI keluar, bayi menyusu c. Lokia berbau tidak sedap d. Tidak ada riwayat penyakit kronis Hasil pemeriksaan: a. TD: 100/70 mmHg b. Nadi: 104 x/menit c. Suhu: 38,5°C d. TFU masih tinggi, uterus lembek e. Lokia rubra, berbau TUGAS 1. Identifikasi masalah pada kasus di atas 2. Tentukan diagnosis/masalah kebidanan 3. Jelaskan tanda bahaya yang ditemukan 4. Tentukan penatalaksanaan awal 5. Tentukan kebutuhan rujukan

		6. Berikan edukasi kepada ibu
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai 2. Penilaian berdasarkan jawaban CBT 3. Tidak diperbolehkan memberi bantuan INSTRUKSI KHUSUS 1. Diagnosis yang diharapkan: → Infeksi puerperium (endometritis) 2. Tanda bahaya: a. Demam >38°C b. Lokia berbau c. Nyeri abdomen d. Takikardia 3. Penatalaksanaan: a. Stabilisasi awal b. Observasi tanda vital c. Pemberian cairan d. Rujukan 4. Edukasi: a. Tanda bahaya nifas b. Pentingnya control c. Kebersihan diri
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Tidak diperlukan (CBT berbasis soal tulis)
9	Dialog PS	Tidak ada (CBT)
10	Kebutuhan manikin	Tidak ada
11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan soal CBT 2. Mengatur waktu ujian
12	Kebutuhan alat	1. Komputer/lembar soal 2. Alat tulis
13	Penulis	—
14	Referensi	1. World Health Organization. (2022). <i>WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn</i> . WHO.

		2.Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). <i>Williams Obstetrics</i> (26th ed.). McGraw-Hill. 3.Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2020). <i>Myles Textbook for Midwives</i> (17th ed.). Elsevier. 4.Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2021). <i>Myles Textbook for Midwives</i> (17th ed.). Elsevier. 5.Stewart, D. E., & Vigod, S. (2019). Postpartum depression. <i>New England Journal of Medicine</i>, 381(22), 2127–2136. 6.Tully, K. P., & Ball, H. L. (2021). Postnatal care practices. <i>Maternal & Child Nutrition</i>, 17(2). 7.Say, L., et al. (2019). Global causes of maternal death. <i>The Lancet Global Health</i>, 7(2), e113–e125. 8.Victora, C. G., et al. (2016). Breastfeeding in the 21st century. <i>The Lancet</i>, 387(10017), 475–490.
--	--	---

H. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 2: Pemantauan Masa Nifas dan Deteksi Dini Risiko

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (demam, nyeri, lokia)		
2. Waktu postpartum (hari ke berapa)		
3. Riwayat persalinan (normal/tindakan/komplikasi)		
4. Pola pengeluaran lokia (warna, jumlah, bau)		
5. Keluhan nyeri perut atau uterus		
6. Riwayat menyusui (lancar/tidak, keluhan payudara)		
7. Riwayat penyakit/komplikasi (anemia, infeksi, dll)		
8. Kondisi umum & aktivitas ibu (lemas, nafsu makan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

3 = Melakukan semua 8 langkah dengan benar

2 = Melakukan 5–7 langkah dengan benar

1 = Melakukan 1–4 langkah dengan benar

0 = Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

1. Persiapan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyapa klien dengan sopan		
b. Memperkenalkan diri		
c. Menjelaskan tujuan pemeriksaan		
d. Meminta persetujuan		
e. Menjaga privasi		
f. Hand hygiene		
g. Menyiapkan alat pemeriksaan		

2. Langkah-langkah

Komponen	Skoring	Skor
a. Menilai kondisi umum ibu		
b. Mengukur tanda vital (TD, nadi, suhu, RR)		
c. Menilai involusi uterus (TFU, konsistensi)		
d. Menilai lokia (warna, jumlah, bau)		
e. Menilai kondisi payudara & menyusui		

f. Menilai luka perineum/operasi		
g. Mengidentifikasi tanda bahaya nifas		
h. Menentukan masalah/diagnosis (misal infeksi)		
i. Menentukan penatalaksanaan awal		
j. Melakukan stabilisasi awal (posisi, cairan, dll)		
k. Menentukan kebutuhan rujukan		
l. Menyusun rencana pemantauan lanjutan		
m. Melakukan dokumentasi klinis		

3. Pasca Tindakan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyimpulkan hasil pemeriksaan		
b. Menjelaskan rencana tindak lanjut		
c. Merapikan alat & hand hygiene		

Skoring KOMPETENSI 2

3 = Melakukan 15–20 langkah dengan tepat & sistematis

2 = Melakukan 10–14 langkah dengan cukup tepat

1 = Melakukan 1–9 langkah

0 = Tidak melakukan / tidak tepat

KOMPETENSI 3. KIE / Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tanda bahaya masa nifas		
4. Menjelaskan perawatan diri & kebersihan		
5. Memberi kesempatan bertanya		
6. Menjawab dengan jelas dan empatik		

Skoring KOMPETENSI 3

3 = 6 langkah benar

2 = 4–5 langkah benar

1 = 1–3 langkah benar

0 = Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		

2. Menjaga privasi pasien		
3. Empati terhadap ibu		
4. Komunikasi jelas & tenang		
5. Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

3 = 5 langkah benar

2 = 4 langkah benar

1 = 1–3 langkah benar

0 = Tidak melakukan

TOTAL SKOR = (K1 + K2 + K3 + K4) / 3

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),.....

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
pada Pemantauan Masa Nifas Terjadwal, Parameter Klinis, dan Deteksi Dini Risiko

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Masa Nifas
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam praktik klinik. Penilai mengamati tindakan mahasiswa pada pasien nyata atau simulasi, kemudian memberikan umpan balik segera. Domain yang dinilai meliputi komunikasi, informed consent, persiapan, keterampilan klinis, keselamatan pasien, dan profesionalisme.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan kunjungan nifas, mulai dari anamnesis, pemeriksaan parameter klinis ibu, hingga deteksi dini tanda bahaya dan pemberian edukasi kepada ibu.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas yang aman, sistematis, dan berpusat pada ibu (woman-centered care), serta mampu mendeteksi dini risiko dan komplikasi. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip evidence-based practice dan patient safety.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan tentang masa nifas, tetapi dari kemampuannya melakukan pengkajian klinis, membedakan kondisi normal dan abnormal, serta mengambil keputusan tindak lanjut secara tepat.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran, khususnya pemantauan masa nifas, penilaian parameter klinis, dan deteksi dini komplikasi postpartum.	Seorang ibu usia 26 tahun, P1A0, hari ke-4 postpartum datang untuk kunjungan nifas. Ibu mengeluh demam ringan, lokia berbau, dan nyeri perut bawah.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan tindakan klinik secara langsung, meliputi komunikasi awal, anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi data, serta	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan anamnesis, memeriksa tanda vital,

	edukasi. Aktivitas mencerminkan integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.	menilai involusi uterus dan lokia, mengidentifikasi kemungkinan infeksi puerperium, serta memberikan edukasi dan rencana rujukan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi: kemampuan anamnesis, ketepatan pemeriksaan parameter klinis, interpretasi hasil, kemampuan deteksi dini risiko, komunikasi (KIE), keselamatan pasien, serta profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan demam, lokia berbau, dan nyeri abdomen sebagai tanda infeksi serta menentukan perlunya eskalasi atau rujukan.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi adalah performa nyata mahasiswa dalam melakukan asuhan nifas secara sistematis, aman, dan efektif, serta kemampuan clinical reasoning dalam pengambilan keputusan.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan pemeriksaan secara lengkap, mengenali tanda bahaya dengan cepat, serta mengambil keputusan klinis yang tepat tanpa menunda.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, mencakup kelebihan dan area yang perlu ditingkatkan. Bersifat spesifik, konstruktif, dan mendukung pembelajaran.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam pemeriksaan fisik, tetapi perlu meningkatkan ketelitian dalam interpretasi lokia atau kecepatan dalam pengambilan keputusan rujukan.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi: kompeten, perlu supervisi, atau remedial, berdasarkan ketepatan tindakan, keselamatan pasien, komunikasi, dan keputusan klinis.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan pengkajian nifas secara lengkap dan mendeteksi komplikasi dengan tepat. Perlu

		supervisi jika masih ragu dalam keputusan. Remedial jika gagal mengenali tanda bahaya.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level "does" dalam taksonomi Miller. Penilaian ini menilai performa nyata mahasiswa dalam praktik klinik secara langsung.	Pada kasus masa nifas, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu melakukan pemantauan, deteksi dini risiko, serta mengambil keputusan klinis secara aman dan profesional di lapangan.

I. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Pemantauan Masa Nifas Terjadwal, Parameter Klinis, dan Deteksi Dini Risiko

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Masa Nifas
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya satu kali ujian.	Pada topik masa nifas, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan kunjungan nifas, menilai parameter klinis ibu dan bayi, mendeteksi dini risiko, serta memberikan edukasi secara konsisten.
Tujuan portofolio	Bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan pernah melakukan kunjungan nifas, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam pengkajian klinis dan deteksi dini komplikasi setelah mendapat umpan balik.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting karena memberikan bukti keterampilan terstruktur dan performa nyata di praktik klinik.	OSCE memuat keterampilan pemeriksaan nifas (tanda vital, involusi uterus, lokia). DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa melakukan kunjungan nifas dan deteksi dini risiko pada ibu.

Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus pasien meliputi data penting, masalah kebidanan, tindakan, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu hari ke-4 postpartum dengan demam dan lokia berbau, dilakukan pemeriksaan, dicurigai infeksi puerperium, dan direncanakan rujukan.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini infeksi, pemantauan tanda vital, serta tidak menunda rujukan pada ibu nifas dengan tanda bahaya.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen sebagai bukti pembinaan dan perbaikan kompetensi.	CI menilai mahasiswa sudah baik dalam pemeriksaan fisik, namun perlu meningkatkan ketelitian interpretasi data klinis dan kecepatan pengambilan keputusan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan, menekankan konsistensi performa, bukan penilaian sekali selesai.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kunjungan nifas, sehingga terlihat konsistensi dalam melakukan pengkajian dan deteksi dini risiko.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mempertahankan mutu performa pada berbagai situasi klinik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi terlihat mahasiswa konsisten mampu melakukan pemantauan nifas dan mengenali tanda bahaya.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai secara nyata dan berulang dalam praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori masa nifas, tetapi mampu menerapkan pemantauan dan deteksi dini risiko secara konsisten dalam praktik.

Tabel. Case Report pada Pemantauan Masa Nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Masa Nifas
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien sebagai bukti kemampuan analisis klinis mahasiswa.	Mahasiswa menyusun laporan ibu nifas dengan keluhan demam dan lokia berbau.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data, analisis masalah, tindakan, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan dugaan infeksi puerperium dan rencana penanganan.
Isi laporan	Identitas pasien, data subjektif-objektif, analisis, diagnosis, tindakan, evaluasi.	Data: demam, lokia berbau → analisis infeksi → tindakan → rujukan → evaluasi.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis, dan keputusan klinis.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan tepat.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi klinis.	Mahasiswa belajar pentingnya interpretasi parameter klinis nifas.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke praktik nyata secara sistematis.	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep masa nifas dalam kasus nyata.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Masa Nifas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Masa Nifas
Hakikat refleksi	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko dan mencegah kesalahan klinis.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini komplikasi masa nifas.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran keselamatan pasien dalam praktik kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan deteksi dapat berakibat fatal.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko: infeksi, perdarahan, keterlambatan rujukan.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Demam tidak terdeteksi, lokia abnormal diabaikan, tanda vital tidak dipantau.

Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Pemantauan rutin, edukasi ibu, deteksi dini, rujukan tepat waktu.
Pembelajaran mahasiswa	Hal yang dipelajari dan perbaikan praktik ke depan.	Mahasiswa belajar pentingnya pengkajian sistematis dan keputusan cepat.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu meningkatkan kualitas asuhan nifas secara berkelanjutan.

J. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pemantauan Masa Nifas Terjadwal, Parameter Klinis, dan Deteksi Dini Risiko

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam banyak, pembalut cepat penuh, atau terdapat bekuan darah besar	Mengarah pada perdarahan postpartum yang dapat menyebabkan syok	Segera nilai kondisi ibu, lakukan stabilisasi awal, lapor pembimbing/dokter, rujuk emergensi
Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ disertai lokia berbau	Kecurigaan infeksi puerperium	Lapor segera, lakukan evaluasi klinis lengkap, siapkan rujukan dan terapi sesuai kewenangan
Uterus lembek atau tidak mengalami involusi sesuai hari nifas	Risiko atonia uteri atau subinvolusi	Lakukan stimulasi kontraksi (sesuai kewenangan), evaluasi penyebab, kolaborasi/rujuk
Lokia tidak sesuai tahap (tetap merah banyak atau kembali merah setelah serosa/alba)	Kemungkinan perdarahan sekunder atau infeksi	Evaluasi segera, pantau ketat, lapor dan rujuk bila perlu
Nyeri perut hebat dan menetap	Dapat mengarah pada infeksi, retensi sisa plasenta, atau komplikasi lain	Lakukan pengkajian cepat, lapor pembimbing, rujuk segera
Tanda infeksi luka (kemerahan, bengkak, nyeri, keluar cairan bernanah)	Infeksi luka perineum atau luka operasi	Lakukan perawatan luka awal, lapor, dan rujuk jika berat
Tekanan darah tinggi disertai sakit kepala hebat atau gangguan penglihatan	Kecurigaan preeklampsia postpartum	Segera evaluasi, lapor, dan rujuk untuk penanganan lanjutan

Ibu tampak sangat lemah, pucat, takikardi, atau penurunan kesadaran	Tanda syok atau komplikasi serius	Lakukan resusitasi awal sesuai kewenangan, panggil bantuan, rujuk emergensi
Payudara sangat nyeri, bengkak, disertai demam	Mastitis atau abses payudara	Edukasi dan penanganan awal, kolaborasi, rujuk bila tidak membaik
Ibu tidak mau menyusui atau bayi tidak mendapat ASI cukup	Risiko gangguan laktasi dan nutrisi bayi	Lakukan konseling menyusui, evaluasi perlekatan, tindak lanjut/rujuk bila perlu
Ibu tampak sedih berkepanjangan, cemas berlebihan, atau ada pikiran menyakiti diri/bayi	Kecurigaan depresi postpartum	Lakukan pendekatan suportif, lapor, dan rujuk ke layanan kesehatan mental
Sesak napas atau nyeri dada	Kecurigaan emboli paru atau gangguan kardiovaskular	Tindakan emergensi, rujuk segera
Keputusan rujukan sudah ada tetapi tertunda	Meningkatkan risiko komplikasi dan kematian	Aktifkan sistem rujukan segera, lakukan stabilisasi, komunikasi dengan keluarga dan fasilitas penerima

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab : Pemantauan Masa Nifas Terjadwal, Parameter Klinis, dan Deteksi Dini Risiko

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep masa nifas dan pentingnya pemantauan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan kunjungan nifas	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menyebutkan jadwal kunjungan nifas (KF1–KF4)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan anamnesis pada ibu nifas secara sistematis	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai kondisi umum ibu (kesadaran, aktivitas, keluhan)	☐	☐	_____

6	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan tanda vital (TD, nadi, suhu, RR)	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai involusi uterus (TFU dan kontraksi)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menilai lokia (warna, jumlah, bau)	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menilai kondisi payudara dan proses menyusui	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menilai penyembuhan luka perineum atau luka operasi	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menilai kondisi psikologis ibu nifas	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya masa nifas	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melakukan deteksi dini risiko komplikasi (perdarahan, infeksi, dll)	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa memberikan edukasi perawatan ibu nifas	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa memberikan edukasi perawatan bayi baru lahir	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa memberikan edukasi tanda bahaya (red flags) kepada ibu	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menyusun rencana tindak lanjut dan kunjungan berikutnya	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa menentukan indikasi rujukan pada ibu nifas	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik dengan ibu dan keluarga	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa menjaga keselamatan pasien dan perilaku profesional	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan nifas secara lengkap dan sistematis	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

K. Rangkuman Materi

Masa nifas merupakan periode setelah persalinan yang berlangsung sejak lahirnya plasenta hingga sekitar enam minggu postpartum. Periode ini ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis pada tubuh ibu yang bertujuan mengembalikan kondisi organ reproduksi dan sistem tubuh lainnya seperti sebelum kehamilan. Proses pemulihan tersebut meliputi involusi uterus, perubahan hormonal, serta adaptasi terhadap proses laktasi dan peran baru sebagai ibu.

Pemantauan masa nifas merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan maternal yang bertujuan memastikan proses pemulihan ibu berlangsung secara normal serta mendeteksi secara dini kemungkinan komplikasi. Pemantauan dilakukan melalui kunjungan nifas terjadwal yang memungkinkan tenaga kesehatan melakukan evaluasi kondisi ibu dan bayi secara berkala. Kunjungan nifas juga memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan diri, perawatan bayi baru lahir, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai.

Standar pelayanan kesehatan merekomendasikan empat kali kunjungan nifas selama enam minggu pertama setelah persalinan. Kunjungan tersebut meliputi kunjungan pertama pada 6–48 jam setelah persalinan, kunjungan kedua pada hari ke-3 hingga hari ke-7, kunjungan ketiga pada hari ke-8 hingga hari ke-28, serta kunjungan keempat pada hari ke-29 hingga hari ke-42. Setiap kunjungan memiliki tujuan tertentu dalam memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi serta memastikan proses pemulihan berjalan secara optimal.

Pemantauan kondisi ibu pada masa nifas dilakukan melalui pemeriksaan parameter klinis yang meliputi kondisi umum ibu, tanda vital, involusi uterus, karakteristik lochia, kondisi payudara, serta penyembuhan luka persalinan. Penilaian terhadap parameter klinis tersebut membantu tenaga kesehatan membedakan kondisi fisiologis normal dengan kondisi abnormal yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pemantauan masa nifas juga mencakup pemeriksaan kondisi bayi baru lahir. Penilaian dilakukan terhadap kondisi umum bayi, tanda vital, berat badan, proses menyusui, serta kondisi tali pusat. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa bayi mampu beradaptasi dengan baik pada awal kehidupan serta memperoleh nutrisi yang cukup melalui pemberian air susu ibu.

Tanda bahaya pada masa nifas perlu dikenali secara dini untuk mencegah terjadinya komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu. Beberapa tanda bahaya yang perlu diwaspadai antara lain perdarahan postpartum, demam atau infeksi puerperium, nyeri kepala berat disertai gangguan penglihatan, nyeri perut

hebat, infeksi pada luka persalinan, gangguan psikologis, serta sesak napas atau nyeri dada.

Deteksi dini risiko dan komplikasi masa nifas dilakukan melalui pengkajian klinis yang sistematis selama kunjungan nifas. Tenaga kesehatan perlu mengidentifikasi faktor risiko yang dimiliki oleh ibu serta memantau perubahan kondisi kesehatan yang dapat mengindikasikan adanya komplikasi. Penatalaksanaan yang cepat dan tepat serta sistem rujukan yang efektif sangat penting untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi pada periode postpartum.

Pemantauan masa nifas yang dilakukan secara terstruktur melalui kunjungan nifas terjadwal, pemeriksaan parameter klinis, serta deteksi dini risiko merupakan bagian penting dari asuhan kebidanan yang berkualitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan ibu setelah persalinan, tetapi juga mendukung kesejahteraan bayi dan keluarga secara keseluruhan serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu pada periode postpartum.

L. Daftar Pustaka

-
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2020). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir*. Kementerian Kesehatan RI.
- Marshall, J., & Raynor, M. (2021). *Myles textbook for midwives* (18th ed.). Elsevier.
- Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A. B., Daniels, J., Gülmezoglu, A. M., Temmerman, M., & Alkema, L. (2019). Global causes of maternal death: A WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 7(3), e323–e333. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30497-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30497-9)
- Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2019). Postpartum depression: Pathophysiology, treatment, and emerging therapeutics. *Annual Review of Medicine*, 70, 183–196. <https://doi.org/10.1146/annurev-med-041217-011106>
- Tully, K. P., & Ball, H. L. (2021). Maternal and newborn care in the postpartum period. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 66(2), 219–229. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13224>
- UNICEF. (2021). *Levels and trends in child mortality: Report 2021*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org>
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J., França, G. V., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). *Breastfeeding in the 21st*

century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)

World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization. <https://www.who.int/publications>

BAB 4

LAKTASI DAN PRODUKSI ASI: FISILOGI, TEKNIK MENYUSUI, DAN PELEKATAN EFEKTIF

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi interprofesional dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyimpulkan status kesehatan ibu nifas dan menyusui.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan nifas dan menyusui secara aman dan bermutu, termasuk stabilisasi awal dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menghasilkan dokumentasi asuhan, edukasi/konseling, dan penggunaan bukti ilmiah dasar untuk peningkatan mutu.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Mengoptimalkan menyusui melalui teknik menyusui, pelekatan efektif, konseling, dan pemecahan masalah laktasi umum.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Laktasi dan Produksi ASI: Fisiologi, Teknik Menyusui, dan Pelekatan Efektif	6.1 Menganalisis mekanisme produksi ASI dan faktor yang memengaruhi (hormonal, frekuensi, teknik, kondisi ibu-bayi).	6.2 Mendemonstrasikan teknik menyusui dan pelekatan efektif serta mengevaluasi tanda kecukupan menyusui.	CPMK-5	CPMK-2

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	OSCE teknik menyusui & konseling; Penilaian performa/video	Pelekatan/posisi efektif ($\geq 85\%$ kriteria terpenuhi); Solusi masalah laktasi sesuai penyebab dan tingkat keparahan; Komunikasi konseling empatik dan terstruktur	15	Checklist OSCE; video/demonstrasi; lembar konseling

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**Rubrik CPMK-5**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Teknik menyusui & pelekatan efektif	Posisi/pelekatan salah; tidak dapat menunjukkan tanda efektif.	Posisi/pelekatan cukup namun masih ada kesalahan yang mengganggu efektivitas.	Posisi/pelekatan benar; menunjukkan tanda efektivitas menyusui.	Teknik sangat tepat; mampu mengoreksi kesalahan; evaluasi kecukupan menyusui sangat baik.

Uraian Materi

Menyusui merupakan proses alamiah bagi setiap mamalia termasuk manusia. Menyusui dan air susu ibu (ASI) merupakan standar normatif untuk pemberian makanan dan gizi bayi. Keuntungan menyusui dalam bidang medis dan perkembangan saraf dalam jangka pendek dan jangka panjang menjadikan pemberian ASI sebagai suatu keharusan bagi kesehatan masyarakat (Meek and Noble, 2022).

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa ASI (Air Susu Ibu) merupakan satu-satunya makan terbaik bagi bayi, terutama pada enam bulan pertama kehidupan. Bayi yang mendapatkan ASI lebih terjamin pemenuhan nutrisinya dan juga pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, serta mengandung antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit. ASI diakui sebagai nutrisi paling ideal bagi bayi karena mengandung zat gizi esensial, komponen imunologis, hormon, dan faktor pertumbuhan yang tidak dapat ditiru sepenuhnya oleh produk pengganti ASI. Pemberian ASI, terutama ASI eksklusif selama enam bulan pertama, telah terbukti menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, meningkatkan perkembangan kognitif, serta memberikan perlindungan bagi ibu terhadap berbagai penyakit.

Manfaat menyusui tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu. Meskipun banyak manfaat yang diketahui, praktik menyusui di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi, mitos dan kepercayaan yang keliru, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang mendukung menyusui sering kali menjadi penghambat, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menyusui serta memberikan dukungan yang memadai bagi ibu menyusui sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mendukung peningkatan angka menyusui dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

A. Fisiologi Laktasi

Menyusui/ laktasi memiliki 2 pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran. Menurut (Rejeki, 2019) proses pembentukan payudara dimulai sejak usia 16 minggu kehamilan, dan terbagi menjadi 3 tahap yaitu: 1.) Laktogenesis I. Tahap ini dimulai selama kehamilan dan melibatkan persiapan kelenjar susu untuk produksi susu. Hormon seperti estrogen, progesteron, dan prolaktin merangsang perkembangan sel dan saluran yang mensekresi susu (alveoli). Pada fase ini, payudara mengalami perubahan struktural namun belum memproduksi ASI. Pada tahap ini payudara mulai sekeresi dan produksi ASI. Pengeluaran kolostrum selama masa kehamilan atau sebelum persalinan bukanlah suatu masalah medis dan tidak

menunjukkan banyak atau sedikitnya produksi ASI nantinya, 2.) Laktogenesis II. Tahap ini dimulai setelah melahirkan dan melibatkan permulaan sekresi susu. Tingkat estrogen dan progesteron turun setelah melahirkan, yang memungkinkan prolaktin merangsang produksi ASI. Produksi ASI meningkat, dan ASI “keluar” biasanya dalam beberapa hari pascapersalinan. Hormon prolaktin yang keluar dapat menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI, hormon prolaktin juga akan keluar dalam ASI. Level prolaktin dalam susu akan lebih tinggi apabila produksi ASI lebih banyak, yaitu pada pukul 2 pagi sampai 6 pagi, akan tetapi kadar prolaktin akan menurun jika payudara terasa penuh. Secara fisiologis, penanda biokimia menunjukkan bahwa Laktogenesis II dimulai sekitar 30–40 jam setelah persalinan, namun sebagian besar ibu baru merasakan payudara terasa penuh pada 50–73 jam postpartum. Pada hari-hari pertama, bayi mengonsumsi kolostrum yang mengandung kadar sel imun dan antibodi yang tinggi, terutama IgA, yang berfungsi melapisi usus bayi, melindungi dari infeksi, serta mencegah terjadinya alergi makanan, 3.) Laktogenesis III. Tahap ini mengacu pada kelanjutan produksi dan pengaturan suplai susu sebagai respons terhadap kebutuhan bayi yang biasanya biasanya dimulai hari ke-10 hingga seterusnya. Produksi ASI diatur oleh isapan bayi, yang merangsang pelepasan prolaktin dan oksitosin, yang menyebabkan produksi dan pengeluaran ASI terus berlanjut. Produksi ASI selama kehamilan dan beberapa hari setelah melahirkan diatur oleh sistem kontrol hormon endokrin. Pada saat produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Semakin banyak ASI dikeluarkan, maka produksi ASI semakin banyak pula, karena bila bayi semakin sering disusui maka produksi ASI semakin banyak.

B. Reflek Menyusui

Pada proses menyusui terjadi 2 reflek yang berperan dalam memperkuat kelancaran menyusui, yaitu reflek prolaktin dan reflek aliran. Pertama, reflek prolaktin yang berlangsung ketika bayi menghisap puting susu ibu, dimana akan menimbulkan rangsangan pada ujung-ujung saraf di daerah puting susu dan akan diteruskan ke sumsum tulang belakang kemudian ke otak, yaitu hipotalamus. Di hipotalamus akan terjadi penurunan Prolactine Inhibitory Hormone (PIH) yaitu hormon yang menghambat pelepasan prolaktin oleh hipofisa anterior. Saat PIH turun maka prolaktin segera dilepaskan oleh hipofisa anterior yang akan merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Semakin sering bayi disusui maka reflek ini akan teraktivasi sehingga produksi ASI akan meningkat. Kedua, reflek aliran (let down reflex). Refleks let-down adalah respon otomatis tubuh ibu yang memungkinkan susu mengalir dari payudara. Ketika bayi mulai menyusu, hormon oksitosin dilepaskan, menyebabkan kontraksi di sel-sel sekitar

kelenjar susu, sehingga susu bisa mengalir dengan lancar. Ibu mungkin merasakan sensasi kesemutan atau ketidaknyamanan ringan saat refleksi ini terjadi. Beberapa ibu juga dapat melihat tetesan susu keluar dari payudara sebelum bayi mulai menyusui. Reflek ini berlangsung bersamaan dengan reflek prolaktin yaitu ketika bayi menghisap puting ibu dengan jalur yang sampai pada hipotalamus, akan dilepaskan oksitosin yang disimpan oleh hipofisa posterior. Peningkatan kadar oksitosin dalam darah akan menuju ke sel target yaitu myoepitel di sekitar alveoli payudara. Ketika oksitosin diikat oleh reseptor otot, maka otot akan berkontraksi sehingga akan memeras ASI keluar. Oksitosin juga mempunyai sel target yang lain yaitu otot polos uterus, sehingga bila terjadi peningkatan oksitosin maka otot rahim akan berkontraksi yang akan membantu proses involusi uterus.

Terdapat 3 mekanisme menghisap pada bayi lahir, yaitu: 1.) reflek menangkap (Rooting Reflex), dimana ketika pipi bayi disentuh akan menoleh ke arah sentuhan. Saat bibir disentuh bayi akan membuka mulut dan berusaha menangkap puting susu, 2.) reflek menghisap (sucking reflex), dimana terjadi ketika langit-langit mulut bayi tersentuh oleh puting mengakibatkan tekanan terhadap daerah areola oleh gusi, lidah bayi serta langit-langit, sehingga ASI terperas keluar, 3.) reflek menelan (swallowing reflex), dimana terjadi ketika mulut bayi terisi oleh ASI, maka bayi akan menelannya (Rejeki, 2019).

C. Teknik Menyusui yang Benar

Kegagalan menyusui sering disebabkan oleh kesalahan memosisikan dan meletakkan bayi pada saat menyusui yang berakibat pada lecetnya puting susu sehingga ibu enggan menyusui, produksi ASI berkurang dan bayi menjadi malas menyusui. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah menyusui yang benar serta memastikan posisi dan pelekatan tepat. Teknik menyusui yang benar juga menentukan keberhasilan menyusui. Posisi dan pelekatan ibu dan bayi dengan benar merupakan hal yang sangat menentukan, sehingga perlu disampaikan pada ibu bagaimana langkah-langkah menyusui yang benar, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum menyusui anjurkan ibu mencuci tangan.
2. Keluarkan sedikit ASI, kemudian oleskan pada puting dan sekitar areola sebagai desinfektan alami dan menjaga kelembapan puting.
3. Pastikan Ibu duduk atau berbaring dengan santai, usahakan supaya kaki ibu tidak menggantung.
4. Posisikan kepala bayi di lengkung siku ibu, bokong bayi ditahan telapak tangan, dan satu tangan bayi di belakang badan ibu.
5. Pastikan perut bayi menempel pada badan ibu dan kepala bayi menghadap payudara.

6. Usahakan telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus.
7. Saat menyusui, anjurkan ibu menatap bayi dengan kasih sayang.
8. Memegang payudara dengan ibu jari diatas dan jari yang lain menopang di bawah, jangan terlalu menekan puting susu atau kalang payudara saja.
9. Rangsang bayi agar membuka mulut (roting refleks) dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi.
10. Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting susu serta kalang payudara dimasukkan ke mulut bayi, usahakan sebagian besar areola dapat masuk ke dalam mulut bayi.
11. Lepas tangan ibu saat bayi mulai menghisap payudara.
Setelah selesai menyusui, melepas isapan bayi dengan cara jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi ditekan ke bawah.
12. Untuk mencegah bayi gumoh, setelah bayi selesai menyusui sendawakan bayi dengan cara bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu kemudian punggungnya ditepuk secara perlahan atau dengan cara posisikan bayi tidur tengkurap dipangkuan ibu kemudian tepuk punggung bayi perlahan-lahan.

Teknik menyusui yang salah dapat menyebabkan masalah antara lain puting susu menjadi lecet dan ASI tidak keluar optimal yang sehingga akan mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi enggan menyusui. Tanda pelekatan yang benar antara lain:

1. Dagunya bayi menempel pada payudara
2. Mulut terbuka lebar
3. Sebagian besar areola (terutama bagian bawah) masuk ke mulut bayi
4. Bibir terlipat keluar
5. Pipi bayi tidak kempot
6. Tidak terdengar bunyi decak, hanya bunyi menelan
7. Ibu tidak merasa sakit
8. Bayi tampak tenang

Bidan perlu memberitahu ibu posisi pelekatan benar untuk menjamin proses menyusui yang efektif, yang meliputi sebagai berikut: 1.) mulut bayi membuka lebar, 2.) dagu bayi menempel pada payudara ibu, 3.) hisapan kuat dengan irama perlahan, 4.) puting susu tidak terasa nyeri, 5.) telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus, 6.) kepala bayi agak menengadah (Perinasia, 2004) (UNICEF, 2009).

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan berusia 23 tahun PIA0, telah melahirkan anak pertamanya 2 hari yang lalu yang lalu. Bidan datang melakukan kunjungan rumah. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan Tekanan Darah 120/70 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,4°C, Pernafasan 20x/menit. Ibu mengatakan ASI sudah keluar, namun masih kesulitan saat menyusui bayinya, saat disusui bayi menggigit puting susu sehingga menjadi lecet, dan bayi juga menjadi rewel.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan kasus di atas, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama terjadinya masalah?
4. Apakah kemungkinan yang dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak ditatalaksana dengan tepat?
5. Apa asuhan yang paling sesuai dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	5
2	Judul	Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal
3	Kasus	Masalah laktasi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Pengumpulan data subjektif 2. Prosedur pemeriksaan fisik dan laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/masalah 4. Keterampilan prosedur tindakan, sesuai pada perumusan diagnosis dan/masalah 5. Pendidikan Kesehatan 6. Pendokumentasian 7. Perilaku profesional

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan berusia 23 tahun PIA0, telah melahirkan anak pertamanya 6 jam yang lalu di RS. Saat ini ibu sudah turun dari tempat tidur dan eliminasi spontan. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan Tekanan Darah 120/70 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,4°C, Pernafasan 20x/menit. Ibu mengatakan merasa khawatir karena kesulitan saat menyusui bayinya, saat menyusui puting susu terasa nyeri. TUGAS 1. Lakukan pengkajian data subyektif sesuai dengan kasus 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus 3. Sampaikan diagnosis/ masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh 4. Berikan asuhan kebidanan yang paling tepat pada klien
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS

No.	Komponen	Isi
		1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan payudara, penguji memberikan data payudara simetris, puting susu menonjol, kolostrum sudah keluar 3. Penguji menyimak ketika peserta menyampaikan diagnosis/ masalah kebidanan sesuai kasus 4. Asuhan kebidanan yang diharapkan dari peserta adalah memberikan pendidikan kesehatan mengenai teknik menyusui yang benar 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 10. PS berperan sebagai ibu nifas 11. PS tampak khawatir karena belum berhasil menyusui bayinya, setiap menyusui puting susu terasa nyeri 12. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif 13. Bila peserta melakukan evaluasi dengan bertanya, PS merespon dengan menjawab pertanyaan yang diajukan
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Saya bidan yang bertugas di ruangan ini yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya sudah mencoba menyusui anak saya tetapi belum berhasil bu. Peserta: Apakah sudah dicoba untuk disusukan bu? PS: Sudah Bu, tetapi setiap dicoba disusukan puting susu saya terasa nyeri Peserta: Bisa diperagakan bu, bagaimana cara ibu saat menyusui bayi ibu? PS: Memperagakan cara menyusui dengan teknik yang kurang tepat Peserta: Berdasarkan pengamatan saya, cara menyusui ibu kurang tepat, oleh karena itu saya akan mengajarkan teknik menyusui yang benar. Apakah ibu bersedia? PS: Bersedia bu
10	Kebutuhan manikin	1. Pantom payudara 2. Pantom bayi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Kursi dengan sandaran 2. Kursi kecil untuk sandaran kaki 3. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 4. Pena — 1
13	Penulis	Bdn. Rini Kristiyanti, SSi.T, M.Keb.
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kemenkes RI. 2. UNICEF. (2018). Breastfeeding Counselling: A Training Course. New York: UNICEF.

E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 5: Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat menyusui (frekuensi, durasi, posisi menyusui)		
3. Riwayat kesehatan ibu (puting susu datar, puting susu lecet/kondisi lain)		
4. Pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar		
5. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur pemeriksaan fisik dan laboratorium sederhana

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Melakukan pemeriksaan bentuk payudara (bentuk, puting susu, tanda infeksi)		
b. Melakukan pemeriksaan puting susu (menonjol, datar, atau masuk ke dalam)		
c. Melakukan palpasi payudara (konsistensi, nyeri tekan)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
d. Melakukan palpasi pengeluaran ASI (sudah keluar atau belum)		
e. Melakukan penilaian menyusui (posisi ibu dan bayi, pelekatan, hisapan)		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada catatan medis		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **5 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–4 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE Teknik Menyusui yang Benar

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Memperkenalkan diri		
3. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
4. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan		
5. Menjaga privasi klien		
6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir		
7. Mempersilahkan ibu duduk dengan santai dan nyaman		
8. Mempersilahkan ibu membuka pakaian bagian atas		
9. Mengajarkan ibu untuk mengoleskan ASI pada puting dan areola		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
10. Mengajarkan pada ibu untuk memegang bayi dengan satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan		
11. Mengajarkan pada ibu untuk menempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu tangan bayi di belakang badan ibu dan yang satu di depan, kepala bayi menghadap payudara		
12. Mengajarkan pada ibu untuk memposisikan bayi dengan telinga dan lengan pada satu garis lurus		
13. Mengajarkan pada ibu untuk memegang payudara dengan ibu jari diatas dan jari yang lain menopang di bawah serta jangan menekan puting susu atau areola saja		
14. Mengajarkan pada ibu untuk merangsang membuka mulut bayi dengan menyentuh pipi bayi dengan puting susu atau menyentuh sudut mulut bayi		
15. Setelah bayi membuka mulut, mengajarkan pada ibu untuk mendekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu, kemudian memasukkan puting susu serta sebagian besar areola ke mulut bayi		
16. Setelah bayi mulai menghisap, menganjurkan ibu untuk tidak memegang atau menyangga payudara lagi		
17. Mengajarkan pada ibu cara melepaskan bayi selama menyusui		
18. Mengajarkan pada ibu cara melepaskan isapan bayi: 19. a. Jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut ATAU 20. b. Dagum bayi ditekan ke bawah		
21. Setelah selesai menyusui, mengajarkan pada ibu untuk mengoleskan sedikit ASI pada puting susu dan areola. Biarkan kering dengan sendirinya		
22. Mengajarkan pada ibu untuk selalu menyusukan kedua payudara secara bergantian		
23. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayi setiap saat bayi menginginkan (on demand)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
24. Menanyakan kembali apa yang sudah diajarkan dan dijelaskan		
25. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **23 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **12–22 dari 23 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–11 dari 23 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 4

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skor}}{38} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal: masalah laktasi

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah menyusui
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu nifas dengan masalah laktasi, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat memberikan asuhan yang tepat pada klien yaitu KIE tentang teknik menyusui yang benar
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas normal yang mengalami masalah dalam menyusui bayinya dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan bayi serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang manajemen laktasi, tetapi dari kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kondisi ibu dan memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya mengenai masalah kesulitan menyusui yang sering dialami oleh ibu pada awal-awal pascapersalinan	Seorang perempuan berusia 23 tahun PIA0, telah melahirkan anak pertamanya 6 jam yang lalu di RS. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan Tekanan Darah 120/70 mmHg, Nadi 80x/menit, Suhu 36,4°C, Pernafasan 20x/menit. Ibu mengatakan merasa khawatir karena kesulitan saat menyusui bayinya, dan setiap

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah menyusui
		menyusui puting susu terasa nyeri.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain melengkapi data subyektif dan obyektif dengan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sesuai kasus, dan memberikans uhan yang tepat sesuai kebutuhan ibu yaitu KIE teknik menyusui yang benar.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan pengkajian data subyektif, melakukan pemeriksaan fisik pada payudara ibu dan menilai kemampuan ibu dalam menyusui bayinya, menyimpulkan diagnosa dan masalah yang dialami oleh ibu, dan memberikan asuhan yang tepat sesuai kebutuhan ibu yaitu KIE teknik menyusui yang benar.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, kemampuan memberikan KIE, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menerapkan berpikir kritis dalam menganalisis bahwa masalah ibu merupakan masalah yang fisiologis, namun tetap harus diberikan asuhan yang tepat yaitu KIE teknik menyusui yang benar agar tidak menimbulkan masalah yang lebih berat seperti infeksi.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Setelah melakukan pengkajian data subyektif dan obyektif mahasiswa mampu	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menganalisis bahwa masalah yang dialami ibu adalah masalah fisiologis, tidak diperlukan intervensi khusus,

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah menyusui
	menganalisis diganosa dan masalah utama yang dialami oleh ibu, sehingga asuhan yang diberikan tepat sesuai kebutuhan.	dan mahasiswa mampu memberikan asuhan yang tepat sesuai kebutuhan yaitu dengan memberikan KIE teknik menyusui yang benar.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam berkomunikasi dengan ibu dan keluarga, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan materi dan langkah-langkah KIE agar lebih sistematis.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal menganalisis kebutuhan ibu, salah dalam memberikan asuhan pada ibu.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan	Pada kasus asuhan nifas dengan masalah laktasi, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menganalisis kebutuhan ibu, dan

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah menyusui
	klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	memberikan asuhan secara tepat dan profesional di lahan praktik.

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal: masalah laktasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik ibu nifas dengan masalah menyusui memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian subyektif dan obyektif yang berkaitan dengan menyusui, menganalisis masalah yang muncul berkaitan dengan menyusui, memberikan asuhan sesuai kebutuhan, dan memperbaiki performa berdasarkan umpan balik yang diterima.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu nifas dengan masalah menyusui, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
	karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	profession, analisa masalah yang dialami klien, dan pemberian asuhan yang tepat. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu nifas, analisis masalah yang muncul, dan asuhan tepat sesuai kebutuhan klien.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu 23 tahun PIA0, ibu nifas normal 6 jam, dengan masalah khawatir karena kesulitan saat menyusui bayinya, dan asuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ibu.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pemberian KIE mengenai teknik menyusui yang benar sehingga ibu dapat menerapkan pada bayi dan terhindar dari masalah yang lebih berat seperti puting susu lecet dan mastitis yang dapat menurunkan keberhasilan dalam menyusui.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali masalah dan memberikan asuhan yang tepat pada ibu nifas dengan masalah menyusui, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
		dalam menyampaikan materi dan langkah-langkah KIE agar lebih sistematis sehingga dapat diterima oleh klien dengan lebih optimal.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus masalah menyusui, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menganalisis masalah menyusui dan dapat memberikan asuhan yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menganalisis masalah menyusui dengan baik dan memberikan asuhan sesuai kebutuhan klien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik asuhan ibu nifas dengan masalah laktasi, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal: masalah laktasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu nifas primipara yang mengalami masalah karena belum berhasil menyusui bayinya.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah yang muncul, dan asuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan klien merupakan ibu nifas 6 jam yang mengalami masalah belum berhasil menyusui bayinya, dan merasa khawatir dengan kondisinya saat ini, analisis ibu nifas dengan masalah menyusui yang merupakan kondisi yang fisiologis namun tetap memerlukan penatalaksanaan yang tepat, sehingga perlu diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan klien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menganalisis bahwa kondisi ibu tersebut merupakan hal yang fisiologis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
	kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	namun akan mengakibatkan masalah yang lebih berat apabila tidak dilakukan penatalaksanaan dengan tepat, sehingga perlu diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan klien.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ibu nifas dengan masalah menyusui, mahasiswa belajar bahwa pengkajian dan analisis yang tepat sebelum memberikan asuhan kebidanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai keberhasilan menyusui.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep manajemen laktasi, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal: masalah laktasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus masalah menyusui, mahasiswa merefleksikan bahwa analisis yang kurang tepat dalam mengenali masalah menyusui dapat menyebabkan masalah yang lebih berat yang dapat menurunkan keberhasilan dalam menyusui.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah menganalisis kebutuhan ibu dapat berdampak menyebabkan masalah yang lebih berat yang dapat menurunkan keberhasilan dalam menyusui
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah terjadinya puting susu lecet sampai dengan mastitis yang dapat mengakibatkan meningkatkan morbiditas ibu dan mengakibatkan kegagalan menyusui.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain analisis masalah yang kurang tepat sehingga pemberian asuhan tidak sesuai dengan kebutuhan klien yang dapat mengakibatkan kegagalan menyusui.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengkajian data subyektif dan obyektif yang lengkap, analisis masalah yang tepat, dan pemberian asuhan sesuai dengan kebutuhan klien yang tepat dengan menggunakan komunikasi yang mudah diterima oleh klien dan keluarga.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan	Mahasiswa menyadari bahwa pada masalah menyusui, pengkajian data subyektif dan obyektif yang lengkap, analisis masalah yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan masalah laktasi
	memengaruhi praktik berikutnya.	tepat, dan pemberian asuhan sesuai dengan kebutuhan klien adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

G. Ringkasan

Pada awal pascapersalinan produksi ASI belum optimal dikarenakan pengaruh hormon estrogen dan progesteron, namun kondisi ini merupakan kondisi yang fisiologis yang akan meningkat seiring dengan peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin. Masalah akan timbul apabila ibu belum memahami mengenai fisiologi laktasi sehingga muncul kekhawatiran yang hal tersebut justru akan mengakibatkan stress dan menurunkan sekresi ASI.

Bidan perlu melakukan pengkajian terfokus meliputi data subyektif dan obyektif sehingga dapat diketahui diagnosa dan masalah aktual yang dialami ibu. Pengkajian data subyektif meliputi keluhan, riwayat menyusui, dan pengetahuan tentang teknik menyusui yang benar, sedangkan pemeriksaan data obyektif difokuskan pada pemeriksaan payudara antara lain bentuk payudara, pemeriksaan puting susu, palpasi payudara untuk mengetahui konsistensi dan apakah ada nyeri tekan, pemeriksaan peneluaran ASI, dan posisi serta pelekatan saat menyusui. Apabila hasil pengkajian menunjukkan ibu dalam kondisi normal, dan masalah utama adalah pada ketidaktahuan ibu mengenai fisiologi laktasi dan juga kurangnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyusui bayinya, maka bidan dapat menyusun penatalaksanaan yang sesuai prioritas sehingga kondisi tersebut dapat tertangani secara tepat.

Penatalaksanaan pada masalah menyusui antara lain dengan memberikan dukungan pada ibu. Setelah melahirkan bahwa kondisi yang dialami adalah hal yang fisiologis, selain itu memfasilitasi agar keluarga juga memberikan dukungan pada ibu sepenuhnya. Selain itu bidan juga memberikan KIE sesuai dengan kebutuhan ibu, yaitu teknik menyusui yang benar dengan harapan ibu dapat mempraktikkan dan masalah menyusui dapat berkurang. Dalam pemberian KIE bidan perlu memerhatikan bahasa yang digunakan, karena hal tersebut termasuk kunci keberhasilan KIE. Dengan bahasa yang mudah dipahami klien, maka materi yang diberikan akan lebih terserap dan dipahami dengan optimal.

Alur asuhan singkat

Ibu nifas dengan masalah kesulitan menyusui → pengkajian data subyektif dan obyektif yang mendukung → analisis kebutuhan klien → pemberian KIE teknik menyusui yang benar pada ibu dan keluarga → evaluasi hasil asuhan → dokumentasi.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Laktasi dan Produksi ASI: Fisiologi, Teknik Menyusui, dan Pelekatan Efektif

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Kolostrum belum keluar secara optimal pada 6 jam postpartum	Kondisi kolostrum yang belum keluar secara optimal pada 6 jam postpartum merupakan hal yang fisiologis, namun dapat menjadi masalah bila ibu belum memiliki pemahaman mengenai laktasi	Berikan KIE mengenai fisiologi laktasi dan juga dukungan pada ibu agar menjadi lebih percaya diri dalam menyusui
Bayi enggan menyusui	Kondisi bayi enggan menyusui perlu evaluasi lebih lanjut terkait posisi dan pelekatan menyusui	Lapor ke pembimbing/DPJP, evaluasi ulang lengkap, siapkan rencana asuhan kebidanan yang tepat berupa KIE teknik menyusui yang benar
Puting susu lecet	Kondisi puting susu lecet disebabkan karena posisi dan pelekatan menyusui yang kurang tepat	Lapor ke pembimbing/DPJP, berikan KIE teknik menyusui yang benar, pantau tanda bayi menyusu dengan benar
Payudara ibu tampak kemerahan, bengkak, nyeri, disertai demam dengan suhu badan lebih dari 38°C	Kondisi tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya mastitis	Lapor ke pembimbing/DPJP, berikan asuhan untuk mengurangi nyeri, persiapkan untuk rujukan
ASI tidak keluar >72 jam postpartum	Menunjukkan terjadinya gangguan fisiologis laktasi yang memungkinkan kegagalan dalam menyusui	Lapor ke pembimbing/DPJP untuk dilakukan evaluasi lanjut hormonal, pantau kondisi ibu, rujukan
Bayi buang air kecil kurang dari 6 kali	Menunjukkan asupan ASI kurang	Evaluasi menyeluruh kondisi ibu dan bayi,

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
dalam sehari setelah hari ke-5		lakukan monitoring menyusui secara ketat
Penurunan berat badan bayi lebih dari 10%	Dapat mengarah pada intake ASI tidak cukup	Nilai cepat kondisi bayi, tangani sesuai prioritas, rujuk segera

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Laktasi dan Produksi ASI: Fisiologi, Teknik Menyusui, dan Pelekatan Efektif

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No.	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan fisiologi laktasi	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan 3 tahapan laktogenesis dengan tepat	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu nifas dengan masalah menyusui	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik pada ibu dengan masalah menyusui dengan sistematis	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menganalisis masalah yang dialami ibu nifas sesuai kondisi aktual dengan tepat	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah menyusui yang dialami oleh ibu	☐	☐	
7	Saya sudah bisa memberikan KIE teknik menyusui yang benar pada ibu dan keluarga	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memberikan dukungan pada ibu dengan masalah menyusui	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	

No.	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
10	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
11	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan asuhan secara ringkas dan tepat	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Daftar Pustaka

- Kusuma, N.I., Kristiyanti, R. and Khanifah, M. (2024) Husband and Family Support for Breastfeeding Mothers with COVID-19: The Mother's Perspective. Atlantis Press SARL. Available at: https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_58.
- Lubis, T.- et al. (2022) 'Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, Dukungan Keluarga, Peran Petugas Kesehatan, Dan Hak Menyusui Terhadap Pola Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Pekerja Di Sektor Industri Yang Memiliki Fasilitas Menyusui', *Gizi Indonesia*, 45(1), pp. 59–66. Available at: <https://doi.org/10.36457/gizindo.v45i1.497>.
- Meek, J.Y. and Noble, L. (2022) 'Policy Statement: Breastfeeding and the Use of Human Milk', *Pediatrics*, 150(1), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988>.
- Pearce, E.C. (2014) *Anatomi dan fisiologi untuk paramedis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Perinasia (2004) *Bahan Bacaan Manajemen Laktasi Menuju Persalinan Aman dan Bayi Baru Lahir Sehat*. Jakarta.
- Rejeki, P.S. (2019) 'Catatan Kami tentang ASI', pp. 1–17.
- Suciati, S. and Wulandari, S. (2020) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Asi Eksklusif : Literature Review*.
- Sutanto, A.V. (2018) *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui- Teori dalam Praktik Kebidanan Profesional*. Yogyakarta: Pustaka Batu Press.
- UNICEF (2009) *Guidance Notel for The Implementation of The Baby Friendly Initiative Standards: Higher Education Institutions*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kemenkes RI

BAB 5

KONSELING MENYUSUI DAN PEMECAHAN MASALAH: PUTING LECET, BENDUNGAN ASI, DAN MASTITIS

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab hukum dalam pemberian asuhan nifas dan menyusui.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi interprofesional dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam seluruh rangkaian pelayanan nifas–menyusui.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Melakukan clinical reasoning untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyimpulkan status kesehatan ibu nifas dan menyusui.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan nifas dan menyusui secara aman dan bermutu, termasuk stabilisasi awal dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menghasilkan dokumentasi asuhan, edukasi/konseling, dan penggunaan bukti ilmiah dasar untuk peningkatan mutu.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, ruang lingkup, standar, dan alur pelayanan asuhan nifas dan menyusui berbasis keselamatan pasien.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis–psikologis nifas dan fisiologi laktasi untuk menafsirkan parameter klinis.
CPMK-3	Merancang dan melaksanakan asuhan esensial segera setelah persalinan (kala IV) termasuk pencegahan perdarahan dan keselamatan ibu.
CPMK-4	Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Mengoptimalkan menyusui melalui teknik menyusui, perlekatan efektif, konseling, dan pemecahan masalah laktasi umum.
CPMK-6	Mengidentifikasi dan melakukan tatalaksana awal komplikasi/kegawatdaruratan nifas (perdarahan, infeksi, kesehatan mental) serta menetapkan kriteria rujukan dan kolaborasi.
CPMK-7	Menyusun edukasi, rencana tindak lanjut, dan dokumentasi asuhan nifas–menyusui berbasis bukti dengan komunikasi terapeutik.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui	1.1 Menganalisis konsep, tujuan, dan ruang lingkup asuhan nifas dan menyusui dalam continuum of care.	1.2 Menjelaskan prinsip keselamatan pasien, etika, dan alur pelayanan/rujukan dasar pada masa nifas dan menyusui.	CPMK-1	CPMK-7
Bab 2. Adaptasi Fisiologis dan Psikologis Ibu Nifas: Involusi, Lokia, dan Perubahan Emosi	2.1 Menafsirkan perubahan involusi uterus dan lokia serta parameter fisiologis normal/abnormal berdasarkan data klinis.	2.2 Menganalisis perubahan emosi masa nifas dan faktor risiko gangguan psikologis untuk rencana dukungan awal.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-6
Bab 3. Asuhan Esensial Segera Setelah Persalinan: Kala IV, Pencegahan Perdarahan, dan Keselamatan Ibu	3.1 Melakukan pengkajian kala IV (tanda vital, kontraksi, perdarahan, kandung kemih) dan menetapkan status risiko.	3.2 Menentukan prioritas intervensi pencegahan perdarahan postpartum dan langkah keselamatan ibu sesuai protokol.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-6
Bab 4. Pemantauan Masa Nifas Terjadwal: Kunjungan Nifas, Parameter Klinis, dan Deteksi Dini Risiko	4.1 Menyusun rencana pemantauan/kunjungan nifas terjadwal beserta parameter yang dinilai.	4.2 Menggunakan temuan kunjungan untuk deteksi dini risiko dan menetapkan tindak lanjut/kolaborasi/rujukan.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-7
Bab 5. Perawatan Perineum, Luka Jahitan, dan Manajemen	5.1 Melaksanakan penilaian luka perineum/luka jahitan dan perawatan untuk	5.2 Merancang manajemen nyeri postpartum (nonfarmakologi/farmakologi	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Nyeri Pascapersalinan	mendukung penyembuhan serta mencegah infeksi.	dasar) dan edukasi self-care yang aman.		
Bab 6. Laktasi dan Produksi ASI: Fisiologi, Teknik Menyusui, dan Perlekatan Efektif	6.1 Menganalisis mekanisme produksi ASI dan faktor yang memengaruhi (hormonal, frekuensi, teknik, kondisi ibu-bayi).	6.2 Mendemonstrasikan teknik menyusui dan perlekatan efektif serta mengevaluasi tanda kecukupan menyusui.	CPMK-5	CPMK-2
Bab 7. Konseling Menyusui dan Pemecahan Masalah: Puting Lecet, Bendungan ASI, dan Mastitis	7.1 Mengidentifikasi penyebab dan tanda masalah menyusui (puting lecet, bendungan ASI, mastitis) melalui pengkajian terstruktur.	7.2 Memberikan konseling dan tatalaksana awal, termasuk keputusan rujukan bila perlu, berdasarkan tingkat keparahan.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7
Bab 8. Kebutuhan Gizi Ibu Menyusui dan Dukungan Gaya Hidup Sehat	8.1 Menentukan kebutuhan gizi dan hidrasi ibu menyusui serta rekomendasi suplementasi dasar sesuai kondisi.	8.2 Menyusun rencana dukungan gaya hidup sehat (istirahat, aktivitas, manajemen stres, higienitas) yang realistis.	CPMK-7	CPMK-5; CPMK-2
Bab 9. Perdarahan Postpartum: Identifikasi, Stabilisasi Awal, dan Kriteria Rujukan	9.1 Mengenali dini perdarahan postpartum dan menilai derajat syok menggunakan parameter klinis sederhana.	9.2 Melakukan stabilisasi awal dan menetapkan kriteria rujukan/kolaborasi berdasarkan respons dan sumber daya.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-4
Bab 10. Infeksi Masa Nifas: Endometritis, Infeksi Luka, dan Tatalaksana Awal	10.1 Mengidentifikasi tanda infeksi nifas (endometritis, infeksi luka) dan faktor risiko melalui anamnesis dan pemeriksaan.	10.2 Melaksanakan tatalaksana awal dan pencegahan PPI serta menentukan kebutuhan rujukan sesuai kriteria.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7
Bab 11. Gangguan Eliminasi dan Komplikasi Lain: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid	11.1 Melakukan penatalaksanaan awal gangguan eliminasi (retensi urine, konstipasi, hemoroid) berdasarkan pengkajian.	11.2 Memantau respons, memberikan edukasi pencegahan, dan menentukan tindak lanjut bila tidak membaik.	CPMK-4	CPMK-7; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 12. Kesehatan Mental Ibu Nifas: Baby Blues, Depresi Postpartum, dan Dukungan Keluarga	12.1 Membedakan baby blues, depresi postpartum, dan kondisi lain berdasarkan gejala, durasi, dan dampak fungsi.	12.2 Menyusun rencana dukungan psikososial, keselamatan, dan rujukan/kolaborasi yang melibatkan keluarga.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-7
Bab 13. Keluarga Berencana Pascapersalinan: Konseling, Pemilihan Metode, dan Waktu Pemberian	13.1 Menganalisis kebutuhan, preferensi, dan kontraindikasi dasar KB pascapersalinan termasuk pada ibu menyusui.	13.2 Melakukan konseling pemilihan metode dan waktu pemberian KB dengan mempertimbangkan risiko-manfaat.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-5
Bab 14. Dokumentasi Asuhan Nifas, Edukasi Tanda Bahaya, dan Rencana Tindak Lanjut	14.1 Menyusun dokumentasi asuhan nifas-menyusui yang lengkap, akurat, dan terstruktur sesuai standar.	14.2 Mengembangkan materi edukasi tanda bahaya dan rencana tindak lanjut/rujukan yang dapat dipahami ibu/keluarga.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-6

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Kuis konsep (MCQ/SAQ); Tugas analisis alur pelayanan	Akurasi konsep/terminologi dan standar ($\geq 80\%$ benar); Alur pelayanan logis dan selaras keselamatan pasien/etika (langkah kritis tidak terlewat)	10	Lembar kuis; ringkasan/mind map alur
CPMK-2	Ujian berbasis kasus (analisis); Kuis interpretasi data	Ketepatan interpretasi parameter fisiologis nifas & laktasi ($\geq 80\%$ tepat); Rasional klinis jelas (≥ 3 alasan relevan) untuk simpulan	15	Lembar analisis kasus; lembar kuis
CPMK-3	OSCE/simulasi kala IV; Checklist keterampilan	Pengkajian kala IV lengkap ($\geq 90\%$ item checklist); Prioritas tindakan tepat dan aman (tidak	15	Checklist OSCE; rekaman/lembar penilaian simulasi

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		ada langkah kritis keselamatan terlewat)		
CPMK-4	OSCE kunjungan nifas & perawatan; Laporan praktik mini-case	Pengkajian terjadwal dan deteksi dini risiko akurat ($\geq 85\%$ keputusan tepat); Teknik perawatan/perencanaan tindak lanjut sesuai SOP (error kritis = 0)	20	Checklist OSCE; laporan mini-case; catatan asuhan
CPMK-5	OSCE teknik menyusui & konseling; Penilaian performa/video	Perlekatan/posisi efektif ($\geq 85\%$ kriteria terpenuhi); Solusi masalah laktasi sesuai penyebab dan tingkat keparahan; Komunikasi konseling empatik dan terstruktur	15	Checklist OSCE; video/demonstrasi; lembar konseling
CPMK-6	Simulasi skenario kegawatdaruratan; Ujian tulis skenario	Pengenalan tanda bahaya cepat dan tepat (≤ 2 menit pada simulasi); Stabilisasi awal sesuai prioritas dan aman; Keputusan rujukan/kolaborasi sesuai kriteria	15	Lembar penilaian simulasi; jawaban skenario
CPMK-7	Portofolio (dokumentasi & edukasi); Presentasi singkat	Dokumentasi lengkap-akurat-terstruktur ($\geq 90\%$ komponen); Materi edukasi jelas sesuai literasi; Menggunakan ≥ 2 sumber bukti ilmiah; Rencana tindak lanjut spesifik dan realistis	10	Portofolio; leaflet/lembar edukasi; slide/presentasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep/terminologi dan standar	Banyak konsep inti keliru; istilah tidak konsisten; standar tidak jelas.	Konsep dasar cukup benar namun ada kekeliruan penting;	Mayoritas konsep benar; kekeliruan minor; standar	Konsep sangat akurat; istilah konsisten; standar

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		standar disebut terbatas.	relevan digunakan.	digunakan tepat dan menyeluruh.
1.2 Kesesuaian alur pelayanan dengan keselamatan pasien	Alur tidak runtut; langkah kritis keselamatan terlewat.	Alur cukup runtut namun ada langkah kritis yang belum lengkap.	Alur runtut; langkah kritis terpenuhi; risiko utama dikenali.	Alur runtut dan efisien; prioritas jelas; mitigasi risiko & eskalasi dirumuskan tepat.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter fisiologis nifas & laktasi	Salah menafsirkan data; tidak dapat membedakan normal–abnormal.	Menafsirkan sebagian data namun ada salah simpulan pada temuan penting.	Menafsirkan data dengan benar; membedakan normal–abnormal dengan tepat.	Interpretasi sangat tepat; mengaitkan pola data dan prioritas masalah secara tajam.
2.2 Analisis perubahan emosi & faktor risiko psikologis	Tidak mengenali pola gejala; faktor risiko tidak relevan.	Mengenali gejala umum namun analisis risiko dangkal/tidak lengkap.	Analisis gejala dan risiko memadai; menyusun kebutuhan dukungan awal.	Analisis komprehensif; mempertimbangkan konteks keluarga/sosial; rekomendasi dukungan sangat tepat.

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Pengkajian kala IV dan penetapan status risiko	Pengkajian tidak lengkap; banyak data penting terlewat; risiko tidak tepat.	Pengkajian cukup namun masih ada data penting kurang; risiko sebagian tepat.	Pengkajian lengkap sesuai urutan; status risiko tepat.	Pengkajian sangat sistematis; cepat; risiko diprioritaskan dan dikomunikasikan jelas.
3.2 Intervensi pencegahan perdarahan & keselamatan ibu	Tindakan tidak sesuai prioritas; berisiko/menyalahi prosedur.	Tindakan sebagian tepat namun urutan/prioritas belum konsisten.	Tindakan tepat dan aman; prioritas sesuai protokol.	Tindakan sangat tepat; antisipasi komplikasi; koordinasi tim dan keselamatan optimal.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengkajian kunjungan nifas & deteksi dini risiko	Pengkajian tidak terstruktur; tanda risiko sering terlewat.	Pengkajian cukup terstruktur namun deteksi risiko belum konsisten.	Pengkajian terstruktur; risiko terdeteksi tepat; keputusan tindak lanjut sesuai.	Pengkajian sangat komprehensif; mengaitkan tren; rencana tindak lanjut proaktif dan tepat.
4.2 Manajemen masalah umum (luka/nyeri/eliminasi) & rencana tindak lanjut	Intervensi tidak tepat/tidak aman; edukasi minim; tindak lanjut tidak jelas.	Intervensi cukup tepat namun rasional/edukasi kurang lengkap.	Intervensi tepat dan aman; edukasi memadai; tindak lanjut jelas.	Intervensi sangat tepat; personalisasi edukasi; evaluasi respons dan eskalasi direncanakan matang.

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Teknik menyusui & perlekatan efektif	Posisi/perlekatan salah; tidak dapat menunjukkan tanda efektif.	Posisi/perlekatan cukup namun masih ada kesalahan yang mengganggu efektivitas.	Posisi/perlekatan benar; menunjukkan tanda efektivitas menyusui.	Teknik sangat tepat; mampu mengoreksi kesalahan; evaluasi kecukupan menyusui sangat baik.
5.2 Konseling & pemecahan masalah laktasi	Tidak mampu mengidentifikasi penyebab; solusi tidak sesuai.	Identifikasi penyebab sebagian; solusi umum dan kurang spesifik.	Identifikasi penyebab tepat; solusi sesuai dan realistis; komunikasi empatik.	Analisis masalah tajam; solusi bertahap sesuai keparahan; dukungan/kolaborasi direncanakan optimal.

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi cepat komplikasi/kegawatdaruratan	Terlambat mengenali; salah menentukan prioritas; tanda bahaya terlewat.	Mengenali tanda bahaya utama namun belum cepat/kurang lengkap.	Mengenali tanda bahaya dengan cepat; prioritas masalah tepat.	Sangat cepat dan akurat; menilai derajat/keparahan secara sistematis.
6.2 Stabilisasi awal & keputusan rujukan/kolaborasi	Tindakan awal tidak sesuai/berisiko; rujukan tidak tepat.	Tindakan awal sebagian tepat; rujukan/kolaborasi belum jelas.	Stabilisasi awal tepat dan aman; rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	Stabilisasi sangat tepat; koordinasi tim efektif; rujukan disertai informasi klinis lengkap dan tepat waktu.

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Dokumentasi asuhan (lengkap, akurat, terstruktur)	Banyak komponen hilang; data tidak akurat; format tidak runtut.	Komponen utama ada namun masih kurang detail/ada inkonsistensi.	Dokumentasi lengkap dan akurat; format runtut; rencana jelas.	Dokumentasi sangat lengkap; analitis; mudah ditelusuri; mendukung kesinambungan asuhan.
7.2 Edukasi, rencana tindak lanjut, dan penggunaan bukti	Edukasi tidak jelas/tidak sesuai; tindak lanjut tidak spesifik; tanpa rujukan bukti.	Edukasi cukup jelas namun belum sesuai literasi; tindak lanjut umum; bukti minimal.	Edukasi jelas sesuai literasi; tindak lanjut spesifik; menggunakan bukti relevan.	Edukasi sangat jelas dan terpersonalisasi; tindak lanjut terukur; bukti kuat dan diintegrasikan tepat.

A. Puting Susu Lecet (Abraded or Cracked Nipple)

Puting susu lecet dapat disebabkan trauma pada puting susu saat menyusui. Selain itu, dapat pula terjadi retak dan pembentukan celah-celah. Retakan pada puting susu bisa sembuh sendiri dalam waktu 48 jam (Susanto, 2022). Puting susu lecet dapat disebabkan oleh posisi menyusui yang salah, tapi dapat pula disebabkan oleh trush (candidates) atau dermatitis (Walyani dan Purwoastuti, 2015). Selama menyusui, puting pecah adalah masalah payudara yang paling sering ditemui. Insiden puting pecah dalam 7 hari pertama bervariasi dari 15% hingga 80% secara global (Ebru Sxahin & Duman, 2023). Nyeri puting, ruam, dan puting pecah-pecah terlihat pada hampir 80–90% wanita menyusui (Can Gürkan et al., 2022). Karena merupakan kondisi yang menyakitkan, hal ini sering menyebabkan terputusnya pemberian ASI eksklusif dan penyapihan dini (Santos et al., 2016).

1. Penyebab

- a. Teknik menyusui yang tidak benar.
- b. Puting susu terpapar oleh sabun, krim, alkohol ataupun zat iritan lain saat ibu membersihkan puting susu.
- c. Moniliasis pada mulut bayi yang menular pada puting susu ibu.
- d. Bayi dengan tali lidah pendek (frenulum lingue).
- e. Cara menghentikan menyusui yang kurang tepat (Susanto, 2022).

2. Penatalaksanaan

- a. Cari penyebab puting lecet (posisi menyusui salah, candidates atau dermatitis)
- b. Bayi disusukan lebih dulu pada puting susu yang normal atau lecetnya sedikit. Puting susu yang sakit dapat diistirahatkan untuk sementara waktu kurang lebih 1x24 jam, dan biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 2x24 jam
- c. Posisi menyusui harus benar, bayi menyusu sampai ke kalang payudara dan susukan secara bergantian diantara kedua payudara.
- d. Olesi puting susu dengan ASI akhir (hind milk), jangan sekali-kali memberikan obat lain, seperti krim, salep, dan lain-lain
- e. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan, dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena nyeri
- f. Cuci payudara sehari sekali saja dan tidak dibenarkan untuk menggunakan dengan sabun

- g. Bila sangat menyakitkan, berhenti menyusui pada payudara yang sakit untuk sementara untuk memberi kesempatan lukanya menyembuh
- h. Keluarkan ASI dari payudara yang sakit dengan tangan (jangan dengan pompa ASI) untuk tetap mempertahankan kelancaran pembentukan ASI
- i. Berikan ASI perah dengan sendok atau gelas jangan menggunakan dor
- j. Setelah terasa membaik, mulai menyusui kembali mula-mula dengan waktu yang lebih singkat
- k. Pergunakan BH yang menyangga.
- l. Bila terasa sangat sakit boleh minum obat pengurang rasa sakit.
- m. Jika penyebabnya monilia, diberi pengobatan dengan tablet Nystatin (Susanto, 2022; Walyani dan Purwoastuti, 2015).

B. Bendungan ASI atau Payudara Bengkak (Breast Engorgement)

Payudara bengkak adalah kondisi yang tidak normal, terasa sangat sakit karena payudara membengkak, tampak edema, puting serta areola kencang. kulit mengkilat dan bisa tampak memerah. Seluruh payudara mengencang dan sakit. Payudara sulit untuk dipencet/ditekan, terasa keras. Payudara bengkak tersusun dari ASI yang terakumulasi ditambah kongesti akibat peningkatan perdarahan di sekitar jaringan payudara dan edema akibat sumbatan di pembuluh darah serta saluran limfe payudara. Bila diperiksa/dihisap ASI tidak keluar. Badan bisa demam setelah 24 jam. Demam biasanya demam ringan. Tangan dan lengan terkadang terasa kebas dan geli jika payudara sangat bengkak (Asih dan Risneni, 2016).

Payudara bengkak sering terjadi di hari ketiga menyusui ketika ASI mulai bertambah banyak ("ASI datang") jika ibu terlambat mulai menyusui, posisi serta perlekatan menyusui kurang baik, membatasi waktu menyusui dan kurang sering memberikan/mengeluarkan ASI. Payudara bengkak juga bisa terjadi jika bayi menolak menyusu atau pada ibu yang tidak disiplin memerah ASI ketika jauh dari bayi. Penyebab payudara bengkak adalah ibu tidak mengeluarkan ASI secara efektif. Penyebab yang sering menimbulkan payudara bengkak antara lain:

Faktor ibu, antara lain:

1. Posisi dan perlekatan ketika menyusui bayi tidak baik.
2. Memberikan bayinya suplementasi PASI dan empeng/dot.
3. Membatasi penyusuan dan jarang menyusui bayi.
4. Terpisah dari bayi dan tidak mengosongkan payudara dengan efektif.
5. Mendadak menyapih bayi.
6. Payudara tidak normal, misalnya terdapat saluran ASI yang tersumbat.
7. Ibu stress.
8. Ibu kecapaian.

Faktor bayi, antara lain:

1. Bayi menyusui tidak efektif.
2. Bayi sakit, misalnya jaundice/bayi kuning.
3. Menggunakan pacifier (dot/empeng).

Terapi Utama: Teruskan menyusui bayi dengan baik, Keluarkan ASI dengan efektif dari payudara, atasi faktor penyebab. Cara mengatasi payudara bengkak adalah dengan menyusui bayi dalam kondisi payudara bengkak. Sebelum menyusui bayi, payudara yang penuh dan bengkak ini rasanya tidak nyaman, bahkan sakit, sehingga ibu sebaiknya diberikan beberapa saran berikut ini:

1. Ibu menyusui bayi dengan sedini mungkin, frekuensi menyusui sering, dan jangan dibatasi. Ikuti kemauan bayi (namun seringkali bayi baru lahir cenderung mengantuk). Tujuannya supaya ASI keluar dengan efektif.
2. Ibu dan bayi sering melakukan kontak kulit.
3. Areola biasanya edema sehingga kencang dan putting menjadi mendatar: lakukan teknik *reverse pressure softening* seperti areolar grasp untuk melembuntukan jaringan areola. Tujuannya supaya bayi mudah melekat.
4. Pastikan terjadi *let-down reflex* atau refleks aliran ASI sehingga ASI bisa keluar dengan efektif.

Cara membangkitkan *let-down reflex* (LDR) atau refleks oksitosin ketika payudara penuh/bengkak adalah dengan ibu menyusui bayi di tempat yang tenang dan nyaman, Lakukan relaksasi dengan mandi air hangat, kompres hangat di punggung dan pundak, pijat oksitosin, lakukan relaksasi pernafasan, minum hangat dan ambil posisi yang nyaman, lakukan manajemen untuk mengurangi rasa nyeri. Ibu bisa meminum obat pereda rasa sakit (analgesik) seperti parasetamol atau ibuprofen bila diperlukan (selama ibu tidak alergi terhadap obat tersebut). Analgesik bisa membantu terjadinya LDR. Ibuprofen dikatakan lebih efektif dari parasetamol/acetaminophen untuk mengurangi gejala dan aman bagi ibu menyusui. Ibu bisa berkonsultasi dengan dokter untuk pemakaian lebih lanjut. Segera menyusui sebelum bayi menangis kelaparan. Kenali tanda bayi lapar.

Lakukan kontak kulit dengan bayi buka bedong, baju, sarung tangan bayi, pakaikan popok saja. Jika dingin bisa pakaikan kaus kaki, topi serta ibu dan bayi berselimut bersama. Lakukan posisi menyusui *biological nurturing* untuk memanggil refleks menyusui bayi. Pijat payudara dengan lembut. Saat ini memijat payudara yang sedang radang tidak disarankan. Ibu harus berhati-hati memijat payudara yang bengkak dan meradang karena jika terlalu keras justru akan

semakin memperparah radang payudara Lakukan stimulasi puting. Gulung-gulung puting diantara jari telunjuk dan ibu jari sampai terasa ASI keluar. Perah ASI hingga payudara lebih lembut. Lakukan pemerahan jika ibu terpisah dengan bayi atau bayi tidak bisa mengosongkan ASI dengan efektif. Namun perah ASI jangan sampai terlalu kosong, cukup hingga membuat payudara nyaman. Karena pemerahan bisa menstimulasi. Kompres hangat di punggung atau pundak ibu. Kadang beberapa ibu terbantu dengan kompres hangat di payudara, namun kompres hangat di payudara akan meningkatkan vasokongesti sehingga ibu bertambah tidak nyaman. Kompres dingin di payudara selama beberapa menit. Kompres dingin bisa menggunakan: Air es, kompres flu, diapers yang dibasahi, es yang dihancurkan, sayuran beku. Es/sayuran beku (seperti kacang polong beku) harus dibungkus kain terlebih dahulu. Batasi jangan langsung terkena kulit karena berisiko luka frobite.

Saat menyusui bayi, Pastikan bayi menyusu dengan baik. Posisi perlekatan harus baik. Nilai bagaimana bayi menghisap dan menelan ASI. Pastikan bayi menghisap aktif sehingga ASI bisa dikeluarkan secara efektif. Lakukan kompresi payudara saat bayi tidak menghisap dan menelan dengan efektif. Lakukan kompresi payudara bergantian hingga seluruh payudara kosong.

Setelah menyusui bayi, jika bayi telah kenyang dan menyusu dengan baik namun payudara masih terasa penuh dan keras maka ibu sebaiknya memerah payudara hingga terasa enteng, kosong dan lembut. Kedua payudara harus sama-sama terasa lembut dan enteng. Jika payudara terasa nyeri bisa dikompres dengan kompres dingin.

Jika kita membaca literatur di luar negeri terkadang kita temukan saran mengompres payudara bengkak dengan daun kol hijau. Beberapa ibu terbantu dengan kompres menggunakan daun kol hijau. Prinsipnya sama dengan kompres dingin. Namun, daun kol bisa terkontaminasi bakteri seperti *Listeria*. *Listeriosis* ini sangat berbahaya bagi wanita hamil, bayi baru lahir dan dengan gangguan sistem imunitas. Ibu tidak boleh memakai kompres daun kol jika ada luka terbuka pada puting dan payudara. Penggunaan daun kol untuk mengatasi payudara bengkak sebenarnya tidak terbukti melalui penelitian terkontrol dibandingkan terapi yang lain. Namun beberapa ibu di luar negeri mengatakan sangat terbantu dengan penggunaan daun kol ini dibandingkan mempersiapkan sekantong remukan es untuk kedua payudara.

Cara mengompres payudara dengan daun kol:

1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang daun kol.
2. Gunakan daun kol hijau yang bersih. Cuci daun hingga bersih menggunakan air yang bisa diminum.

3. Lemaskan daun kol dengan penggiling kue agar lebih mudah membentuk payudara ibu.
4. Iris tulang daunnya yang besar, lubangi untuk tempat puting dan gunakan di dalam bra selama dua puluh hingga tiga puluh menit.
5. Pasang daun kol setelah menyusui dan biarkan hingga layu, biasanya 2-4 jam, ganti dengan daun segar yang baru jika sudah layu.
6. Ulangi dua hingga tiga kali sehari hingga bendungan ASI sembuh.

Hentikan penggunaan kompres daun kol jika bengkak payudara sudah sembuh. Biasanya bengkak payudara sembuh dalam 8 jam. Penggunaan daun kol berlebihan bisa menurunkan produksi ASI. Penggunaan daun kol bisa membuat payudara beraroma dan terasa seperti daun kol yang sedang dimasak. Jadi, pertimbangkan dengan baik jika ibu ingin melakukan kompres dengan daun kol ini (Asih dan Risneni, 2016). Hasil penelitian menyebutkan bahwa daun kubis dingin lebih efektif daripada perawatan rutin (perbedaan rata-rata (MD) -1,03 poin pada skala analog visual (VAS) 0-10, interval kepercayaan 95% (CI) -1,53 hingga -0,53; 152 wanita; bukti kepastian sangat rendah) atau kompres gel dingin (-0,63 poin VAS, 95% (Zakarija-Grkovic & Stewart, 2020).

Intervensi medis di luar manajemen laktasi yang optimal:

Beberapa dokter menyarankan untuk melakukan terapi seperti ultrasonografi, pemberian oksitosin dan akupuntur. Beberapa ibu merasa membaik setelah menjalani terapi. Namun, review sistematik menunjukkan secara statistik tidak terdapat perbedaan antara pemberian intervensi dengan yang tidak dilakukan intervensi.

Beberapa ahli ada yang menyarankan untuk merendam payudara dilarutan salin kadar rendah atau garam epsom (magnesium sulfat). Fungsinya kemungkinan besar untuk mengurangi edema jaringan payudara. Memang belum ada penelitian yang mendukung intervensi ini, namun tidak berbahaya selama tidak tertelan oleh bayi.

Komplikasi payudara bengkak:

Payudara bengkak yang tidak diatasi dengan baik bisa mengakibatkan beberapa komplikasi berikut ini:

1. Bayi sulit melekat pada payudara yang keras.
2. Puting nyeri.
3. ASI sulit keluar sehingga asupan ASI pada bayi menurun.
4. ASI sulit keluar secara efisien sehingga banyak ASI yang masih tertinggal di payudara, akibatnya lama-kelamaan pasokan ASI bisa menurun.

5. Kerusakan sel-sel alveoli pembuat ASI.
6. Stasis ASI di payudara.
7. Duktus saluran ASI menjadi tersumbat.
8. Mastitis.
9. Ibu kesakitan sehingga menjadi menurun motivasinya untuk terus menyusui bayi.
10. Jangan istirahatkan payudara saat payudara sakit, karena akan semakin sakit.
11. Pencegahan merupakan prioritas utama untuk mengatasi payudara bengkak dan seluruh komplikasi menyusui karena menyusui itu mudah dan tidak menyakitkan.

C. Mastitis

Mastitis laktasi akut mengacu pada infeksi purulen akut pada payudara wanita menyusui. Patogenesisnya terutama disebabkan oleh infeksi bakteri, di antaranya bakteri yang paling umum adalah *Staphylococcus aureus* dan *Streptococcus*. Bakteri ini dapat masuk ke jaringan payudara melalui fisura puting, penyumbatan saluran, stasis susu, dan jalur lainnya. Gejala utama penyakit ini adalah nyeri payudara, kemerahan, pembengkakan, dan demam. Gejala-gejala ini tidak hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan yang parah bagi pasien, tetapi juga mengganggu pemberian ASI, sehingga mengakibatkan asupan nutrisi yang tidak mencukupi bagi bayi. Data epidemiologi terbaru menunjukkan bahwa kejadian mastitis akut pada wanita menyusui berkisar antara 2,2 hingga 10% dan terus meningkat. Meskipun mekanisme patofisiologis mastitis akut telah relatif jelas, etiologinya masih cukup kompleks. Kejadiannya melibatkan banyak faktor risiko, teknik pemberian ASI, struktur payudara yang abnormal, dan status imun. Saat ini, pencegahan klinis mastitis akut terutama bergantung pada pendidikan kesehatan. Selain itu, diagnosis dan pengobatan biasanya didasarkan pada manifestasi klinis dan hasil uji laboratorium. Namun, karena karakteristik gejala awal mastitis akut yang tidak spesifik dan kesulitan dalam memprediksi timbulnya penyakit ini, seringkali terjadi keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatannya. Keterlambatan tersebut seringkali membuat intervensi dan pengobatan dini penyakit menjadi lebih rumit. Keterlambatan ini dapat menyebabkan terjadinya komplikasi, misalnya, pembentukan abses. Komplikasi ini akan berdampak negatif pada efektivitas pengobatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi indikator risiko utama terjadinya mastitis akut pada wanita menyusui. Hal ini tidak hanya sangat penting untuk pencegahan yang efektif tetapi juga sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan tepat waktu (Zhu et al., 2025).

Sumber lain menyebutkan Mastitis adalah peradangan pada payudara. Mastitis ini dapat terjadi kapan saja saat ibu menyusui. Namun, paling sering terjadi antara hari ke-10 dan hari ke-28 setelah kelahiran.

1. Penyebab Mastitis
 - a. Asupan gizi kurang.
 - b. Istirahat tidak cukup dan terjadi anemia.
 - c. Puting susu lecet, sehingga terjadi infeksi.
 - d. Bra dengan ukuran yang salah dan terlalu ketat.
 - e. Payudara bengkak yang tidak disusukan secara adekuat.
2. Gejala Mastitis
 - a. Bengkak disertai rasa nyeri.
 - b. Pada titik tertentu atau keseluruhan, payudara tampak merah.
 - c. Payudara terasa keras dan berbenjol-benjol.
 - d. Demam.
3. Penanganan
 - a. Konsumsi makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup.
 - b. Bayi dianjurkan mulai menyusui saat payudara mengalami peradangan.
 - c. Berikan antibiotik untuk mengatasi infeksi.
 - d. Berikan pengobatan analgetik untuk mengurangi rasa sakit.
 - e. Lakukan pengompresan dengan air hangat pada payudara.

Pembengkakan, penyumbatan saluran ASI, mastitis, dan abses payudara mencerminkan perkembangan dari masalah awal yang umum yaitu drainase yang tidak memadai yang dapat disebabkan oleh posisi dan pelekatan yang buruk, pengosongan yang tidak memadai, atau produksi ASI berlebih (Leung, 2016). Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran akan hambatan yang dapat dimodifikasi yang dialami oleh ibu selama menyusui dapat membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi ibu yang berisiko mengalami penghentian menyusui dini dan implementasi dukungan menyusui yang tepat sasaran (Gianni et al., 2019)

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang perempuan, usia 28 tahun, P1A0, PPH 3, datang ke Puskesmas pukul 09.00 dengan keluhan nyeri dan bengkak pada payudara. Hasil pemeriksaan awal: keadaan umum baik, TD 110/80 mmHg, nadi 80 x/menit, suhu 37,8°C, payudara teraba penuh dan bengkak.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
4. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Nifas: Deteksi Dini
3	Kasus	Putting susu lecet dengan tindakan awal dan penanganan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 24 tahun, P1A0, PPH 2, datang ke TPMB dengan keluhan nyeri dan lecet pada puting saat menyusui bayinya. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut.

No.	Komponen	Isi
		5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan penanganan yang akan diberikan
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memberikan penanganan - Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 4. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN

No.	Komponen	Isi
		1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu nifas. 2. PS tampak cemas, lelah, nyeri saat menyusui. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya nyeri saat menyusui bayi saya karena puting saya terbelah. Peserta: Sejak kapan nyeri saat menyusui? PS: kemarin, Bu. Peserta: Apakah saat menyusui terdengar bunyi decapan dari bayi? PS: Iya, terdengar decapan. Peserta: Apakah Ibu sudah mengetahui terkait Teknik menyusui? PS: belum bu, karena ini anak pertma jadi belum ada pengalaman. Peserta: Baik, Saya akan melakukan tindakan awal untuk membantu mengurangi puting susu ibu yang lecet. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan

No.	Komponen	Isi
		ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom payudara - Phantom Bayi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar dokumentasi, instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom payudara — 1 3. Phantom Bayi— 1 4. Bantal — 1 set 5. kursi dengan sandara — 1 6. Sarung tangan bersih — 1 pasang 7. Handrub — 1 botol 8. Kain penutup/selimut — 1 9. Tisu — 1 pack 10. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 11. Pena — 1
13	Penulis	
14	Referensi	1. Susanto, Andina Vita, 2022. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Teori dalam Praktik Kebidanan Profesional. Yogyakarta:Pustaka Baru Press. 2. Walyani, E. S dan Purwoastuti, E. 2015. Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. Yogyakarta:Pustaka Baru Press. 3. Asih, Y dan Risneni. 2016. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Jakarta: Trans Info Media (TIM).

E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Nifas: Deteksi Dini

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat menyusui		
3. Posisi menyusui		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai Skor nyeri ibu		
c. Melakukan penilaian putting susu ibu		
d. Mengajari ibu cara Teknik menyusui yang benar		
e. Menilai perlekatan saat menyusui serta menjelaskan tanda perlekatan yang benar		
f. Menjelaskan tanda bayi cukup ASI		
g. Menjelaskan cara melepaskan putting saat bayi telah kenyang		
3. Pasca tindakan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada partograf/catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama melakukan tindakan		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30

(Kota),

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Konseling Nifas: Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan penanganan puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis penanganan puting susu lecet, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan bayi serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan yang evidence-based, woman-centred.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-bayi, melakukan penanganan, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan jika diperlukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan puting susu lecet, dan penanganannya.	Seorang perempuan, usia 24 tahun, P1A0, PPH 2, datang ke TPMB dengan keluhan nyeri dan lecet pada puting saat menyusui bayinya.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, menilai nyeri ibu dan penanganan puting susu lecet, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai keadaan umum ibu, tanda vital, menilai nyeri ibu dan penanganan puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan nyeri yang

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
	komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda puting susu lecet dan ketepatan keputusan eskalasi.	dirasakan oleh ibu dengan penanganan yang diberikan.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan jika diperlukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan memberikan penanganan, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, serta kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya	Pada kasus puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis dan penanganannya, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
	diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Konseling Nifas: Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian masalah menyusui, mengenali tanda bahaya ibu melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu nifas dengan puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
		setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi rofession, pengenalan puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, dan penangannya. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu nifas, dan penanganan puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis di ruangan nifas
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Seorang perempuan, usia 24 tahun, P1A0, PPH 2, datang ke TPMB dengan keluhan nyeri dan lecet pada puting saat menyusui bayinya, serta penanganannya
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, ketelitian membaca rofession, penanganan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis dan menjelaskan penanganannya, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai kasus.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
		konsisten mampu menilai Fisiologi menyusui, mengenali puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, dan melakukan tindakan tepat secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan rofession, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan yang tepat pada puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Konseling Nifas: Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu yang mengalami puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
	kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	prioritas, tindakan penanganan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan Seorang perempuan, usia 24 tahun, P1A0, PPH 2, datang ke TPMB dengan keluhan nyeri dan lecet pada puting saat menyusui bayinya.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menilai dan menganalisis tentang puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis,.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus tentang puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, mahasiswa belajar bahwa deteksi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan nifas.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep tentang puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Konseling Nifas: Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Penaganannya

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan deteksi dini masalah menyusui dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca rofession, tidak memantau Teknik menyusui dengan cermat, atau menunda penagangan dapat berdampak besar pada kenyamanan dan keselamatan ibu.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta keterlambatan penanganan bila tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, serta penanganan yang kurang tepat.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya mendeteksi secara tepat puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis, pengambilan keputusan cepat,

Komponen	Deskripsi	Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis serta Konseling
		dan keberanian melakukan tindakan adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

G. Rangkuman Materi

Menyusui adalah cara pemenuhan kebutuhan nutrisi yang terbaik bagi bayi. Memberikan seluruh anak permulaan hidup yang terbaik bisa dimulai dengan menyusui, sebuah ikhtiar yang paling sederhana, paling cerdas dan paling terjangkau untuk mendukung anak yang lebih sehat, keluarga yang lebih kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan. WHO mereko-mendasikan pemberian ASI eksklusif dimulai dalam 1 jam setelah kelahiran bayi hingga usia bayi 6 bulan. MPASI gizi seimbang harus ditambahkan ketika usia bayi 6 bulan dengan tetap meneruskan menyusui hingga umur 2 tahun atau lebih.

Puting susu lecet dapat disebabkan trauma pada puting susu saat menyusui. Selain itu, dapat pula terjadi retak dan pembentukan celah-celah. Retakan pada puting susu bisa sembuh sendiri dalam waktu 48 jam (Susanto, 2022). Puting susu lecet dapat disebabkan oleh posisi menyusui yang salah, tapi dapat pula disebabkan oleh trush (candidates) atau dermatitis.

Penanganan Puting Susu Lecet:

- Cari penyebab puting lecet (posisi menyusui salah, candidates atau dermatitis)
- Bayi disusukan lebih dulu pada puting susu yang normal atau lecetnya sedikit. Puting susu yang sakit dapat diistirahatkan untuk sementara waktu kurang lebih 1x24 jam, dan biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 2x24 jam
- Posisi menyusui harus benar, bayi menyusu sampai ke kalang payudara dan susukan secara bergantian diantara kedua payudara.
- Olesi puting susu dengan ASI akhir (hind milk), jangan sekali-kali memberikan obat lain, seperti krim, salep, dan lain-lain

- e. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan, dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena nyeri
- f. Cuci payudara sehari sekali saja dan tidak dibenarkan untuk menggunakan dengan sabun
- g. Bila sangat menyakitkan, berhenti menyusui pada payudara yang sakit untuk sementara untuk memberi kesempatan lukanya menyembuh
- h. Keluarkan ASI dari payudara yang sakit dengan tangan (jangan dengan pompa ASI) untuk tetap mempertahankan kelancaran pembentukan ASI
- i. Berikan ASI perah dengan sendok atau gelas jangan menggunakan dor
- j. Setelah terasa membaik, mulai menyusui kembali mula-mula dengan waktu yang lebih singkat
- k. Pergunakan BH yang menyangga.
- l. Bila terasa sangat sakit boleh minum obat pengurang rasa sakit.
- m. Jika penyebabnya monilia, diberi pengobatan dengan tablet Nystatin

Alur asuhan singkat

Ibu menyusui tidak on demand → nilai cara menyusui bayi → identifikasi kemungkinan pusing susu lecet → penanganan → tentukan kebutuhan kolaborasi/rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Konseling Nifas: Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Putting susu menunjukkan lecet	Putting susu lecet karena Teknik menyusui yang kurang tepat	Lapor ke pembimbing/DPJP, evaluasi ulang lengkap, berikan konseling dan mengajari Teknik menyusui
Payudara terasa penuh	Payudara membengkak, tampak edema, puting serta areola kencang	Berikan pengobatan analgetik untuk mengurangi rasa sakit
Payudara bengkak disertai demam	Menunjukkan akibat payudara penuh, payudara tampak merah	Reposisi ibu, nilai cepat kondisi ibu-janin, lapor segera, percepat eskalasi

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Konseling Nifas: Puting susu lecet, Payudara Bengkak dan Mastitis

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian putting susu lecet, payudara bengkak dan mastitis	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan bahwa penyebab dan gejala putting susu lecet, payudara bengkak dan mastitis	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada putting susu lecet, payudara bengkak dan mastitis	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menilai putting susu lecet, payudara bengkak dan mastitis secara klinis dari data yang tersedia	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya ibu pada kasus putting susu lecet, payudara bengkak dan mastitis	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
6	Saya sudah bisa melakukan tindakan tepat yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan konseling yang tepat sesuai kasus	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	
11	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Daftar Pustaka

- Asih, Y dan Risneni. 2016. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Jakarta: Trans Info Media (TIM).
- Can Gürkan, Ö., Abbasoğlu, D., Arslan Özkan, H., & Alioğullari, A. (2022). Cacao Butter as Prophylaxis for Nipple Problems: A Pilot Randomized Controlled Study. *Breastfeeding Medicine*, 17(9), 745–752. <https://doi.org/10.1089/bfm.2021.0349>
- Ebru Sxahin, F. Y., & Duman, and N. B. kkayaci. (2023). *şahin-et-al-2023-effect-of-tea-tree-oil-and-coconut-oil-on-nipple-crack-formation-in-the-early-postpartum-period.pdf*. <https://doi.org/10.1089/bfm.2022.0260>
- Gianni, M. L., Bettinelli, M. E., Manfra, P., Sorrentino, G., Bezze, E., Plevani, L., Cavallaro, G., Raffaelli, G., Crippa, B. L., Colombo, L., Morniroli, D., Liotto, N., Roggero, P., Villamor, E., Marchisio, P., & Mosca, F. (2019). Breastfeeding difficulties and risk for early breastfeeding cessation. *Nutrients*, 11(10), 1–10. <https://doi.org/10.3390/nu11102266>
- Leung, S. S. F. (2016). Breast pain in lactating mothers. *Hong Kong Medical Journal*, 22(4), 341–346. <https://doi.org/10.12809/hkmj154762>
- Santos, K. J. da S., Santana, G. S., Vieira, T. de O., Santos, C. A. de S. T., Giugliani, E. R. J., & Vieira, G. O. (2016). Prevalence and factors associated with cracked nipples in the first month postpartum. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 16(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12884-016-0999-4>
- Susanto, Andina Vita, 2022. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Teori dalam Praktik Kebidanan Profesional. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Walyani, E. S dan Purwoastuti, E. 2015. Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Zakarija-Grkovic, I., & Stewart, F. (2020). Treatments for breast engorgement during lactation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(9). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006946.pub4>
- Zhu, L., Huang, Z., Chen, Y., Li, G., & Liu, L. (2025). Constructing a predictive model for acute mastitis in lactating women based on machine learning. *Scientific Reports*, 15(1), 1–8. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16473-9>

PROFIL PENULIS



Karnilan Lestari Ningsi Sam, S.ST., M.Keb Lahir di Bisanti, 30 Juni 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan tahun 2014 dan DIV Bidan Pendidik tahun 2015 di STIKes Mega Rezky Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014-2015 menjadi Bidan Magang di TPMB Nasjawiyah Darma, tahun 2015-2016 menjadi Bidan Magang di Puskesmas Pembantu Kelurahan Tolo' Selatan, Tahun 2018-2022 menjadi dosen di Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Borneo Medistra pada Prodi DIII Kebidanan mengampu mata kuliah Pengantar Asuhan Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop, pelatihan dan pengembang kurikulum pada program studi DIII Kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nilanlestari99@gmail.com
Motto: "Long Life Education"

PROFIL PENULIS



Bdn. Wiwik Puspita Dewi, S.SiT., M.Keb lahir di Sampit pada 20 Juni 1988. Saya merupakan seorang akademisi kebidanan yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan ilmu kebidanan, pendidikan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Studi DIV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran, Semarang, dan berhasil lulus pada tahun 2010. Dengan semangat pengembangan keilmuan, saya melanjutkan studi Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Perjalanan karier dimulai pada tahun 2011 sebagai tenaga pendidik di AKBID PKU Muhammadiyah Surakarta, yang kemudian berkembang seiring transformasi institusi menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Dalam perjalanannya, saya tidak hanya berperan sebagai dosen, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan pengembangan institusi, termasuk dalam bidang penerimaan mahasiswa baru, pengembangan publikasi ilmiah mahasiswa, serta kegiatan kemahasiswaan. Saat ini, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Pengantar Praktik Kebidanan, Kebidanan dalam Pengembangan IPTEK, KB dan Pelayanan Kontrasepsi, Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas, Public Speaking, Multimedia dalam Pelayanan Kebidanan. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, saya aktif dalam kegiatan penulisan buku ajar, publikasi ilmiah, seminar nasional, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, saya juga kerap menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan kesehatan dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, edukasi stunting, serta peningkatan kapasitas kader kesehatan. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman lapangan yang luas, saya memiliki minat khusus pada bidang: Kesehatan ibu dan anak, Laktasi dan menyusui, Keluarga berencana, Edukasi kesehatan berbasis masyarakat, Pengembangan media pembelajaran kebidanan.

Penulis dapat dihubungi melalui email: wiwikpuspitadewi@umpku.ac.id

Motto: "Growing People, Creating Impact."

PROFIL PENULIS



Bdn. Dini Ria Oktavia, S.ST., M.Keb. Lahir di Malang, 16 Oktober 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Pendidikan Kesehatan-STIKES dr. Soepraoen Malang, dengan memilih Jurusan Kebidanan dan berhasil lulus pada tahun 2010 dengan gelar D3. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan lanjutan D4 ke POLTEKKES Malang Jurusan Kebidanan D4 Klinik pada tahun 2012. Tahun 2020 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis bekerja di Institut Teknologi Kesehatan Malang Widya Cipta Husada dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas, Evidence Based Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, mengikuti seminar. Pengalaman bekerja saya di bidang pelayanan Kesehatan menumbuhkan minat dan rasa ingin menyampaikan informasi dan pengetahuan yang saya miliki kepada seluruh lapisan masyarakat terutama perempuan dalam kesehatan Ibu. Serta untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai penulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: diniria025@gmail.com

Motto: "Sehat untuk Diri, Bermanfaat bagi Negeri"

PROFIL PENULIS



Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes. adalah dosen tetap sekaligus Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Kader Bangsa Palembang. Ia merupakan bidan profesional yang menekuni bidang kesehatan reproduksi dan KB serta pelayanan pasca persalinan. Lahir di Sekayu pada 16 Januari 1988, ia menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar magister kesehatan pada tahun 2012, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2022. Ia aktif mengajar mata kuliah KB dan Pelayanan, Asuhan Kebidanan Nifas, serta Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Fokus risetnya mencakup upaya meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Penulis dapat dihubungi melalui email: ermapuspitasari88@gmail.com.



Bdn. Rini Kristiyanti, SSi.T, M.Keb. Penulis lahir di Pekalongan pada tanggal 4 Agustus 1980. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Program Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Riwayat pendidikan kebidanan penulis diawali dari Akademi Kebidanan Depkes Semarang (Lulus tahun 2001), D4 Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran (Lulus tahun 2003), S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung (Lulus tahun 2014), terakhir menyelesaikan pendidikan profesi bidan di Universitas Asyiah Yogyakarta (Lulus tahun 2024). Saat ini penulis bekerja di sebagai dosen di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP). Aktivitas penulis saat ini selain mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, juga menjalankan tridharma perguruan tinggi lainnya, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimana penulis concern pada topik ibu nifas dan menyusui. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mamabilgis@gmail.com
Motto: "Menjadi versi terbaik dari diri sendiri"

Sinopsis

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi merupakan buku ajar yang membahas asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui secara sistematis, terarah, dan berbasis kompetensi. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami konsep dasar masa nifas dan menyusui, termasuk prinsip asuhan, teori dasar, serta kemampuan mengenali kondisi normal maupun tanda bahaya yang dapat muncul pada ibu nifas dan bayi baru lahir.

Pembahasan dalam buku ini mencakup adaptasi fisiologis dan psikologis ibu nifas, involusi uterus, lokia, perubahan emosi, pemantauan masa nifas terjadwal, kunjungan nifas, parameter klinis, serta deteksi dini risiko dan komplikasi. Selain itu, buku ini juga menguraikan fisiologi laktasi, produksi ASI, refleks menyusui, teknik menyusui yang benar, pelekatan efektif, serta strategi konseling menyusui dalam mengatasi masalah seperti puting lecet, bendungan ASI, dan mastitis. Dengan susunan materi tersebut, pembaca diarahkan untuk memahami kesinambungan asuhan dari pemantauan kondisi ibu dan bayi hingga pemberian dukungan menyusui yang tepat.

Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran seperti Knows How dan Shows How, rubrik penilaian dan kelulusan, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka. Kelengkapan ini menjadikan buku tidak hanya sebagai sumber teori, tetapi juga sebagai panduan pembelajaran aplikatif untuk melatih kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, komunikasi konseling, dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui secara aman, responsif, dan profesional.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi merupakan buku ajar yang membahas asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui secara sistematis, terarah, dan berbasis kompetensi. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami konsep dasar masa nifas dan menyusui, termasuk prinsip asuhan, teori dasar, serta kemampuan mengenali kondisi normal maupun tanda bahaya yang dapat muncul pada ibu nifas dan bayi baru lahir.

Pembahasan dalam buku ini mencakup adaptasi fisiologis dan psikologis ibu nifas, involusi uterus, lokia, perubahan emosi, pemantauan masa nifas terjadwal, kunjungan nifas, parameter klinis, serta deteksi dini risiko dan komplikasi. Selain itu, buku ini juga menguraikan fisiologi laktasi, produksi ASI, refleks menyusui, teknik menyusui yang benar, pelekatan efektif, serta strategi konseling menyusui dalam mengatasi masalah seperti puting lecet, bendungan ASI, dan mastitis. Dengan susunan materi tersebut, pembaca diarahkan untuk memahami kesinambungan asuhan dari pemantauan kondisi ibu dan bayi hingga pemberian dukungan menyusui yang tepat.

Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran seperti Knows How dan Shows How, rubrik penilaian dan kelulusan, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka. Kelengkapan ini menjadikan buku tidak hanya sebagai sumber teori, tetapi juga sebagai panduan pembelajaran aplikatif untuk melatih kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, komunikasi konseling, dan kesiapan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui secara aman, responsif, dan profesional.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-68-8 (PDF)



9

786347

756688